



PEDOMAN TATA NASKAH PT DISA PRIMA MEDIKA RS PRIMA HUSADA

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : disaprimamedika@gmail.com

**PERATURAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA
NOMOR: 1056.5/DPM/I-PDM/DIR/IX/2025**

TENTANG

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS DISA PRIMA MEDIKA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok Rumah Sakit di bidang administrasi, maka perlu penyeragaman pengelolaan tata naskah di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika tentang Pedoman Tata Naskah;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kearsipan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No 17 tahun 2023;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH.**

Pasal 1

Tata Naskah Rumah Sakit Prima Husada merupakan acuan bagi karyawan di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada dalam pengelolaan Tata Naskah.

Jl. Alamat RSPH. – Kota/Kab
Telp : | Email : info.....@rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

Pasal 2

Tata Naskah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas :

a. jenis dan format naskah dinas;

- b. penyusunan naskah dinas;
- c. pengamanan naskah dinas;
- d. kewenangan penandatanganan; dan
- e. pengendalian naskah dinas.

Pasal 3

Tim regulasi bertanggung jawab dalam pengelolaan Tata Naskah Dinas dan pengendalian Naskah Dinas di RS, yang meliputi:

- a. Peninjauan dan persetujuan semua dokumen oleh pihak yang berwenang sebelum diterbitkan;
- b. Proses dan frekuensi peninjauan dokumen serta persetujuan berkelanjutan;
- c. Pengendalian untuk memastikan bahwa hanya dokumen versi terbaru/terkini dan relevan yang tersedia;
- d. Identifikasi adanya perubahan dalam dokumen;
- e. Pemeliharaan identitas dan keterbacaan dokumen;
- f. Proses pengelolaan dokumen yang berasal dari luar rumah sakit;
- g. Penyimpanan dokumen lama yang sudah tidak terpakai (obsolete) setidaknya selama waktu yang ditentukan oleh peraturan perundangan, sekaligus memastikan bahwa dokumen tersebut tidak akan salah gunakan; dan
- h. Identifikasi dan pelacakan semua dokumen yang beredar.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut terkait Pedoman Tata Naskah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 20 September 2025
Direktur PT Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hlm
Peraturan Direktur	2
Daftar Isi	4
LAMPIRAN I PERATURAN DIREKTUR RS PRIMA HUSADA	7
BAB I: PENDAHULUAN	7
1.1.Latar Belakang	7
1.2.Maksud dan Tujuan	7
1.3.Sasaran	8
1.4. <u>Asas</u>	8
1) Asas Efektif dan Efisien	8
2) Asas Pembakuan	8
3) Asas Pertanggungjawaban	8
4) Asas Keterkaitan	8
5) Asas Kecepatan dan Ketepatan	8
6) Asas Keamanan	8
1.5. Pengertian	8
BAB II: RUANG LINGKUP	10
BAB III: JENIS DAN FORMAT NASKAH DINAS	11
3.1.Naskah Dinas Arahkan	11
3.1.1. Naskah Dinas Pengaturan	11
a. Peraturan	11
1) Pedoman	15
2) Panduan	21
b. Instruksi	23
c. Standar Prosedur Operasional (SPO)	25
d. Surat Edaran	30
e. Program kerja	31
f. RBA	36
3.1.2.Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)	40
3.1.3.Naskah Dinas Penugasan	43
a. Surat Tugas	41
b. SPPD	46
c. Surat Perintah	48
3.2 .Naskah Dinas Korespondensi	50
3.2.1.Naskah Dinas Korespondensi Internal	50
a. Nota Dinas	50
b. Disposisi	52
3.2.2.Naskah Dinas Korespondensi Eksternal	53
a. Surat Dinas	53
b. Surat Undangan	55
3.3. Naskah Dinas Khusus	58

3.3.1.Surat Perjanjian	58
3.3.2.Surat Kuasa	61
3.3.3.Berita Acara	62
3.3.4.Surat Keterangan	63
a. Surat Keterangan Tentang Seseorang	64
b. Surat Keterangan Tentang Hal/Peristiwa	62
3.3.5..Surat Pengantar	65
3.3.6.Pengumuman	67
3.4.Laporan	69
3.5.Telaah Staf	101
3.6.Sertifikat & Piagam	103
3.7.Surat Peringatan	104
3.8.Notulen	104
3.9 Naskah Dinas lain	105
a. TOR	105
b. Feasibility Study	111
BAB IV : PENYUSUNAN NASKAH DINAS	113
4.1.Prinsip	113
4.2.Langkah dan Ketentuan Penyusunan	113
4.2.1.Penyusunan Konsep	113
4.2.2.Tembusan	113
4.2.3.Lampiran	113
4.3.Penggunaan Kertas	113
4.4.Tata Cara Penulisan Surat/Dokumen	114
4.5. Registrasi Dan Penomoran Naskah	116
4.5.1.Nomor Surat Keputusan Direktur	116
4.5.2.Nomor Surat Korespondensi dari Direktur	117
4.5.3.Nomor surat dari Kepala Bidang, Komite, Tim	117
4.5.4.Nomor SPO	118
4.6.Kepala/Kop Surat Dinas	122
4.7.Stempel /Cap Surat Dinas	122
4.8.Amplop Surat Dinas	123
BAB V : PEMBERLAKUAN DOKUMEN REGULASI	125
5.1.Pemberlakuan Dokumen Regulasi Internal	125
5.2.Pemberlakuan Dokumen Regulasi Eksternal	125
5.3.Penandaan Dokumen Regulasi Berdasarkan Klasifikasi	125
5.4.Identifikasi Dokumen Regulasi	126
5.5.Pengesahan dan Penerbitan Dokumen	126
5.6.Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas	127
BAB VI : PENGAMANAN NASKAH DINAS	128
6.1.Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas	128
6.2.Hak Akses Naskah Dinas	128
6.3.Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses	128
BAB VII : KEWENANGAN PENANDATANGANAN	129

7.1.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas di Lingkungan RS	129
7.2.Garis Kewenangan dan Penandatanganan	130
7.2.1.Penggunaan Garis Kewenangan	130
7.2.2.Penandatanganan	130
7.2.3.Plt	131
7.2.4.Plh	131
7.2.5.Yang Menjalankan Tugas (Ymt.)	131
 BAB VIII : PENGENDALIAN DOKUMEN REGULASI	 132
8.1.Naskah Dinas	132
8.1.1. Naskah Dinas Masuk	132
8.1.2. Naskah Dinas keluar	133
8.1.3. Naskah Dinas Masuk Internal RSPH	134
8.1.4. Naskah Dinas keluar Internal RSPH	135
8.2. Pembuatan dan Revisi Dokumen	136
8.3. Persetujuan Dokumen	136
8.4. Distribusi dan Pelacakan Dokumen	136
8.5. Revisi dan Pembaharuan Dokumen	138
8.6. Penyimpanan dan Keamanan Dokumen	138
8.7. Pengendalian/Monitoring Dokumen	139
8.8. Pengendalian Dokumen Rahasia	139
8.9. Audit dan Evaluasi Dokumen Regulasi	140
8.10. Review Dokumen Regulasi	142
8.11. Waktu Melaksanakan Review	144
8.12 Penghancuran Dokumen Regulasi	146
BAB IX : DOKUMENTASI	149
BAB X : PENUTUP	150

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR PT DISA PRIMA
MEDIKA
NOMOR 1056.5/DPM/I-PDM/DIR/IX/2025
TENTANG
PEDOMAN TATA NASKAH DINAS

PEDOMAN TATA NASKAH DINAS,

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Pedoman Penyusunan Regulasi di Lingkungan Rumah Sakit Prima Husada diperlukan dalam mendukung tugas pokok dan fungsi Rumah Sakit Prima Husada. Salah satu komponen penting dalam ketatalaksanaan Rumah Sakit Prima Husada adalah Administrasi. Ruang lingkup Administrasi meliputi tata naskah dinas, penamaan lembaga, singkatan dan akronim, kearsipan, dan tata ruang perkantoran.

Pedoman penyusunan Regulasi di Lingkungan Rumah Sakit Prima Husada sebagai salah satu unsur Administrasi mencakup pengaturan tentang Tata Naskah yaitu jenis, penyusunan, penggunaan lambang rumah sakit, logo, stempel, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam naskah dinas.

Keterpaduan Regulasi di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada sangat diperlukan untuk menunjang kelancaran komunikasi tulis instansi dalam penyelenggaraan tugas Rumah Sakit Prima Husada secara efektif dan efisien. Untuk itu diperlukan Pedoman Penyusunan Regulasi di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada sebagai acuan dalam melaksanakan tata naskah dan pengendalian dokumen di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

1.2.1. Maksud

Pedoman Penyusunan Regulasi di Lingkungan Rumah Sakit Prima Husada dimaksudkan sebagai acuan pengelolaan, pembuatan dan pengendalian naskah dinas di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada

1.2.2. Tujuan

Pedoman Penyusunan Regulasi di Lingkungan Rumah Sakit Prima Husada bertujuan menciptakan kelancaran komunikasi tulis intern dan ekstern yang efektif dan efisien dalam rangka mendukung tertib administrasi pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan RS Prima Husada.

1.3. SASARAN

Sasaran Tata Naskah RS Prima Husada, yaitu :

- 1) Tercapainya kesamaan pengertian, bahasa, dan penafsiran dalam penyelenggaraan tata naskah di Lingkungan Rumah Sakit Prima Husada
- 2) Terwujudnya keterpaduan pengelolaan tata naskah dengan unsur lainnya dalam lingkup Administrasi.
- 3) Tercapainya kemudahan dalam pengendalian komunikasi tulis.

- 4) Tercapainya penyelenggaraan tata naskah di Lingkungan Rumah Sakit Prima Husada yang efisien dan efektif.

1.4. ASAS

- 1) Asas Efektif dan Efisien
Penyelenggaraan tata naskah perlu dilakukan secara efektif dan efisien dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, penentuan spesifikasi informasi serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan lugas.
- 2) Asas Pembakuan
Naskah regulasi diproses dan disusun menurut tata cara dan bentuk yang telah baku, termasuk jenis, penyusun naskah, dan tata cara penyelenggaraannya.
- 3) Asas Pertanggungjawaban
Penyelenggaraan tata naskah regulasi dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kearsipan, kewenangan, dan keabsahan.
- 4) Asas Keterkaitan
Kegiatan penyelenggaraan tata naskah regulasi terkait dengan kegiatan Administrasi dan unsur Administrasi lainnya.
- 5) Asas Kecepatan dan Ketepatan
Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi satuan kerja atau satuan organisasi, tata naskah regulasi harus dapat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran, antara lain dilihat dari kejelasan redaksional, kemudahan prosedural, kecepatan penyampaian, dan distribusi.
- 6) Asas Keamanan
Tata naskah regulasi harus aman secara fisik dan substansi (isi) mulai dari penyusunan, klasifikasi, penyampaian kepada yang berhak, pemberkasan, kearsipan dan distribusi.

1.5. PENGERTIAN UMUM

- 1) Administrasi adalah rangkaian kegiatan administrasi yang meliputi tata naskah (tata persuratan, distribusi, formulir, dan media), penamaan lembaga, singkatan, kearsipan, dan tata ruang perkantoran.
- 2) Dokumen regulasi adalah semua ketentuan yang terdokumentasikan baik melalui tulisan tangan atau menggunakan media elektronik, dan ditetapkan untuk digunakan secara resmi sebagai panduan atau acuan kerja. Yang termasuk dokumen regulasi adalah dokumen yang disusun sendiri oleh Rumah Sakit maupun dokumen yang berasal dari luar Rumah Sakit dan telah ditetapkan oleh Direktur RS untuk diberlakukan sebagai acuan di Rumah Sakit (RS).
- 3) Dokumen Regulasi Internal adalah dokumen regulasi yang disusun, ditetapkan oleh Direktur dan diberlakukan di RS.
- 4) Dokumen Regulasi Eksternal adalah dokumen regulasi yang berasal dari luar RS BAKTI KARS dan ditetapkan oleh Direktur untuk digunakan sebagai pendukung kegiatan organisasi, dapat berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, pedoman, panduan, maupun prosedur.
- 5) Format adalah susunan dan bentuk naskah yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambing rumah sakit, logo, dan stempel.
- 6) Kode Klasifikasi Naskah adalah tanda pengenalan isi naskah berdasarkan Sistem Tata Kearsipan Dinamis RS Prima Husada
- 7) Komunikasi Intern adalah tata hubungan dalam penyampaian informasi yang dilakukan antar Instalasi di lingkungan Rumah Sakit Prima Husada, secara vertikal dan horisontal.
- 8) Komunikasi Ekstern adalah tata hubungan penyampaian informasi yang dilakukan oleh Rumah Sakit Prima Husada dengan pihak lain di luar lingkungan Rumah Sakit Prima Husada .

-
- 9) Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak dan kewajiban yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab pada jabatannya.
 - 10) Logo adalah tanda pengenal atau identitas dalam bentuk gambar atau tulisan.
 - 11) Lampiran adalah bahan keterangan yang disertakan pada surat asli sebagai bukti, penguat tambahan terhadap apa yang dinyatakan di dalam surat.
 - 12) Tata Naskah adalah pengaturan jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan, serta pengamanan naskah dinas yang digunakan dalam komunikasi.
 - 13) Lampiran adalah bahan keterangan yang disertakan pada surat asli sebagai bukti, penguat tambahan terhadap apa yang dinyatakan di dalam surat.
 - 14) Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis dan format, teknik penyusunan, kewenangan penandatanganan, serta pengamanan Naskah Dinas yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
 - 15) Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan diterima oleh staf yang berwenang dilingkungan RS dalam rangka penyelenggaraan tugas pengorganisasian dan pelayanan.
 - 16) Dokumen Dikendalikan adalah Naskah Dinas yang berbentuk peraturan perundang-undangan atau dokumen yang berlaku di RS dan perlu diperbaharui secara berkala sesuai dengan kebutuhan karena adanya perubahan yang terjadi selama pemakaiannya. Dokumen Dikendalikan didistribusikan ke bagian, unit atau ke karyawan yang sudah ditentukan sesuai dengan isi dan kegunaannya dalam pelaksanaan kerja.
 - 17) Dokumen Tidak Dikendalikan adalah dokumen yang sejak diterbitkan tidak perlu diperbaharui karena tidak digunakan sebagai acuan kerja. Dokumen ini didistribusikan kepada personil yang sudah ditentukan dan apabila terjadi perubahan/revisi pada dokumen tersebut, maka Tim Regulasi tidak berkewajiban untuk memberikan revisi yang terbaru dan juga untuk menarik dokumen yang lama.
 - 18) Tembusan surat adalah hasil penggandaan dari suatu naskah dinas yang jumlahnya sesuai dengan jumlah pejabat atau satuan kerja yang dipandang perlu untuk mengetahui isi surat dan disebut dalam naskah asli sebagai penerima tembusan.
 - 19) Verbal konsep surat adalah rancangan surat yang ditulis dalam bentuk verbal oleh staf yang terkait dengan substansi isi surat yang kemudian diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang akan menetapkan dan berwenang menandatangani surat tersebut.
 - 20) Dokumen Asli adalah dokumen yang ditandai dengan adanya logo asli, stempel atau tanda tangan asli dari staf yang memberikan persetujuan.
 - 21) Dokumen Terkendali (Controlled Copy) adalah salinan dokumen asli yang masih berlaku dan didistribusikan kepada pengguna dokumen di bagian/unit.
 - 22) Dokumen Tidak Terkendali (Uncontrolled Document) adalah salinan dokumen yang didistribusikan kepada pihak-pihak yang tidak tercantum dalam Daftar Dokumen Internal.
 - 23) Dokumen Tidak Berlaku (obsolete) adalah dokumen yang sudah tidak berlaku.
 - 24) Revisi Dokumen adalah perubahan terhadap suatu dokumen

BAB II

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tata Naskah Dinas RS Prima Husada meliputi pengaturan tentang jenis dan format tata naskah yang berlaku umum dalam pengelolaan manajemen yang berhubungan ke dalam dan ke luar Rumah Sakit. Tata Naskah Dinas dimulai dari jenis dan format, penyusunan Naskah Dinas, prinsip-prinsip yang diterapkan, dan distribusi surat. Tata Naskah Dinas juga termasuk penggunaan logo Rumah Sakit, cap dinas, amplop, dan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh staf Rumah Sakit, staf sementara, dan pelaksana tugas.

Secara umum dapat diringkas lingkup Tata Naskah Dinas RS Prima Husada adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan format Naskah Dinas;
2. Penyusunan Naskah Dinas;
3. Pengamanan Naskah Dinas;
4. Kewenangan penandatanganan; dan
5. Pengendalian Naskah Dinas.

BAB III

JENIS DAN FORMAT NASKAH

Jenis naskah dinas terdiri atas naskah dinas arahan, naskah dinas korespondensi, naskah dinas khusus, laporan, dan telaah staf.

3.1 Naskah Dinas Arahan

Naskah dinas arahan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan pokok atau kebijakan pelaksanaan yang harus dipedomani dan dilaksanakan dalam penyelenggaraan tugas dan kegiatan yang berupa produk hukum yang bersifat penetapan dan penugasan.

3.1.1 Naskah Dinas Pengaturan

Naskah dinas yang bersifat pengaturan terdiri dari Peraturan, Instruksi, Standar Prosedur Operasional, dan Surat Edaran.

a. Peraturan

1) Pengertian

Peraturan Direktur adalah Naskah Dinas yang dikeluarkan oleh Direktur RS BAKTI KARS, yang bersifat mengatur dan mengikat dalam lingkungan Rumah Sakit. Peraturan memuat aturan dalam bentuk pasal demi pasal atau peraturan pelaksanaan yang merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan, yaitu peraturan dalam rangka ketatalaksanaan unit pelayanan, penyelenggaraan tugas pelayanan dan manajerial Rumah Sakit seperti kebijakan, pedoman pengorganisasian, pedoman kerja, pedoman pelayanan/pedoman kerja unit, standar pelayanan, panduan, dan kumpulan standar prosedur operasional.

Tata naskah peraturan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

2) Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Peraturan adalah Direktur Rumah Sakit Prima Husada

3) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Peraturan terdiri dari :

- (1) kop naskah peraturan terdiri atas kop surat RS;
- (2) kata Peraturan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris;
- (3) nomor peraturan, ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris. Penomoran Naskah Peraturan Direktur mengacu kepada penomoran dan kodifikasi surat RS;
- (4) kata penghubung "**TENTANG**", ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris;
- (5) judul peraturan, ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris;
- (6) nama jabatan pejabat yang menetapkan peraturan, ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma.

b) Konsiderans

Bagian konsiderans Peraturan terdiri dari :

- (1) Kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan / tujuan/ kepentingan/ pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Peraturan.
Huruf awal kata menimbang ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) dan diletakkan di bagian kiri;

Penomoran uraian dimulai dari huruf a, dst, untuk uraiannya ditulis rata kanan kiri (*justify*) dengan menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh:

Menimbang:

a. bahwa ...;

b. bahwa ...;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang

- (2) Kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang – undangan sebagai dasar hukum pengeluan Peraturan sebagai dasar kewenangan dan peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan peraturan tersebut.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum adalah peraturan yang tingkatannya sederajat atau lebih tinggi dengan hierarki / urutan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/MENKES/1128/2022 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit, yakni sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Menteri;
- g. Peraturan Daerah Provinsi;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten / Kota;
- i. Keputusan Pengurus Yayasan

Konsiderans *Mengingat* diletakkan di bagian kiri tegak lurus dengan kata *menimbang*.

Penomoran uraian dimulai dari angka 1, dst, untuk uraiannya ditulis rata kanan kiri (*justify*), huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan seterusnya menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;) , apabila konsiderans mengingat lebih dari satu, maka digunakan angka kecil, contoh: 1., 2., dst, dan dipisahkan dengan tanda baca titik koma (;).

c) Diktum

Bagian diktum Peraturan terdiri dari hal berikut :

- (1) Diktum *Memutuskan* ditulis simetris di tengah, seluruhnya dengan huruf kapital dan dicetak tebal, serta diletakkan di tengah margin. Ini merupakan pernyataan keputusan.
- (2) Diktum *Menetapkan* dicantumkan setelah kata *Memutuskan* disejajarkan ke bawah dengan kata *menimbang* dan *mengingat*. Huruf awal kata *Menetapkan* ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)

-
- (3) Nama peraturan sesuai dengan judul seluruhnya ditulis dengan huruf kapital, dicetak tebal, dan diakhiri dengan tanda baca titik.
- d) Batang Tubuh
- Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh Peraturan, diuraikan dalam pasal – pasal, yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik.
- (1) Batang tubuh memuat semua substansi keputusan yang dirumuskan dalam diktum-diktum dengan tata cara penulisan sebagai berikut:
- (2) Pasal-pasal di mana materi kebijakan dituangkan dalam pasal-pasal, contoh;
- Pasal 1 :
- Pasal 2 :
- Pasal 3 :
- Dst
- (3) Bila di dalam pasal terdapat poin tambahan yang lebih dari satu, maka digunakan huruf kecil, contoh: a., b., dst, dan dipisahkan dengan tanda baca titik koma (;) dan poin terakhir diakhiri dengan tanda titik (.).
- e) Kaki
- Merupakan bagian akhir substansi peraturan yang memuat penandatanganan penetapan peraturan, yang terdiri atas nama tempat, tanggal, bulan dan tahun penetapan, nama jabatan dan institusi, tanda tangan staf dan stempel Rumah Sakit, nama lengkap Direktur dicetak dengan huruf proporsional.
- Bagian kaki Peraturan terdiri dari :
- (1) tempat dan tanggal penetapan Peraturan;
- (2) jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- (3) tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan; dan
- (4) nama lengkap pejabat yang menandatangani Peraturan, ditulis dengan huruf kapital (*bold*).
- f) Penandatanganan
- Peraturan Direktur ditandatangani oleh Direktur RS BAKTI KARS yang menjabat pada periode berjalan.
- g) Paraf
- Penulisan paraf ditempatkan di bagian kanan bawah dari nama penanda tangan surat. Pemberi paraf adalah pimpinan level Direksi atau pembuat konsep dan atasan langsung dari pimpinan penyusun dokumen yang akan diberlakukan dengan Peraturan Direktur.
- h) Lampiran peraturan
- Halaman pertama lampiran bagian kanan atas ditulis dalam huruf kapital
Lampiran :(sebutkan nama peraturan Direktur)
Nomor :
Tentang :
 - Halaman terakhir ditandatangani oleh Direktur yang menetapkan peraturan.
- i) Salinan/Tembusan
- Salinan atau tembusan dimaksudkan agar peraturan disampaikan kepada pihak lain, jika ditujukan kepada lebih dari satu unit maka tembusan diberi nomor.
- j) Distribusi

- 4) Hal yang perlu diperhatikan
 - a) naskah yang asli yang diparaf harus disimpan sebagai arsip.
 - b) Penomoran Peraturan mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip.

PT. DISA PRIMA MEDIKA

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka
.....
b. bahwa Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor tentang sudah tidak
sesuai dengan kebutuhan rumah sakit sehingga perlu dilakukan
penyempurnaan dan penyesuaian; **(Jika Regulasi diperbarui)**
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit
Prima Husada tentang

Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor/DPM/I-KEP/DIR/I/20.. tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Rumah Sakit Prima Husada;

3. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor .../DPM/I-KEP/DIR/I/20.. tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN**
TENTANG

Pasal 1

[illegible]

Pasal 2

[illegible]

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini mulai berlaku, Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor tentang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. **(Jika Regulasi diperbarui)**

Pasal 4

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

TTD stemple

Nama terang & stempel

Peraturan Direktur RS Prima Husada digunakan untuk pemberlakuan dokumen regulasi. Bila Direktur Rumah Sakit diganti, pemberlakuan dokumen regulasi tidak perlu diubah. Peraturan/keputusan Direktur perlu diubah apabila ada perubahan dalam isi peraturan tersebut. Regulasi Rumah Sakit yang diberlakukan dengan Peraturan Direktur adalah:

1. Pedoman

Pedoman adalah kumpulan ketentuan dasar atau terdiri dari beberapa hal yang memberi arah bagaimana sesuatu harus dilakukan, dengan demikian merupakan hal pokok yang menjadi dasar untuk menentukan atau melaksanakan kegiatan.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen Pedoman yaitu:

- a. Pedoman terdiri dari Pedoman Pengorganisasian, Pedoman Pelayanan dan Pedoman Kerja. Setiap Unit Kerja menyusun Pedoman Pengorganisasian dan Pedoman Pelayanan/Pedoman Kerja, sedangkan Komite menyusun Pedoman Kerja.
- b. Isi pedoman masuk sebagai lampiran dari Peraturan Direktur RS.
- c. Format baku sistematika pedoman yang digunakan di RS minimal sebagai berikut :

(1) Pedoman Pengorganisasian Unit

Pedoman Pengorganisasian Unit dibuat oleh seluruh Unit Kerja yang ada baik pelayanan maupun non pelayanan dan memuat hal-hal sebagai berikut:

- (a) Peraturan Direktur yang menetapkan Pedoman Pengorganisasian Unit terkait. Peraturan Direktur tersebut memuat gambaran secara umum isi Pedoman yang dijabarkan dalam bentuk bab dan/atau pasal).
- (b) Isi Pedoman yang mengatur ketentuan secara lebih lanjut dimuat sebagai Lampiran Peraturan Direktur, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:
Uraian Jabatan pada bab 5 terdiri dari:
 - 1. Nama Jabatan
 - 2. Bidang
 - 3. Atasan Langsung
 - 4. Atasan Tidak Langsung
 - 5. Pengertian
 - 6. Persyaratan Jabatan
 - 7. Uraian Tugas
 - 8. Tanggung Jawab
 - 9. Wewenang

CONTOH
FORMAT PEDOMAN

	LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA NOMOR 0...../RSPH../I-PER/DIR/I/2025 TENTANG PEDOMAN PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT..... ,
	PEDOMAN PENGORGANISASIAN UNIT..... TAHUN.....
	BAB I . PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang 1.2. Maksud dan Tujuan	
	BAB II. GAMBARAN UMUM RUMAH SAKIT
2.1.	
	BAB III. VISI, MISI, NILAI BUDAYA, MOTO RS
3.1. VISI 3.2. MISI 3.3 VALUE/NILAI/ 7 NILAI BUDI UTAMA 3.4. MOTTO	
	BAB IV. STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJA (BAGAN SOTK)
	BAB V URAIAN JABATAN (contoh tabel KUTW)
	BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA (Hubungan Kerja Bagian/Unit dengan Bagian Lain di lingkungan Rumah Sakit)
	BAB VIII POLA KETENAGAAN DAN KUALIFIKASI PERSONIL (lihat contoh tabel)
	BAB IX PROGRAM ORIENTASI
9.1.Orientasi Umum Rumah Sakit (uraikan mulai materi sd penilaian) 9.2. Orientasi Unit (Orientasi Khusus jabarkan mulai materi, jadwal, penilaian)	
	BAB X PERTEMUAN/RAPAT
	BAB XI PELAPORAN (Laporan Harian, BulanaN, Tahunan)
	BAB XII PENUTUP
	Pas/Mlg/Prob, tanggal –bln- tahun Direktur RSPH Tanda Tangan dan Stempel
	Nama Lengkap

Contoh : bab 8 Pola Ketenagaan dan Kualifikasi Personil

No	Nama Jabatan	JUMLAH SDM				KUALIFIKASI					
						PENDIDIKAN			SERTIFIKASI		
		Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan	Perencanaan	Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan	Standar	Kondisi Saat Ini	Kebutuhan
1.											
2.											
3.											

Contoh Penghitungan Analisa Beban Kerja (masing-masing jabatan)

1. Menetapkan Waktu Kerja Tersedia (WKT)

	Kode	Komponen	Keterangan	Rumus	Jumlah	Satuan
	A	B	C	D	E	F
1	A	Hari Kerja	5 hr kerja/mg	52 (mg)	260	hr/th
2			6 hr kerja/mg	52 (mg)	312	hr/th
3	B	Cuti Pegawai	Peraturan kepegawaian		12	hr/th
4	C	Libur Nasional	Dalam 1 th (Kalender)		14	hr/th
5	D	Mengikuti Pelatihan	Rata-2 dalam 1 th		3	hr/th
6	E	Absen (Sakit, dll)	Rata-2 dalam 1 th		12	hr/th
7	F	Waktu Kerja (dalam 1 minggu)	UU 13 Tahun 2003		40	Jam/mg
8	G	Jam Kerja Efektif (JKE)	Permen PAN-RB 26/2011	70% x 40 Jam	28	Jam/mg
9	WK	Waktu Kerja (dalam 1 hari)	5 hr kerja/mg	E8 / 5	5,6	Jam/hr
10			6 hr kerja/mg	E8 / 6	4,7	Jam/hr
11	WKT	Waktu Kerja Tersedia (hari)	5 hr kerja/mg	E1- (E3+E4+E5+E6)	219	Hari/th
12			6 hr kerja/mg	E2- (E3+E4+E5+E6)	271	Hari/th
13		Waktu Kerja Tersedia (hari)	5 hr kerja/mg	E1- (E3+E4+E5+E6)x E9	1226,4	Jam/th
14			6 hr kerja/mg	E2- (E3+E4+E5+E6)x E10	1273,7	Jam/th
Waktu Kerja Tersedia (WKT).....dibulatkan (dalam jam)					1300	Jam/th
Waktu Kerja Tersedia (WKT).....dibulatkan (dalam menit)					78000	Mnt/th

2. Menetapkan Komponen Beban Kerja Dan Norma Waktu

No.	Jenis Tugas	Komponen Beban Kerja (Kegiatan)	Norma Waktu	Satuan
1	Tugas Pokok			menit per kegiatan/hari/bulan menit/kegiatan menit/hari menit/bulan menit/kegiatan
2	Tugas Penunjang			menit per kegiatan/hari/bulan menit/kegiatan menit/hari menit/bulan menit/kegiatan

3. Menghitung Standar Beban Kerja (SBK)

No.	Jenis Tugas	Kegiatan	Norma Waktu (menit)	Satuan	WKT (menit)	SBK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)/(4)
1	Tugas Pokok					

4. Menghitung Standar Tugas Penunjang (STP) Dan Faktor Tugas Penunjang (FTP)

No.	Jenis Tugas	Kegiatan	Rata-rata Waktu	Satuan	Waktu Keg (mnt/th)	WKT (mnt/th)	FTP %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(6)/(7)x100
2	Tugas Penunjang			menit/ kegiatan			
				menit /kegiatan			
				menit/ bulan			
Faktor Tugas Penunjang (FTP) dalam %							
Standar Tugas Penunjang (STP) = (1/(1-FTP/100))							

5. Penghitungan Kebutuhan SDM

Jenis Tugas	Kegiatan	Capaian (1 th)	SBK	Kebutuhan SDM
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)/(4)
A. Tugas Pokok				
				
JKT = Jumlah Kebutuhan Tenaga Tugas Pokok				
B. Tugas Penunjang	Standar Tugas Penunjang			
Total Kebutuhan SDM			(JKT x STP)	
Pembulatan				

- (2) Pedoman Pelayanan Unit
- Pedoman Pelayanan Unit dibuat oleh unit kerja/instalasi yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien (pelayanan medis, penunjang medis, dan keperawatan) dan memuat hal-hal sebagai berikut:
- (a) Peraturan Direktur yang menetapkan Pedoman Pelayanan Unit terkait. Peraturan Direktur tersebut memuat gambaran secara umum isi Pedoman yang dijabarkan dalam bentuk bab dan/atau pasal).

(b) Isi Pedoman yang mengatur ketentuan secara lebih lanjut dimuat sebagai Lampiran Peraturan Direktur, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR 0...../RSPH../I-PER/DIR/II/2025
TENTANG
PEDOMAN PELAYANAN UNIT.....

,
PEDOMAN PELAYANAN UNIT.....
TAHUN.....

BAB I .
PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Ruang Lingkup Pelayanan
- 1.3. Batasan Operasional

BAB II.
STANDAR KETENAGAAN

- 2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia
- 2.2. Distribusi Ketenagaan
- 2.3. Pengaturan Jaga/Dinas

BAB III.
STANDAR FASILITAS

- 3.1. Denah Ruangan
- 3.2. Standard Fasilitas

BAB IV.
KEMAMPUAN PELAYANAN

BAB V
TATA LAKSANA

BAB VI
LOGISTIK
(fasilitas , alkes, aldok, dll)

BAB VII
KESELAMATAN PASIEN

BAB VIII
KESELAMATAN KERJA

BAB IX
PENGENDALIAN MUTU

BAB X
PENUTUP

Pas/Mlg/Prob, tanggal –bln- tahun
Direktur RSPH

Tanda Tangan dan Stempel

Nama Lengkap

- (3) Pedoman Kerja Unit
- Pedoman Kerja Unit dibuat oleh seluruh unit kerja yang tidak melayani pasien secara langsung (non pelayanan) dan memuat hal-hal sebagai berikut:
- (a) Peraturan Direktur yang menetapkan Pedoman Kerja terkait. Peraturan Direktur tersebut memuat gambaran secara umum isi Pedoman yang dijabarkan dalam bentuk bab dan/atau pasal).
 - (b) Isi Pedoman yang mengatur ketentuan secara lebih lanjut dimuat sebagai Lampiran Peraturan Direktur, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

	LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA NOMOR 0...../RSPH..I-PER/DIR/I/2025 TENTANG PEDOMAN KERJA UNIT.....
	, PEDOMAN KERJA UNIT..... TAHUN.....
	BAB I . PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang 1.2. Ruang Lingkup Pelayanan 1.3. Batasan Operasional	
	BAB II. STANDAR KETENAGAAN
2.1. Kualifikasi Sumber Daya Manusia 2.2. Distribusi Ketenagaan 2.3. Pengaturan Jaga/Dinas	
	BAB III. STANDAR FASILITAS
3.1. Denah Ruangan 3.2. Standard Fasilitas	
	BAB IV. KEMAMPUAN PELAYANAN
	BAB V TATA LAKSANA
	BAB VI LOGISTIK (fasilitas , alkes, aldok, dll)
	BAB VII KESELAMATAN PASIEN
	BAB VIII KESELAMATAN KERJA
	BAB IX PENGENDALIAN MUTU
	BAB X PENUTUP
	Pas/Mlg/Prob, tanggal –bln- tahun Direktur RSPH
	Tanda Tangan dan Stempel
	Nama Lengkap

- (4) Pedoman Kerja Komite/Tim
- Pedoman Kerja Komite/Tim dibuat oleh seluruh Komite/Tim yang ada di lingkungan RS BAKTI KARS dan memuat hal-hal sebagai berikut:
- (a) Peraturan Direktur yang menetapkan Pedoman Kerja Komite/Tim terkait. Peraturan Direktur tersebut memuat gambaran secara umum isi Pedoman yang dijabarkan dalam bentuk bab dan/atau pasal).
 - (b) Isi Pedoman yang mengatur ketentuan secara lebih lanjut dimuat sebagai Lampiran Peraturan Direktur, dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA
NOMOR 0...../RSPH../I-PER/DIR/II/2025
TENTANG
PEDOMAN KERJA KOMITE/TIM.....

,
PEDOMAN KERJA KOMITE/TIM.....
TAHUN.....

BAB I .
PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang
1.2. Tujuan Pedoman

BAB II.
PENGORGANISASIAN

2.1. Struktur organisasi
2.2 Uraian Tugas dan Wewenang
2.3 Tata Hubungan Kerja

BAB III.
ISI TENTANG PEDOMAN
(d disesuaikan dengan pemenuhan standar peraturan dan/atau akreditasi)

BAB IV.
MONEV DAN PELAPORAN

BAB V
TATA LAKSANA

BAB VI
PENUTUP

Pas/Mlg/Prob, tanggal –bln- tahun
Direktur RSPH

Tanda Tangan dan Stempel

Nama Lengkap

2. Panduan

Panduan adalah tuntunan/petunjuk dalam melakukan kegiatan dan hanya meliputi satu kegiatan. Pada kondisi tertentu, agar panduan dapat diimplementasikan dengan baik dan benar, diperlukan pengaturan lebih lanjut melalui SPO. Akan tetapi tidak semua Panduan harus diatur lebih lanjut dengan SPO. Panduan dibuat oleh seluruh unit kerja yang ada baik pelayanan maupun non pelayanan yang membutuhkan dan memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Peraturan Direktur yang menetapkan Panduan. Peraturan Direktur tersebut memuat gambaran secara umum isi Panduan yang dijabarkan dalam bentuk bab dan/atau pasal).
- b. Isi Panduan yang mengatur ketentuan secara lebih lanjut dimuat sebagai Lampiran Peraturan Direktur, dengan sistematika penyusunan minimal sebagai berikut:

	LAMPIRAN PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA NOMOR 0...../RSPH../I-PER/DIR/II/2025 TENTANG PANDUAN..... ,
	PANDUAN TAHUN.....
	BAB I . PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang 1.2. Tujuan Panduan	BAB II. RUANG LINGKUP
2.1	BAB III. TATA LAKSANA ((penamaan dan jumlah bab dapat diuraikan sesuai dengan ketentuan yang perlu diatur pelaksanaannya)
KEPUSTAKAAN	BAB IV. DOKUMENTASI
	Pas/Mlg/Prob, tanggal –bln- tahun Direktur RSPH Tanda Tangan dan Stempel Nama Lengkap

Sistematika Pedoman/Panduan di atas tidak baku dan tergantung dari materi/isi Pedoman/Panduan terkait. Ketentuan isi Pedoman/Panduan tersebut merupakan standar minimal yang harus dimuat dan dapat disesuaikan dengan hal-hal yang dipersyaratkan oleh regulasi yang diminta dalam elemen penilaian akreditasi

3. Instruksi

a. Pengertian

Instruksi adalah naskah dinas yang memuat perintah berupa petunjuk / arahan tentang pelaksanaan suatu kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.

b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani instruksi adalah Direktur Rumah Sakit.

c. Susunan

1) Kepala Bagian kepala instruksi terdiri dari :

- a) kop naskah instruksi;
- b) kata instruksi dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf kapital *bold* secara simetris;
- c) nomor instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital *bold* secara simetris;
- d) kata tentang, yang ditulis dengan huruf kapital *bold* secara simetris;
- e) judul instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital *bold* secara simetris; dan
- f) nama jabatan pejabat yang menetapkan instruksi, yang ditulis dengan huruf kapital *bold*, dan diakhiri dengan tanda baca koma secara simetris.

2) Batang Tubuh bagian batang tubuh instruksi memuat substansi instruksi.

3) Kaki bagian kaki instruksi ditempatkan di sebelah kiri bawah, yang terdiri dari:

- a) tempat (kota sesuai dengan alamat Rumah Sakit) dan tanggal penetapan instruksi;
- b) nama jabatan pejabat yang menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri dengan tanda koma;
- c) tanda tangan pejabat yang menetapkan instruksi;
- d) nama lengkap pejabat yang menandatangani, yang ditulis dengan huruf awal kapital *bold*.

4) Distribusi dan Tembusan Instruksi disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian instruksi diikuti dengan tindakan pengendalian.

5) Hal yang perlu diperhatikan

- a) Instruksi merupakan pelaksanaan kebijakan pokok sehingga instruksi harus merujuk pada suatu peraturan perundang – undangan.
- b) Wewenang penetapan dan penandatanganan instruksi tidak dapat dilimpahkan kepada pejabat lain.

4. Standar Prosedur Operasional (SPO)

1. Pengertian

Standar Prosedur Operasional adalah suatu perangkat instruksi / langkah – langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu.

2. Tujuan Penyusunan SPO

Agar berbagai proses kerja rutin terlaksana dengan efisien, efektif, konsisten / seragam dan aman, dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan melalui pemenuhan standar yang berlaku.

3. Manfaat SPO

- 1) Memenuhi persyaratan standar pelayanan RS/Akreditasi RS.
- 2) Mendokumentasi langkah-langkah kegiatan.
- 3) Memastikan staf RS memahami bagaimana melaksanakan pekerjaannya.

4. Susunan

1) Kotak *Heading* terdiri dari :

- a) *Heading* dan kotaknya dicetak pada setiap halaman. Pada halaman pertama kotak *heading* harus lengkap, untuk halaman-halaman berikutnya kotak *heading* dapat hanya memuat : Kotak Nama RS, Judul SPO, No. Dokumen, No. Revisi dan Halaman.
- b) Kotak RS diberi nama RS dan logo RS
- c) Judul SPO: diberi judul/nama SPO sesuai proses kerjanya.
- d) No. Dokumen: diisi sesuai dengan ketentuan penomoran yang berlaku di RS yang bersangkutan, yang dibuat sistematis agar ada keseragaman.
- e) No. Revisi: diisi dengan status revisi, dianjurkan menggunakan huruf. Contoh: dokumen baru diberi huruf A, dokumen revisi pertama diberi huruf B dan seterusnya. Tetapi dapat juga dengan angka, misalnya untuk dokumen baru dapat diberi nomor 0, sedangkan dokumen revisi pertama diberi nomor 1, dan seterusnya.
- f) Halaman: diisi nomor halaman dengan mencantumkan juga total halaman untuk SPO tersebut. Misalnya: halaman pertama: 1/5, halaman kedua: 2/5, halaman terakhir : 5/5.
- g) SPO diberi penamaan sesuai ketentuan (istilah) yang digunakan RS, misalnya: SPO, prosedur, prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan, prosedur kerja dan sebagainya.
- h) Tanggal terbit: diberi tanggal sesuai tanggal terbitnya atau tanggal diberlakukannya SPO tersebut.
- i) Ditetapkan Direktur: diberi tanda tangan Direktur dan nama jelasnya.

2) Isi SPO

- a) Pengertian: berisi penjelasan dan atau definisi tentang istilah yang mungkin sulit dipahami atau menyebabkan salah pengertian.
- b) Tujuan: berisi tujuan pelaksanaan SPO secara spesifik. Kata kunci : " Sebagai acuan penerapan langkah-langkah untuk"
- c) Kebijakan: berisi kebijakan Direktur/Pimpinan RS yang menjadi dasar dibuatnya SPO tsb. Dicantumkan intisari kebijakan yang mendasari SPO tersebut, tidak perlu dituliskan nomor peraturan/keputusan dari kebijakan terkait.
- d) Prosedur: bagian ini merupakan bagian utama yang menguraikan langkah-langkah kegiatan untuk menyelesaikan proses kerja tertentu menggunakan kalimat perintah.
- e) Unit terkait: berisi unit-unit yang terkait dan atau prosedur terkait dalam proses kerja tersebut.

5. Tata Cara Pengelolaan SPO

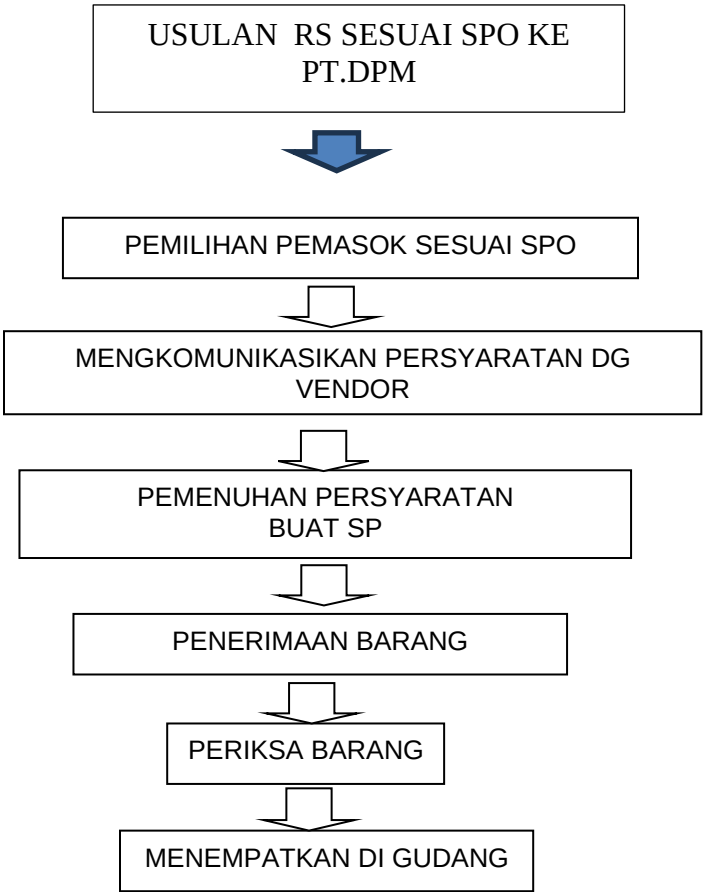
- 1) RS agar menetapkan siapa yang mengelola SPO
- 2) Pengelola SPO harus mempunyai arsip seluruh SPO RS

-
- 3) Pengelola SPO agar membuat tata cara penyusunan, penomoran, distribusi, penarikan, penyimpanan, evaluasi dan revisi SPO
6. Tata Cara Penyusunan SPO
 - 1) Hal-hal yang perlu diingat :
 - a) Siapa yang harus menulis atau menyusun SPO.
 - b) Bagaimana merencanakan dan mengembangkan SPO.
 - c) Bagaimana SPO dapat dikenali.
 - d) Bagaimana memperkenalkan SPO kepada pelaksana dan unit terkait.
 - e) Bagaimana pengendalian SPO nya (nomor, revisi dan distribusi).
 7. Syarat Penyusunan SPO
 - 1) Identifikasi kebutuhan yakni mengidentifikasi apakah kegiatan yang dilakukan saat ini sudah ada SPO belum dan bila sudah ada agar diidentifikasi, apakah SPO masih efektif atau tidak.
 - 2) Perlu ditekankan bahwa SPO harus ditulis oleh mereka yang melakukan pekerjaan tersebut atau oleh unit kerja tersebut, Tim atau panitia yang ditunjuk oleh Direktur/Pimpinan RS hanya untuk menganggap dan mengoreksi SPO tersebut. Hal tersebut sangatlah penting, karena komitmen terhadap pelaksanaan SPO hanya diperoleh dengan adanya keterlibatan pesonel/unit kerja dalam penyusunan SPO.
 - 3) SPO harus merupakan *flow charting* dari suatu kegiatan. Pelaksana atau unit kerja agar mencatat proses kegiatan dan membuat alurnya kemudian Tim/Panitia diminta memberikan tanggapan.
 - 4) Didalam SPO harus dapat dikenali dengan jelas siapa melakukan apa, dimana, kapan dan mengapa.
 - 5) SPO jangan menggunakan kalimat majemuk. Subyek, predikat dan obyek harus jelas.
 - 6) SPO harus menggunakan kalimat perintah/instruksi dengan bahasa yang dikenal pemakai.
 - 7) SPO harus jelas ringkas dan mudah dilaksanakan. Untuk SPO pelayanan pasien maka harus memperhatikan aspek keselamatan, keamanan dan kenyamanan pasien. Untuk SPO profesi harus mengacu kepada standar profesi, standar pelayanan, mengikuti perkembangan IPTEK dan memperhatikan aspek keselamatan pasien.
 8. Proses Penyusunan SPO
 - 1) SPO disusun dengan menggunakan format SPO sesuai dengan lampiran Surat Edaran Direktur Pelayanan Medik Spesialistik nomer YM.00.02.2.2.837 tertanggal 1 Juni 2001, perihal bentuk SPO.
 - 2) Penyusunan SPO dapat dikelola oleh suatu Tim/panitia dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a) Pelaksana atau unit kerja menyusun SPO dengan melibatkan unit terkait.
 - b) SPO yang telah disusun oleh pelaksana atau unit kerja disampaikan ke Tim/Panitia SPO.
 - c) Fungsi Tim/Panitia SPO :
 - Memberikan tanggapan, mengoreksi dan memperbaiki terhadap SPO yang telah disusun oleh pelaksana/unit kerja baik dari segi bahasa maupun penulisan.
 - Sebagai koordinator dari SPO yang sudah dibuat oleh masing-masing unit kerja sehingga tidak terjadi duplikasi SPO/tumpang tindih SPO antar unit.
 - Melakukan cek ulang terhadap SPO-SPO yang akan di tanda tanagni oleh Drektur RS
 - 3) Penyusunan SPO dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan SPO. Untuk SPO pelayanan dan SPO admnistrasi, untuk melakukan identifikasi kebutuhan SPO bisa

dilakukan dengan menggambarkan proses bisnis di unit kerja tersebut atau alur kegiatan dari kerja yang dilakukan di unit tersebut. Sedangkan untuk SPO Profesi identifikasi kebutuhan dilakukan dengan mengetahui pola penyakit yang sering ditangani di unit kerja tersebut. Dari identifikasi kebutuhan SPO maka di suatu unit kerja dapat diketahui berapa banyak dan macam SPO yang harus dibuat/disusun. Untuk melakukan identifikasi kebutuhan SPO dapat pula dilakukan dengan memperhatikan elemen penilaian pada standar akreditasi rumah sakit, minimal SPO-SPO apa saja yang harus ada. SPO yang dipersyaratkan di elemen penilaian adalah SPO minimal yang harus ada di rumah sakit. Sedangkan identifikasi SPO dengan menggambarkan terlebih dahulu proses bisnis di unit kerja adalah seluruh SPO secara lengkap yang harus ada di unit kerja tersebut.

- 4) Mengingat SPO merupakan flow charting dari proses kegiatan maka untuk memperoleh pengertian yang jelas bagi subyek, penulisan SPO adalah dimulai dengan membuat flow chart dari kegiatan yang dilaksanakan. Caranya adalah membuat diagram kotak sederhana yang menggambarkan langkah penting dari seluruh proses.

Contoh : diagram kotak untuk pembelian bahan yang digunakan di RS.

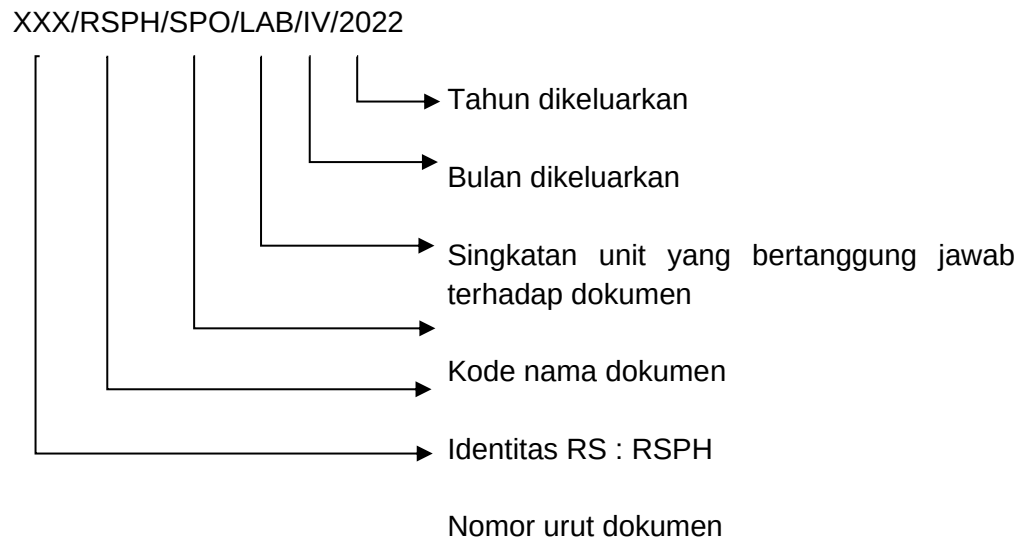


Setelah dibuatkan diagram kotak maka diuraikan kegiatan di masing-masing kotak dan dibuat alurnya.

- a) Semua SPO harus ditandatangani oleh Direktur/Pimpinan RS.
- b) Untuk SPO pelayanan dan SPO administrasi, sebagian memerlukan uji coba
- c) Agar SPO dapat dikenali oleh pelaksana maka perlu dilakukan sosialisasi SPO-SPO tersebut dan bila SPO tersebut rumit maka untuk melaksanakan SPO tersebut perlu dilakukan pelatihan.

- 5) Yang mempengaruhi keberhasilan penyusunan SPO
- a) Ada komitmen dari pimpinan RS yang terlihat dengan adanya dukungan fasilitas dan sumber daya lainnya
 - b) Ada fasilitator/petugas yang mempunyai kemampuan dan kemauan untuk menyusun SPO, jadi ada aspek pekerjaan dan aspek psikologis.
 - c) Ada target waktu yaitu ada target dan jadwal yang disusun dan disepakati
 - d) Adanya pemantauan dan pelaporan kemajuan penyusunan SPO

9. Tata Cara Penomoran SPO



10. Tata Cara Penyimpanan SPO

- 1) Yang dimaksud penyimpanan adalah bagaimana SPO tersebut disimpan.
- 2) SPO asli agar disimpan di sekretariat Tim akreditasi RS atau Bagian sekretariat RS, sesuai dengan kebijakan yang berlaku di RS tersebut tentang tata cara pengarsipan dokumen. Penyimpanan SPO yang asli harus rapi, sesuai metode pengarsipan dokumen sehingga mudah dicari kembali bila diperlukan.
- 3) SPO foto copy ada di simpan di masing-masing unit kerja dimana SPO tersebut dipergunakan. Bila SPO tersebut sudah tidak berlaku lagi atau tidak dipergunakan lagi karena di revisi atau hal lainnya maka unit kerja wajib mengembalikan SPO yang sudah tidak berlaku tersebut ke sekretariat Tim Akreditasi/Bagian sekretariat RS sehingga di unit kerja hanya ada SPO yang masih berlaku saja. Sekretariat Tim Akreditasi/Bagian sekretariat RS dapat memusnahkan foto copy SPO yang tidak berlaku tersebut, namun untuk SPO nya yang asli agar tetap disimpan, dengan lama penyimpanan sesuai ketentuan dalam pengarsipan dokumen di RS.
- 4) SPO di unit kerja harus diletakkan ditempat yang mudah dilihat, mudah diambil dan mudah dibaca oleh pelaksana.
- 5) Bagi rumah sakit yang sudah menggunakan *e-file* maka penyimpanan SPO sebagai berikut :
 - a) Setiap SPO harus di print-out dan disimpan sebagai SPO asli .
 - b) SPO di unit kerja tidak perlu *hard copy*, SPO bisa dilihat di intranet di rumah sakit. Namun untuk SPO penanganan gawat darurat tetap harus dibuatkan *hard copy*nya.

11. Tata Cara Pendistribusian SPO

- 1) Yang dimaksud dengan distribusi adalah kegiatan atau usaha menyampaikan SPO kepada unit kerja dan atau pelaksana yang memerlukan SPO tersebut agar dapat sebagai panduan dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan ini dilakukan oleh Tim Akreditasi RS atau Bagian sekretariat RS sesuai kebijakan RS dalam pengendaian dokumen.
- 2) Distribusi harus memakai buku ekspedisi dan atau formulir tanda terima.
- 3) Distribusi SPO bisa hanya untuk unit kerja tertentu tetapi bisa juga untuk seluruh unit kerja. Hal tersebut tergantung jenis SPO tersebut, bila SPO tersebut merupakan acuan untuk melakukan kegiatan di semua unit kerja maka SPO ddistribusikan ke semua unit kerja. Namun bila SPO tersebut hanya untuk unit kerja tertentu maka distribusi SPO hanya untuk unit kerja tertentu tersebut dan unit terkait yang tertulis di SPO tersebut.
- 4) Bagi rumah sakit yang sudah menggunakan *e-file* maka distribusi SPO bisa melalui intranet dan diatur kewenangan otorisasi di setiap unit kerja, sehingga unit kerja dapat mengetahui batas kewenangan dalam membuka SPO

12. Tata Cara Evaluasi

- 1) Evaluasi SPO dilaksanakan sesuai kebutuhan dan maksimal 3 tahun sekali.
- 2) Evaluasi SPO dilakukan oleh masing-masing unit kerja yang dipimpin oleh kepala unit kerja.
- 3) Hasil evaluasi : SPO masih tetap bisa dipergunakan atau SPO perlu diperbaiki/direvisi. Perbaikan/revisi bisa isi SPO sebagaian atau seluruhnya.
 - a) Perbaikan/revisi perlu dilakukan bila :
 1. Alur di SPO sudah tidak sesuai dengan keadaan yang ada
 2. Adanya perkembangan IPTEK
 3. Adanya perubahan organisasi atau kebijakan/regulasi baru.
 4. Adanya perubahan fasilitas
 - b) Pergantian direktur RS, bila SPO memang masih sesuai/dipergunakan maka tidak perlu di revisi. Revisi ke dari tahun ke tahun dituliskan ke...

CONTOH
FORMAT SPO

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	JUDUL SPO		
	No. Dokumen	No. Revisi 00	Halaman 29 / 3
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit :	Ditetapkan Oleh : Direktur RS Prima Husada TTD stempel Nama dan gelar	
Pengertian	pengertian yang sudah aplikatif		
Tujuan	tujuan dibuatnya spo		
Kebijakan	kalimat-kalimat yang ada dalam perdir-pedoman atau panduan (no perdir tentang)		

Prosedur	Menggunakan kalimat perintah/instruksi dengan bahasa yang dikenal pemakai, buat sesuai pelaksanaan sehari-hari dengan mengingat pasien safety. 1. 2. ...dst a. b. c....dst
Unit Terkait	1. 2. 3. dst

5. Surat Edaran

- a. Pengertian surat edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan Kewenangan untuk menetapkan dan menandatangani surat edaran adalah Direktur Rumah Sakit.
- c. Susunan
 - 1) Kepala Bagian kepala surat edaran terdiri dari:
 - a) kop naskah surat edaran;
 - b) kata Yth., yang diikuti oleh nama pejabat yang dikirim surat edaran;
 - c) tulisan surat edaran, yang dicantumkan di bawah kop surat, ditulis dengan huruf kapital *bold* serta nomor surat edaran di bawahnya secara simetris;
 - d) kata tentang, yang dicantumkan di bawah nomor surat edaran ditulis dengan huruf kapital *bold* secara simetris;
 - e) rumusan judul surat edaran, yang ditulis dengan huruf kapital *bold* secara simetris di bawah kata tentang.
 - 2) Batang Tubuh bagian batang tubuh surat edaran terdiri dari latar belakang tentang perlunya dibuat surat edaran, maksud dan tujuan dibuatnya surat edaran, ruang lingkup diberlakukannya surat edaran, peraturan perundang – undangan atau naskah dinas lain yang menjadi dasar pembuatan surat edaran, isi edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak, penutup.
 - 3) Kaki bagian kaki surat edaran ditempatkan di sebelah kanan yang terdiri dari:
 - a) tempat dan tanggal penetapan;
 - b) nama jabatan pejabat penanda tangan, yang ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
 - c) tanda tangan pejabat penanda tangan;
 - d) nama lengkap pejabat penanda tangan, ditulis dengan huruf kapital; dan
 - e) stempel.
 - 4) Distribusi Surat edaran disampaikan kepada pihak yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat edaran diikuti dengan tindakan pengendalian.

PT. DISA PRIMA MEDIKA

3. dan seterusnya

MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

(Inti edaran mengenai hal tertentu yang dianggap mendesak),

Direktur Rumah Sakit Prima Husada.

Nama terang & stempel

b) Materi proker yang terdiri dari kegiatan yang akan dilaksanakan, factor yang mempengaruhinya, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, monitoring evaluasi, dan hal yang perlu dilaporkan sesuai dengan kegiatannya,

-
- c) Simpulan dan saran, atau monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan masukan dan pertimbangan; dan
 - d) Penutup, yang merupakan akhir proker, memuat harapan / permintaan arahan / ucapan terima kasih.
- 3) Kaki
- a) Bagian kaki proker terdiri dari:
 - b) Tempat dan tanggal pembuatan proker
 - c) Nama jabatan pejabat pembuat proker , ditulis dengan huruf awal kapital; Tanda tangan; dan Nama lengkap, ditulis dengan huruf awal capital dan setiap unsurnya
 - d) Apabila ada pejabat di atasnya maka tanda tangan berada di kiri pembuat proker dan pejabat yang lebih tinggi dikiri bawah dan pejabat yang paling tinggi ada di tengah
- d. Hal yang harus diperhatikan
- 1) Proker bisa dilengkapi dengan lampiran disesuaikan dengan kebutuhan
Untuk proker hasil rapat atau pertemuan (Notulen) dapat berupa:
 - 1) Undangan
 - 2) Materi (bentuk PPT atau word atau fisik)
 - 3) Notulen
 - 4) Daftar hadir peserta
 - 5) Dokumentasi (Foto)Lampiran ini disesuaikan dengan kebutuhan sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan , dst
 - 2) Pembuatan Proker tahunan pembuatan Tabel dan grafik sesuai kebutuhan dan apa yang ingin ditonjolkan dalam proker tersebut dan rencana tindak lanjut, sesuai kebutuhan dimana trend yang ingin ditonjolkan dalam laporan

PROGRAM KERJA UNIT/INSTALASI.....
RSPH..... TAHUN

BAB I.
PENDAHULUAN

- 1.1. Umum/Latar belakang (bentuk narasi berisi masalah yang ditemukan di tahun sebelumnya)
1.2. Dasar Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II
GAMBARAN UMUM

- 2.1 Visi
2.2. Misi
2.3. Motto
2.4. 7 Nilai Budi Utama
2.5. SOTK
2.6. Masalah (bisa langsung angka)

BAB III.
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

No	KEGIATAN POKOK	RINCIAN KEGIATAN
----	----------------	------------------

3.2. Sasaran

(LANDSCAPE)

NO	RINCIAN KEGIATAN	TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	JENIS	TARGET/ STANDARD	INDIKATOR KEBERHASILAN	KET
----	------------------	--------	------------------	-------	------------------	------------------------	-----

3.3. Cara Melaksanakan Kegiatan

(LANDSCAPE)

NO	RINCIAN KEGIATAN	CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN	METODE	MEDIA	JADWAL	BUKTI PELAKSANAAN	KET
----	------------------	----------------------------	--------	-------	--------	-------------------	-----

3.4. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2026

NO	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA
			12/ 23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

3.5. Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RSPH yang telah disetujui oleh PT.DPM (sudah melalui Raker)
Contoh : Perhitungan biaya berdasarkan pemakaian rata -rata perbulan adalah sebagai berikut:
Untuk level RS bisa di kelompokkan sekup besar/rekapan per program, rinciannya di lampiran

NO	BAHAN	RATA /BL	KEBUTUHAN 1 TH		HARGA SATUAN	TOTAL Rp
1.	HANDWASH YURI/ 3,7 LITER	17	204	Jurigen	129.000	26.316.000

Contoh kebutuhan biaya pengembangan SDMRSPHTahun 202....

NO	Kegiatan /rincian kegiatan	Internal eksternal	Jumlah (satuan)	HARGA SATUAN	TOTAL Rp
1					

Dan seterusnya

BAB IV.
MONITORING DAN EVALUASI

(berisi monitoring dalam bentuk observasi/supervise/ sedangkan evaluasi dalam bentuk rapat/pertemuan evaluasi program dapat dilaksanakan sesuai pedoman rapat bulanan, triwulan dan semester atau insidental)

Monitoring dengan melakukan Supervisi

Contoh Form Supervisi dengan menggunakan Ceklist Supervisi (V)

Unit :
Tanggal Supervisi :
Nama yang disupervisi: diisi dengan nama PJ nya atau staf yang disupervisi

NO	Aspek yang di supervisi	Standard /Target	Sesuai Standar (V)	Tidak sesuai standar (V)	Catatan temuan

Tgl supervisi
TTD Supervisor
(nama terang)

Rekapitulasi hasil Supervisi selama 1 bulan dilakukan evaluasi dalam bentuk rapat unit /Rapat

Sesuai standard dan tidak sesuai standard diisi jumlah hasil rekapian sebulan dan diberi (%)

NO	Aspek yang di supervisi	Standard /Target	Jml Sesuai Standar	Jumlah Tidak sesuai standar	Akar Masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC

TTD Supervisor
(nama terang)

**BAB V.
PENCATATAN DAN PELAPORAN**

- 5.1. Pencatatan : Semua kegiatan akan dicatat dalam bentuk Softkopi dan jika perlu akan dicetak
- 5.2. Laporan :
- 1) laporan bulanan
laporan dibuat setiap bulan untuk unit laporan wajib diserahkan antara tanggal 3-5 setiap bulan untuk Manajemen dibuat antara tanggal 5 -7 setiap bulan.
 - 2) laporan Triwulan dibuat dengan merekap hasil kinerja selama 3 bulan
 - 3) Laporan Tahunan : dibuat 1 tahun sekali pada akhir tahun dan diserahkan pada awal januari tahun berikutnya

**BAB VI
PENUTUP**

Mengetahui
Kepala Instalasi/Pejabat diatasnya...

Nama lengkap

Pas/Mlg/Prob tanggal –bln- tahun
Kepala Ruang/Instalasi

Nama Lengkap

1) Keterangan cara melaksanakan kegiatan BISA LEBIH DARI 1

- a) Membuat TOR
- b) Mengisi usulan di SIM
- c) Membuat Studi kelayakan
- d) Membuat telaah staf
- e) Pemberitahuan ke secretariat
- f) Disetujui Direktur
- g) Surat Tugas
- h) Disetujui PT.DPM
- i) UMANDOK, dan lain lain

2) Metode sesuai kegiatan

- a) Rapat Komite, R.Tim, R.Unit, Rapat koordinasi (rakor), Rapat kerja
- b) Audit (contoh : Audit Kepatuhan Terhadap PPI ke Ruangan atau Instalasi)
- c) Sosialisasi
- d) Surveilans
- e) Pelatihan/Diklat
- f) Simulasi
- g) Roll-Play
- h) Demonstrasi
- i) FGD
- j) Disko (diskusi kelompok)
- k) Praktek
- l) Supervisi
- m) Observasi
- n) Wawancara dan lain-lain

3) Bukti pelaksanaan Kegiatan:

- a) UMANDOK,
- b) SAK
- c) Sertifikat
- d) laporan
- e) hasil supervisi
- f) Temuan/masalah

4) Contoh :

- a) Kegiatan PKRS ,
- b) rincian kegiatan : KIE kelompok
- c) Tujuan : meningkatkan pengetahuan pasien dan keluarga pasien tentang
.....
- d) Metode : talkshow
- e) Media : IG
- f) Cara melaksanakan kegiatan : membuat TOR, persetujuan Direktur PT.DPM ,
pelaksanaan (Umandok)
- g) Target : 2x/minggu per unit atau perorang atau per-tim atau target 8x sebulan
(pilih sesuai yg anda tentukan)
- h) Jadwal : tiap selasan dan kamis
- i) Indikator keberhasilan : edukasi kelompok terlaksana $\geq 8x/bln$ + ada
- j) Bukti : Umandok
Dan seterusnya

Catatan :

Supervisi dilakukan di Tingkat Karu kebawah

Audit dilakukan di tingkat RS : dilakukan oleh / Ketua/PJ Komite/Tim/PJ program

No	Tanggal Kegiatan	Kegiatan	Jumlah Yang dipantau/ observasi	Jml-Hasil temuan		Akar masalah	RTL	PIC	ket
				SS	TS				
1									

7. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA)

- a. Pengertian
- b. Wewenang Penandatanganan
- c. Susunan
 - 1) Sampul/Cover
Bagian Sampul TOR terdiri dari :
 - a) Judul TOR/KAK ditulis dengan huruf kapital (bold) yang diletakan secara simetris;
 - b) Bulan dan tahun, ditulis dengan huruf kapital (bold) secara simetris;
 - c) Logo Rumah Sakit Prima Husada
 - d) Nama, alamat, nomor telepon, email dan website Rumah Sakit Prima Husada ;
 - 2) Isi TOR/KAK
Bagian Isi TOR terdiri dari :
 - a) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum atau latar belakang, maksud, dan tujuan, dasar hukum serta ruang lingkup dan sistematikaTOR , disesuaikan dengan kegiatan yang akan dibuat;
 - b) Materi TOR, yang terdiri dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, tanggal, tempat, waktu,, kepanitiaan, peserta, Nara sumber, schedule/susunan acara, media yang digunakan, metode yang dipilih, kebutuhan anggaran, rencana rapat panitia penyelenggara sebelum pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, monitoring evaluasi, dan hal lain yang perlu direncanakan sesuai dengan kegiatannya,
 - c) Monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk kegiatan berikutnya agar lebih baik, bisa dibuat notulen proses pelaksanaan kegiatan, bisa pre, post tes, atau yang lain sesuai kebutuhan.
 - d) Penutup, yang merupakan akhir TOR, memuat harapan / permintaan arahan / ucapan terima kasih.
 - 3) Kaki
 - a) Bagian kaki TOR terdiri dari:
 - 1. Tempat dan tanggal pembuatan
 - 2. Nama jabatan pejabat pembuat, ditulis dengan huruf awal kapital;
 - 3. Tanda tangan; dan
 - 4. Nama lengkap, ditulis dengan huruf awal capital dan setiap unsurnya
 - 5. Tanda tangan pejabat yang lebih tinggi berada di kiri tanda tangan pembuat TOR dan pejabat yang paling tinggi (Direktur) ada di tengah bawah sendiri

Untuk Tingkat unit, instalasi, PJ.program, Tim, Komite pembuatan RBA dilakukan di bulan Nopember dan menggunakan Format sebagai berikut : RBA : masing-masing program atau unit mengusulkan dan direkap di level RS Contoh : Rencana Bisnis Anggaran Untuk Program Pkrs Di RsphTahun 2026

Tabel ... Rincian Kegiatan Program PKRS Tahun 2026 (RP.....)

NO	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Tujuan	Cara Melaksanakan kegiatan	Sasaran	Target Pelaksanaan	Indikator Keberhas ilan	Jum lah	Jeni s	Satu an Rp	Usulan Anggara n
----	----------	------------------	--------	----------------------------	---------	--------------------	-------------------------	---------	--------	------------	------------------

								(satuan)			
1	Gathering	Perusahaan	Evaluasi kunjungan	Buat Tor Pengajuan ke PT.DPM Siapkan Umandok	Perusahaan (100 Perusahaan)	1x/th	Umandok	100 org	mamin	50.000	5.000.000
		FKTP	Menjalin kemitraan, evaluasi rujukan, pembinaan jejaring	Tor Pengajuan ke PT.DPM Siapkan Umandok	FKTP (50 org)	1x/th	Umandok	50 org	Mamin	30.000	1.500.000
2	Pembinaan komunitas	DOLINA	Pembinaan jejaring	Buat Tor Pengajuan ke PT.DPM							
		F-KUL		Buat Tor Pengajuan ke PT.DPM Siapkan Umandok							
		Senam Hamil	Meningkatkan persalinan di RSPH	Buat Tor Pengajuan ke PT.DPM Siapkan Umandok							
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM PKRS SEBESAR											6.500.000

Mengetahui
Program/Sekretaris
Direktur RSPH.....

(.nama lengkap)
(.nama lengkap)

diverifikasi oleh
Ketua Tim PKRS

(.nama lengkap)

Pelaksana

Contoh : RENCANA BISNIS ANGGARAN UNTUK PROGRAM PPI DI RSPHTAHUN 2025

Tabel 6.2 Rincian Kegiatan Program PPI Tahun 2025
(RP.....)

NO	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Tujuan	Cara Melaksanakan kegiatan	Sasaran	Target Pelaksanaan	Indikator Keberhasilan	Jumlah (satuan)	Jenis	Satuan Harga Rp	Total Usulan Anggaran
1	Dekontaminasi-Spilkit	Pengadaan BMHP Spilkit	Memenuhi kebutuhan pembersihan permukaan	Usulan pengadaan melalui Gudang IFRS	RS	1 Th	Tersedianya BMHP-Spilkit	12 botol	CLOREXIDINE	70.000	84.000.000
2	Kebersihan Tangan	Pengadaan BMHP cuci tangan	Memenuhi kebutuhan BMHP cuci tangan	Usulan pengadaan melalui Gudang IFRS berdasarkan data rata-rata tahun lalu	RS	1 Th		948 Botol (500 ML)	HANDRUB	35.000	33.180.000

Mengetahui
Direktur RSPH.....

(.nama lengkap)
(.nama lengkap)

diverifikasi oleh
Ketua Komite PPI

(.nama lengkap)

Pelaksana Program
IPCP

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PT.DPM
TAHUN**

BAB I . PENDAHULUAN

- 1.1. Umum/Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum penyusunan RBA
- 1.3. Maksud dan Tujuan disusunnya RBA

BAB II GAMBARAN UMUM

- 2.1. Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Motto
- 2.4. 7 Nilai Budi Utama
- 2.5. SOTK

BAB III. KINERJA TAHUN BERJALAN

- 3.1 .Capaian Kinerja Pendapatan
- 3.2. Capaian kinerja Belanja Operasional
- 3.3. Laporan Arus Kas
- 3.4. Analisis Posisi bersaing
- 3.5. Kendala yang dihadapi RSPH

BAB IV. RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2024

- 4.1. RBA - Target Pendapatan
- 4.2. RBA - Perkiraan pembiayaan
- 4.3. RBA Ambang Batas

BAB V. RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

- 5.1. Ringkasan Pendapatan
- 5.2. Ringkasan Belanja
- 5.3. Ringkasan Pembiayaan

BAB VI. PENUTUP

- 6.1. kesimpulan
- 6.2. Saran

Pasuruan, tanggal –bln- tahun
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Tanda Tangan

Nama Lengkap

CONTOH
RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

**RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TAHUN**

**BAB I .
PENDAHULUAN**

- 1.1. Umum/Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum penyusunan RBA
- 1.3. Maksud dan Tujuan disusunnya RBA

**BAB II
GAMBARAN UMUM**

- 2.1 Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Motto
- 2.4. 7 Nilai Budi Utama
- 2.5. SOTK

**BAB III.
KINERJA TAHUN BERJALAN**

- 3.1 .Capaian Kinerja Pendapatan
- 3.2. Capaian kinerja Belanja Operasional
- 3.3. Laporan Arus Kas
- 3.4. Analisis Posisi bersaing
- 3.5. Kendala yang dihadapi RSPH

**BAB IV.
RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN 2024**

- 4.1. RBA - Target Pendapatan
- 4.2. RBA - Perkiraan pembiayaan
- 4.3. RBA Ambang Batas

**BAB V.
RINGKASAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

- 5.1. Ringkasan Pendapatan
- 5.2. Ringkasan Belanja
- 5.3. Ringkasan Pembiayaan

**BAB VI.
PENUTUP**

- 6.1. kesimpulan
- 6.2. Saran

....., tanggal –bln- tahun
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Tanda Tangan

Nama Lengkap dan

3.1.2 Naskah Dinas Penetapan (Keputusan)

a. Pengertian

Keputusan adalah naskah dinas yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersidat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, digunakan untuk :

- 1) Menetapkan / mengubah status kepegawaian / personal / keanggotaan / material / peristiwa;
- 2) Menetapkan / mengubah / membubarkan suatu kepanitiaan / tim; dan
- 3) Menetapkan pelimpahan wewenang.

b. Wewenang Penetapan dan Penandatanganan

Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani Keputusan adalah Direktur Rumah Sakit Prima Husada

c. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala Keputusan terdiri dari :

- a) kop naskah peraturan;
- b) kata keputusan dan nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris;
- c) nomor Keputusan, ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris;
- d) kata penghubung tentang, ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris;
- e) judul Keputusan, ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris;
- f) nama jabatan pejabat yang menetapkan Keputusan, ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris dan diakhiri dengan tanda baca koma.

2) Konsiderans

Bagian konsiderans Keputusan terdiri dari :

- a) Kata Menimbang, yaitu konsiderans yang memuat alasan / tujuan/ kepentingan/ pertimbangan tentang perlu ditetapkannya Keputusan. Huruf awal kata menimbang ditulis dengan huruf kapital diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) dan diletakkan di bagian kiri; Penomoran uraian dimulai dari huruf a, dst, untuk uraiannya ditulis rata kanan kiri (*justify*) dengan menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
- b) Kata Mengingat, yaitu konsiderans yang memuat peraturan perundang – undangan sebagai dasar hukum pengeluaran Keputusan. Konsiderans *Mengingat* diletakkan di bagian kiri tegak lurus dengan kata *menimbang*. Penomoran uraian dimulai dari angka 1, dst, untuk uraiannya ditulis rata kanan kiri (*justify*), huruf awal ditulis dengan huruf kapital dan seterusnya menggunakan huruf kecil dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

3) Diktum

Bagian diktum Keputusan terdiri dari hal berikut :

- a) diktum dimulai dengan kata memutuskan ditulis dengan huruf kapital (*bold*) diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) dan diikuti dengan kata menetapkan di tepi kiri dengan huruf awal kapital.
- b) substansi kebijakan yang ditetapkan dicantumkan setelah kata menetapkan, yang ditulis dengan huruf awal kapital.
- c) untuk keperluan tertentu, Keputusan dapat dilengkapi dengan salinan dan petikan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

4) Batang Tubuh

Sistematika dan cara penulisan bagian batang tubuh Keputusan sama dengan ketentuan dalam penyusunan Peraturan, tetapi substansi Keputusan diuraikan bukan dalam pasal – pasal, melainkan diawali dengan bilangan bertingkat / diktum Kesatu, Kedua, Ketiga, dan seterusnya ditulis dengan huruf kapital.

5) Kaki

Bagian kaki Keputusan terdiri dari :

- a) tempat dan tanggal penetapan Keputusan;
- b) jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf capital dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- c) tanda tangan pejabat yang menetapkan Keputusan; dan
- d) nama lengkap pejabat yang menandatangani Keputusan, ditulis dengan huruf kapital (*bold*).

d. Distribusi

Keputusan yang telah ditetapkan didistribusikan kepada yang berkepentingan.

e. Hal yang perlu diperhatikan

- 1) naskah yang asli yang diparaf harus disimpan sebagai arsip.
- 2) Penomoran Keputusan mengacu pada Pola Klasifikasi Arsip.

3.1.3 Naskah Dinas Penugasan

a. Surat Tugas

1. Pengertian

Surat Tugas adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diberi tugas, yang memuat apa yang harus dilakukan.

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat Tugas dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya. Apabila atasan yang berwenang menandatangani lokasinya terletak jauh, maka dapat menggunakan atas nama pejabat tersebut.

Contoh :

a.n. Direktur Rumah Sakit Prima Husada,
Kabid Penunjang

Nama terang & stempel

3. Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Surat Tugas terdiri dari :

- (1) kop surat tugas;
- (2) kata Surat Tugas, ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris;
- (3) nomor, berada di bawah tulisan Surat Tugas ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Tugas terdiri dari hal berikut :

- (1) alinea pembuka meliputi pertimbangan dan / atau dasar : pertimbangan memuat alasan ditetapkannya surat tugas;
- (2) isi dari memberikan tugas kepada diletakkan menjorok ke dalam (Nama dan Jabatan pegawai yang mendapatkan tugas);

c) Kaki

Bagian kaki Surat Tugas terdiri dari :

- (1) tempat, tanggal, bulan dan Tahun Surat Tugas;
- (2) nama jabatan pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- (3) tanda tangan pejabat yang menugasi;
- (4) nama lengkap pejabat dan gelar yang menandatangani Surat Tugas, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya;
- (5) stempel.

4. Distribusi dan Tembusan

- a) Surat tugas diberikan kepada yang mendapat tugas.
- b) Arsip surat tugas di simpan di Bagian SDM.

5. Hal yang perlu diperhatikan

- a) Jika tugas merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, jabatan, dan keterangan;
- b) Surat Tugas tidak berlaku setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan;
- c) Penomoran Surat Tugas mengacu pada Tata Naskah di Rumah Sakit Prima Husada.

CONTOH
FORMAT SURAT TUGAS



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

SURAT TUGAS
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
Jabatan :

Dengan ini menugaskan kepada :

Nama :
Jabatan :
Hadir dalam acara :
Hari, tanggal :
Waktu :
Tempat :

Hasil dan materi dari acara tersebut dilaporkan dalam bentuk *Soft Copy/file* (Nota Dinas) dan diserahkan ke Bagian SDM selambat-lambatnya 2 hari setelah pelaksanaan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, harap melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab.

.....
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

Nama terang & stempel

Jl. Alamat RSPH. – Kota/Kab
Telp : | Email : info.....@rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

CONTOH
FORMAT SURAT TUGAS UNTUK BERKELOMPOK



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

SURAT TUGAS
NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :

Jabatan :

Dengan ini menugaskan kepada :

Nama : (jika yang ditugaskan lebih dari 1 maka dibuat lampiran)

Jabatan :

Hadir dalam acara :

Hari, tanggal :

Waktu :

Tempat :

Hasil dan materi dari acara tersebut dilaporkan dalam bentuk *Soft Copy/file & Hard Copy* (Nota Dinas) dan diserahkan ke Bagian SDM selambat-lambatnya 2 hari setelah pelaksanaan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat, untuk dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.

.....
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Nama terang & stempel

FORMAT LAMPIRAN SURAT TUGAS UNTUK BERKELOMPOK



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

LAMPIRAN SURAT TUGAS
NOMOR
TANGGAL

DAFTAR PEJABAT / PEGAWAI YANG DITUGASKAN

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN

.....
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

Nama terang & stempel

b. Surat Perintah (SP-Perjalanan Dinas/SPPD)

1) Pengertian

Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas sebagai alat pemberitahuan yang ditujukan kepada pejabat tertentu untuk melaksanakan Perjalanan Dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Surat Perintah Perjalanan Dinas dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri dari :

- (1) kop Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- (2) kata Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), ditulis dengan huruf capital (*bold*) secara simetris;
- (3) nomor, berada di bawah tulisan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Perintah Perjalanan Dinas terdiri dari:

- (1) data Karyawan, memuat nama dan jabatan karyawan;
- (2) kegiatan, memuat acara, hari / tanggal, waktu dan tempat acara;
- (3) catatan, memuat catatan selama perjalanan;
- (4) tempat, tanggal, bulan dan tahun perjalanan dinas;
- (5) nama jabatan, ditulis dengan huruf awal capital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- (6) tanda tangan pejabat;
- (7) nama lengkap dan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- (8) stempel.

c) Kaki

Bagian kaki Surat Perintah Perjalanan Dinas diisi oleh Pimpinan di tempat tujuan, memuat :

- (1) tanggal dan jam datang;
- (2) tanggal dan jam kembali;
- (3) catatan;
- (4) tempat, tanggal, bulan dan tahun perjalanan dinas;
- (5) nama jabatan, ditulis dengan huruf awal capital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- (6) tanda tangan pejabat;
- (7) nama lengkap dan pejabat yang menandatangani Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- (8) stempel.

4) Distribusi

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas diberikan kepada yang mendapat tugas untuk diserahkan ke penyelenggara kegiatan; dan
- b) Arsip Surat Perintah Perjalanan Dinas disimpan di Bagian SDM.

5) Hal yang perlu diperhatikan

- a) Surat Perintah Perjalanan Dinas tidak berlaku setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan;
- b) Penomoran Perintah Perjalanan Dinas mengacu pada Tata Naskah di Rumah Sakit Prima Husada.

CONTOH
FORMAT SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (SPPD)
NOMOR

Direktur RS Prima Husada memberikan ijin kepada :

A. DATA KARYAWAN

Nama : Nama (Jabatan)

B. KEGIATAN

Acara :
Hari, tanggal :
Waktu :
Tempat :

C. CATATAN : Biaya perjalanan dinas harus dipertanggungjawabkan selambat –
lambatnya 1 hari setelah tiba dari perjalanan dinas.

.....
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

Nama terang & stempel

D. DIISI OLEH PIMPINAN DITEMPAT TUJUAN :

Tanggal Datang : Jam :
Tanggal Kembali : Jam :
Catatan :
.....

Malang,

.....
Nama terang & stempel

c. Surat Perintah

1) Pengertian

Surat Perintah adalah naskah dinas yang dibuat oleh atasan atau pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat lain yang diperintah, yang memuat apa yang harus dilakukan. Surat perintah digunakan untuk penunjukkan sebagai pejabat pelaksana tugas maupun pelaksana harian.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan surat Perintah dibuat dan ditandatangani oleh atasan atau pejabat yang berwenang berdasarkan lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3) Susunan

a) Kepala Bagian kepala Surat Perintah terdiri dari:

- (1) Kop surat dinas,
- (2) Kata surat perintah, ditulis dengan huruf kapital secara simetris; dan
- (3) Nomor, berada di bawah tulisan Surat Perintah.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Surat Perintah terdiri dari hal berikut:

- (1) Konsiderans meliputi pertimbangan dan/atau dasar: pertimbangan memuat alasan ditetapkannya Surat Perintah; dasar memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya Surat Perintah tersebut.
- (2) Diktum dimulai dengan kata memberi perintah, ditulis dengan huruf kapital dicantumkan secara simetris, diikuti kata kepada di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas. Di bawah kata kepada ditulis kata untuk disertai tugas-tugas yang harus dilaksanakan.

c) Kaki

Bagian kaki Surat Perintah terdiri dari:

- (1) Tanggal Surat Perintah;
- (2) Nama jabatan pejabat yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya, dan diakhiri dengan tanda baca koma;
- (3) Tanda tangan pejabat yang menugasi;
- (4) Nama lengkap pejabat yang menandatangani Surat Perintah, ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap awal unsurnya dan
- (5) cap dinas.

4) Distribusi dan Tembusan

- a) Surat perintah disampaikan kepada yang mendapat tugas
- b) Tembusan surat perintah disampaikan kepada unit kerja/satuan kerja yang terkait

5) Hal yang Perlu diperhatikan

- a) Bagian konsiderans memuat pertimbangan atau dasar
- b) Surat Perintah tidak berlaku lagi setelah tugas yang termuat selesai dilaksanakan

CONTOH
FORMAT SURAT PERINTAH



**SURAT PERINTAH
NOMOR**

Menimbang : a. bahwa
 : b. bahwa

Dasar : 1.
 : 2.

Memberi Perintah

Kepada : 1.
 : 2.
 : 3.
 : 4.

Untuk : 1.
 : 2.
 : 3.

.....,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

Nama Pejabat Yang Berwenang

Jl. Alamat RSPH. – Kota/Kab
Telp : | Email : info.....@rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

3.2 Naskah Dinas Korespondensi

3.2.1 Naskah Dinas Korespondensi Internal

a. Nota Dinas

1) Pengertian

Nota Dinas adalah naskah dinas *intern* yang dibuat oleh pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian kepada pejabat lain.

Nota Dinas memuat hal yang bersifat rutin, berupa catatan ringkas yang tidak memerlukan penjelasan yang panjang, dan dapat langsung dijawab dengan disposisi oleh pejabat yang dituju.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

3) Nota Dinas dibuat oleh :

- a) antar pejabat struktural secara horizontal dalam lingkungan internal unit kerja;
- b) pejabat secara vertikal dalam satu lingkungan unit kerja atau sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.

4) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Nota Dinas terdiri dari :

- (1) Kop surat dinas;
- (2) Kata nota dinas, ditulis dengan huruf kapital (*bold*) secara simetris;
- (3) Kata Dari, ditulis dengan huruf awal kapital;
- (4) Kata Perihal, ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- (5) Kata Tanggal, ditulis dengan huruf awal kapital;

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh Nota Dinas terdiri dari alinea pembuka, isi dan penutup yang singkat, padat, dan jelas.

c) Kaki

Bagian kaki Nota Dinas terdiri dari tanda tangan, nama pejabat dengan gelar Huruf pertama capital (*bold*) dan tembusan (jika perlu).

5) Hal yang perlu diperhatikan

- a) Nota Dinas tidak dibubuhi stempel.
- b) Tembusan Nota Dinas berlaku di lingkungan internal unit kerja.
- c) Nota Dinas bisa digunakan sebagai hasil dari Dinas Luar.
- d) Pemonoram Nota Dinas mengacu pada Tata Naskah di Rumah Sakit Prima Husada.

- b. Disposisi
- Disposisi adalah petunjuk tertulis mengenai tindak lanjut / tanggapan terhadap surat masuk, ditulis secara jelas pada lembar disposisi, tidak pada suratnya. Ketika didisposisikan, lembar disposisi merupakan satu kesatuan dengan surat masuk.

CONTOH
FORMAT DISPOSISI



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

LEMBAR DISPOSISI

Surat dari : PT.DISA PRIMA MEDIKA	Diterima Tanggal : 18 April 2022
No. Surat : 188/DPMI-PB/DIR/IV/2021	No. Agenda : RSPHS/SM-E/2204/021
Tanggal Surat : 18 April 2022	Sifat : ☐ Sangat Segera ☐ Segera ☐ Penting/Rahasia ☒ Biasa
Perihal : Peringatan Hari Kartini menggunakan kebaya dan batik	
Diteruskan :	Dengan hormat harap : ☐ Tanggapan dan saran ☐ Koordinasi / Konfirmasikan ☐ Proses lebih lanjut ☐ Tidak di proses
Catatan Direktur:	Direktur RS Prima Husada Sukorejo dr. Sadi Hariono, MMRS
Sekretariat/ Kabid/ Kabag ...	Sekretariat/ Kabid/ Kabag ... (.....) Tgl.
Tindak Lanjut Yang Bersangkutan	 (.....) Tgl.

3.2.2 Naskah Dinas Korespondensi Eksternal

a. Surat Dinas

Jenis naskah dinas korespondensi eksternal hanya ada satu macam, yaitu Surat Dinas.

1) Pengertian

Surat Dinas adalah naskah dinas pelaksanaan tugas pejabat dalam menyampaikan informasi kedinasan berupa pemberitahuan, pernyataan, permintaan, penyampaian naskah dinas atau barang, atau kedinasan lainnya kepada pihak lain di luar unit kerja dan di luar RS Prima Husada.

2) Wewenang Penandatanganan

Surat Dinas ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.

3) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala Surat Dinas terdiri dari :

- (1) Kop surat dinas;
- (2) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun pembuatan surat diletakkan di sebelah kanan atas;
- (3) Nomor, Lampiran, Perihal, yang diketik dengan huruf awal kapital di sebelah kiri;
- (4) Kata Kepada Yth., yang ditulis dibawah perihal, diikuti dengan nama atau jabatan yang dikirim surat; dan
- (5) Alamat surat, ditulis di bawah Kepada Yth.

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat dinas terdiri dari alinea pembuka, isi, dan penutup.

c) Kaki

Bagian kaki surat dinas ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari :

- (1) Nama jabatan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- (2) Tanda tangan pejabat;
- (3) Nama lengkap, pejabat, ditulis dengan huruf awal kapital (*bold*);
- (4) Stempel, yang digunakan sesuai dengan ketentuan; dan
- (5) Tembusan, yang memuat nama jabatan pejabat penerima (jika ada).

d) Distribusi

Surat dinas disampaikan kepada penerima yang berhak secara cepat dan tepat waktu, lengkap serta aman. Pendistribusian surat dinas diikuti dengan tindakan pengendalian.

e) Hal yang perlu diperhatikan

- (1) Kop surat hanya digunakan pada halaman pertama surat dinas;
- (2) Jika surat dinas disertai lampiran, pada kolom lampiran dicantumkan jumlahnya;
- (3) Lampiran tidak dicantumkan apabila tidak ada lampiran yang menyertainya; dan
- (4) Hal berisi pokok surat sesingkat mungkin ditulis dengan huruf awal kapital pada setiap unsurnya, tanpa diakhiri tanda baca.
- (5) Penomoran Surat Dinas mengacu pada Tata Naskah RS Prima Husada.

CONTOH
FORMAT SURAT DINAS



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

.....,

Nomor :
Lampiran : 1 lembar / bendel
Perihal :

Kepada Yth.
.....
Alamat
.....

Dengan hormat,

..... (Alinea Pembuka)
.....
.....
.....

..... (Alinea Isi)
.....
.....
.....

..... (Alinea Penutup)
.....
.....
.....

Hormat kami,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

Nama terang & stempel

.....

Jl. Alamat RSPH. – Kota/Kab
Telp : | Email : info.....@rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

b. Surat Undangan

1) Pengertian

Surat undangan adalah surat yang memuat undangan kepada pejabat/pegawai pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara tertentu, misalnya rapat, pertemuan, dan sebagainya.

2) Kewenangan

Surat Undangan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawabnya.

3) Susunan

a) Kepala

Bagian kepala surat undangan terdiri dari :

- (1) Kop surat undangan terdiri atas logo Rumah Sakit Prima Husada;
- (2) Tempat dan tanggal pembuatan undangan ditulis di sebelah kanan;
- (3) Nomor, lampiran, dan perihal ditulis di sebelah kiri undangan;
- (4) Kata Kepada Yth., ditulis di bawah Perihal, yang diikuti dengan nama atau jabatan, dan alamat yang dikirim surat undangan (jika diperlukan).

b) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh surat undangan terdiri dari :

- (1) Alinea pembuka;
- (2) Isi Undangan, yang meliputi hari/ tanggal, pukul, tempat, dan acara;
- (3) Alinea penutup.

c) Kaki

Bagian kaki surat undangan terdiri dari nama jabatan ditulis dengan huruf awal kapital, tanda tangan, dan nama pejabat ditulis dengan huruf awal capital.

d) Hal yang perlu diperhatikan

- (1) Format surat undangan sama dengan format surat dinas, bedanya adalah bahwa pihak yang dikirim surat undangan dapat ditulis pada lampiran.
- (2) Surat undangan untuk keperluan tertentu dapat berbentuk kartu
- (3) Penomoran Surat Dinas mengacu Tata Naskah RS Prima Husada

CONTOH
FORMAT KARTU UNDANGAN



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Undangan

Dengan hormat,
Dengan ini kami mohon kehadirannya besok pada :
Hari / Tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara :
Demikian undangan kami dengan harapan berkenan hadir.
Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

.....
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Nama terang & stempel

Konfirmasi hadir selambatnya :
Hari, Tanggal, Tahun
Contact person :
Undangan berlaku 1 orang

Jl. Alamat RSPH. – Kota/Kab
Telp : | Email : info.....@rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

CONTOH
FORMAT SURAT UNDANGAN



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Mlg/Pas/Prob, tg l- BI - th

Nomor :
Lampiran :
Perihal :

Kepada Yth.
1.
2.
3. dan seterusnya

Dengan hormat,

(Alinea Pembuka dan Alinea Isi)

pada :

Hari / tanggal :
Pukul :
Tempat :
Acara :

(Alinea Penutup)

Hormat kami,
Direktur Rumah Sakit Prima Husada.

Nama terang & stempel

FORMAT LAMPIRAN SURAT UNDANGAN



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Lampiran :
Nomor :
Tanggal :

DAFTAR KARYAWAN YANG DIUNDANG

NO	UNIT	NAMA
1		
2		
3		
dst		

Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Nama terang & stempel

57

3.3 Naskah Dinas Khusus

3.3.1. Surat Perjanjian

a. Pengertian

Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama tentang sesuatu hal yang mengikat antara kedua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.

b. Wewenang dan penandatanganan

Perjanjian yang dilakukan antar instansi, dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya.

c. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala terdiri dari :

- a) Logo kedua Lembaga
- b) Tulisan “Perjanjian Kerjasama” yang ditempatkan ditengah lembar naskah dinas dan ditulis dengan huruf kapital dan bold ;
- c) Judul perjanjian;
- d) Nomor.

2) Batang Tubuh

Batang tubuh perjanjian kerja sama memuat materi perjanjian, antara lain tujuan kerjasama, ruang lingkup kerjasama, pelaksanaan kegiatan, hak dan kewajiban, kendali mutu pembiayaan, cara bayar, penyelesaian perselisihan, penutup dan hal – hal lain yang menjadi kesepakatan para pihak. Huruf untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menggunakan huruf capital

3) Kaki

Bagian kaki perjanjian kerja sama terdiri dari nama penanda tangan para pihak yang mengadakan perjanjian dan para saksi (jika dipandang perlu), dibubuhi materai dan stempel sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

4) Hal yang harus diperhatikan

Penomoran Perjanjian kerja sama mengacu pada Tata Naskah RS Prima Husada

CONTOH
FORMAT SURAT PERJANJIAN

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA

NOMOR :

DENGAN

NOMOR :

TENTANG

.....

Pada hari ini,, tanggal,, bulan
tahun, yang bertanda tangan di bawah ini :

1.

: Selaku yang beralamatkan di
.....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK PERTAMA**”, dan

2.

: Selaku yang beralamatkan di
.....
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Selanjutnya disebut sebagai “**PIHAK KEDUA**”.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara Bersama – sama selanjutnya disebut sebagai
PARA PIHAK, dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal – hal sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA adalah

2. PIHAK KEDUA adalah bermaksud untuk
..... Kepada PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA bermaksud menunjuk PIHAK KEDUA untuk

Maka, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat
untuk menuangkan kesepakatan – kesepakatan mereka dalam Perjanjian ini dengan syarat
– syarat dan ketentuan – ketentuan minimal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

.....

.....

.....

PARAF I	PARAF II

Jl. Alamat RSPH. – Kota/Kab

Telp : | Email : info.....@rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

59

Pasal 2 RUANG LINGKUP	
Pasal 3 PELAKSANAAN KEGIATAN	
Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN	
Pasal 5 KENDALI MUTU	
PASAL 6 PEMBIAYAAN DAN CARA BAYAR	
Pasal 7 KORESPONDENSI/CONTACT PERSON	
Pasal 8 JANGKA WAKTU KERJASAMA	
Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN	
Pasal 10 KEADAAN MEMAKSA (<i>FORCE MAJURE</i>)	
Pasal 11 PENUTUP	
PIHAK KEDUA Nama Instansi Pihak II Nama Jabatan, <i>Tanda Tangan dan stempel</i> Nama Pejabat	PIHAK PERTAMA Nama Instansi Pihak I Nama Jabatan, <i>Tanda Tangan dan stempel</i> Nama Pejabat

3.3.2. Surat Kuasa

- a. Pengertian
Surat Kuasa adalah naskah dinas yang berisi pemberian wewenang kepada badan hukum / kelompok orang / perseorangan atau pihak lain dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- b. Susunan
 - 1) Kepala
Bagian Kepala Surat Kuasa terdiri dari :
 - a) Kop surat kuasa terdiri atas logo dan alamat Rumah Sakit Prima Husada;
 - b) Judul surat kuasa ditulis dengan huruf kapital (*bold*) dan diletakan secara simetris; dan
 - c) Nomor surat kuasa.
 - 2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh Surat Kuasa memuat materi yang dikuasakan.
 - 3) Kaki
Bagian kaki Surat Kuasa memuat tempat, tanggal, bulan, dan tahun pembuatan serta nama dan tanda tangan para pihak yang berkepentingan, dan dibubuhi materai sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
 - 4) Hal yang harus diperhatikan
Penomoran Surat Kuasa mengacu Tata Naskah Rumah Sakit Prima Husada .

CONTOH
FORMAT SURAT KUASA



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

SURAT KUASA

NOMOR

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Memberikan kuasa kepada :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Untuk

Surat kuasa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penerima Kuasa,

Tanda tangan

Nama Lengkap

.....,

Pemberi Kuasa,

Tanda tangan

Nama Lengkap

3.3.3. Berita Acara

a. Pengertian

Berita acara adalah naskah dinas yang berisi tentang pernyataan bahwa memang telah terjadi suatu proses pelaksanaan kegiatan pada waktu tertentu yang harus ditandatangani oleh para pihak dan para saksi. Berita acara dapat disertai lampiran.

b. Susunan

1) Kepala

Bagian Kepala berita acara terdiri dari :

- a) Kop berita acara terdiri atas logo dan alamat Rumah Sakit Prima Husada;
- b) Judul berita acara ditulis dengan huruf kapital (*bold*) dan diletakkan secara simetris; dan
- c) Nomor berita acara ditulis dengan huruf kapital dan diletakkan secara simetris.

2) Batang Tubuh

Bagian batang tubuh berita acara terdiri dari :

- a) Tulisan hari, tanggal, dan tahun, serta nama dan jabatan para pihak yang membuat berita acara;
- b) Substansi berita acara;
- c) Keterangan yang menyebutkan adanya lampiran; dan
- d) Penutup yang menerangkan bahwa berita acara ini dibuat dengan sebenar – benarnya.

3) Kaki

Bagian kaki berita acara memuat tempat pelaksanaan penandatanganan nama jabatan / pejabat dan tanda tangan para pihak dan para saksi.

Jika dibuat dengan mengetahui pejabat di atasnya maka jabatan yang paling rendah ada disebelah kanan dan yang jabatannya lebih tinggi ada di sebelah kiri.

4) Hal yang harus diperhatikan

Penomoran Berita Acara mengacu pada Tata Naskah RS Prima Husada.

5) Lampiran Berita Acara

Lampiran berita acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara lain laporan, notulensi, memori, daftar seperti daftar asset / arsip yang terkait dengan materi muatan suatu berita acara.

c. Lampiran Berita Acara

Lampiran Berita Acara adalah dokumen tambahan yang berisi antara lain laporan, notulensi, memori, daftar seperti daftar asset / arsip yang terkait dengan materi muatan suatu berita acara.



- c) Nomor surat keterangan ditulis dengan huruf kapital (*bold*) dan diletakan secara simetris.
- 2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat keterangan memuat pejabat yang menerangkan mengenai sesuatu hal, peristiwa, atau tentang seseorang yang diterangkan, maksud dan tujuan diterbitkannya surat keterangan.
- 3) Kaki
Bagian kaki surat keterangan memuat keterangan tempat, tanggal, bulan, tahun, nama jabatan, tanda tangan, dan nama pejabat yang membuat surat keterangan tersebut diawali dengan huruf capital dan *Bold* . Posisi bagian kaki terletak pada bagian kanan bawah.
- 4) Hal yang harus diperhatikan
Penomoran Surat Keterangan mengacu pada Tata Naskah Rumah Sakit Prima Husada.

CONTOH
FORMAT SURAT KETERANGAN

 RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	 PT. DISA PRIMA MEDIKA
--	---

SURAT KETERANGAN
NOMOR

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Jabatan :

Alamat :

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama :

Jabatan :

.....

.....

.....

.....

Pas/Mlg/Prob.....
Direktur Rumah Sakit Prima
Husada

Nama terang & stempel

Jl. Alamat RSPH. – Kota/Kab
Telp : | Email : info.....@rs-primahusada.com
www.rs-primahusada.com

3.3.5. Surat Pengantar

- a. Pengertian
Surat Pengantar adalah naskah dinas yang digunakan untuk mengantar / menyampaikan barang atau naskah.
- b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan.
Surat Pengantar dibuat dan ditandatangani oleh pejabat baik yang mengirim dan menerima sesuai dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya.
- c. Susunan
 - 1) Kepala
Bagian kepala surat pengantar terdiri dari :
 - a) Kop naskah dinas;
 - b) Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun pembuatan surat diletakkan di sebelah kanan atas;
 - c) Kata Kepada Yth., yang ditulis di sebelah kiri, diikuti dengan nama atau jabatan yang dikirim surat;
 - d) Alamat surat, ditulis dibawah Kepada Yth.;
 - e) Tulisan surat pengantar ditulis dengan huruf kapital (*bold*) dan diletakkan secara simetris;
 - f) Nomor surat pengantar ditulis dengan huruf kapital (*bold*) dan diletakkan secara simetris;
 - 2) Batang Tubuh
Bagian batang tubuh surat pengantar dalam bentuk kolom terdiri dari:
 - a) Nomor urut;
 - b) Jenis yang dikirim;
 - c) Banyaknya naskah dan barang; dan
 - d) Keterangan
 - 3) Kaki
Bagian kaki surat pengantar terdiri dari :
 - a) Pengirim yang berada di sebelah kanan, meliputi ;
 - (1) Nama jabatan pembuat pengantar;
 - (2) Tanda tangan;
 - (3) Nama; diawali dengan huruf capital dan *Bold* .
 - (4) Stempel
 - b) Penerima yang berada di sebelah kiri, yang meliputi :
 - (1) Nama jabatan penerima;
 - (2) Tanda tangan;
 - (3) Nama;
 - (4) Stempel;
 - (5) Nomor telepon instalasi; dan
 - (6) Tanggal penerimaan.
- d. Hal yang Perlu Diperhatikan
 - 1) Surat Pengantar dikirim dalam dua rangkap, lembar pertama untuk penerima dan lembar kedua untuk pengirim.
 - 2) Penomoran surat pengantar mengacu pada Tata Naskah RS Prima Husada

CONTOH
FORMAT SURAT PENGANTAR



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

Kepada Yth.

.....
.....

SURAT PENGANTAR
NOMOR

No	Jenis Yang dikirimkan	Banyaknya	Keterangan

Diterima tanggal
Penerima
Nama Jabatan,

Tanda Tangan dan Stempel

Nama Lengkap

Pengirim
Nama Jabatan,

Tanda Tangan dan Stempel

Nama Lengkap

No. Telepon

Tembusan :

1.
2.
3. dan seterusnya

3.3.6. Pengumuman

a. Pengertian

Pengumuman adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang suatu hal yang ditujukan kepada semua pejabat / pegawai / perseorangan baik di dalam maupun di luar RS Prima Husada.

b. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Pengumuman dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pejabat lain yang ditunjuk.

c. Susunan

1) Kepala

Bagian kepala pengumuman terdiri dari :

- a) Kop naskah dinas;
- b) Tulisan pengumuman keterangan ditulis dengan huruf kapital dan diletakan secara simetris;
- c) Nomor surat keterangan ditulis dengan huruf kapital dan diletakan secara simetris;
- d) Kata tentang, yang dicantumkan di bawah pengumuman ditulis dengan huruf kapital (*bold*) dan diletakan secara simetris; dan
- e) Rumusan judul pengumuman, ditulis dengan huruf kapital secara simetris di bawah tentang.

2) Batang Tubuh

Batang tubuh pengumuman hendaknya memuat :

- a) Alasan tentang perlunya dibuat pengumuman;
- b) Peraturan yang menjadi dasar pembuatan pengumuman; dan
- c) Pemberitahuan tentang hal tertentu.

3) Kaki

Bagian kaki pengumuman ditempatkan di sebelah kanan, yang terdiri dari :

- a) Tempat dan tanggal penetapan;
- b) Nama jabatan pejabat yang menetapkan, ditulis dengan huruf awal kapital, diakhiri dengan tanda baca koma;
- c) Tanda tangan pejabat yang menetapkan;
- d) Nama lengkap yang menandatangani, ditulis dengan huruf awal kapital; dan
- e) Stempel.

d. Hal yang Perlu Diperhatikan

- 1) Pengumuman tidak memuat alamat, kecuali yang ditujukan kepada kelompok / golongan tertentu.
- 2) Pengumuman bersifat menyampaikan informasi, tidak memuat cara pelaksanaan teknis suatu peraturan.
- 3) Penomoran Pengumuman mengacu pada Tata Naskah RS Prima Husada
.....

3.4. Laporan

1. Pengertian

Laporan adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan tentang pelaksanaan suatu kegiatan / kejadian.

2. Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat / staf yang diberi tugas. Laporan ditandatangani oleh pejabat / staf yang disertai tugas.

3. Susunan

5) Sampul

Bagian Sampul Laporan terdiri dari :

- (1) Judul Laporan ditulis dengan huruf kapital (bold) yang diletakan secara simetris;
- (2) Bulan dan tahun, ditulis dengan huruf kapital (bold) secara simetris;
- (3) Logo Rumah Sakit Prima Husada
- (4) Nama, alamat, nomor telepon, email dan website Rumah Sakit Prima Husada;

6) Isi Laporan

Bagian Isi Laporan terdiri dari :

- 1) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum atau latar belakang, maksud, dan tujuan, dasar hukum serta ruang lingkup dan sistematika laporan, disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaporkan;
- 2) Materi Laporan, yang terdiri dari kegiatan yang dilaksanakan, factor yang mempengaruhinya, hasil pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, monitoring evaluasi, dan hal yang perlu dilaporkan sesuai dengan kegiatannya,
- 3) Simpulan dan saran, atau monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan masukan dan pertimbangan; dan
- 4) Penutup, yang merupakan akhir laporan, memuat harapan / permintaan arahan / ucapan terima kasih.

c. Kaki

Bagian kaki Laporan terdiri dari:

- 1) Tempat dan tanggal pembuatan laporan;
- 2) Nama jabatan pejabat pembuat laporan, ditulis dengan huruf awal kapital;
- 3) Tanda tangan; dan
- 4) Nama lengkap, ditulis dengan huruf awal capital dan setiap unsurnya
- 5) Apabila ada pejabat diatasnya maka tanda tangan berada di kiri pembuat laporan dan pejabat yang lebih tinggi dikiri bawah dan pejabat yang paling tinggi ada di tengah

4. Hal yang harus diperhatikan

A. Laporan bisa dilengkapi dengan lampiran disesuaikan dengan kebutuhan

Untuk laporan hasil rapat atau pertemuan (Notulen) dapat berupa:

- 6) Undangan
- 7) Materi (bentuk PPT atau word atau fisik)
- 8) Notulen
- 9) Daftar hadir peserta
- 10) Dokumentasi (Foto)

Lampiran ini disesuaikan dengan kebutuhan sesuai kegiatan yang dilaporkan, dst

B. Pembuatan laporan bulanan, triwulan, tahunan pembuatan Tabel dan grafik sesuai kebutuhan dan apa yang ingin ditonjolkan dalam laporan tersebut..Tabel wajib diikuti dengan grafik, analisis dan rencana tindak lanjut, sesuai kebutuhan dimana trend yang ingin ditonjolkan dalam laporan

CONTOH
FORMAT LAPORAN



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

LAPORAN HASIL KEGIATAN
SEMINAR/WORKSHOP/GATHERING/DIKLAT/.....
TAHUN.....

**BAB I .
PENDAHULUAN**

- 1.1. Umum/Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

**BAB II.
HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN**

- 2.1. Susunan Panitia (dilengkapi tupoksinya)
- 2.2. Pelaksanaan Kegiatan (hari, tgl, jam, tempat)
- 2.3. Sasaran Atau Peserta
- 2.4. Nara Sumber/Pemateri
- 2.5. Susunan Acara
- 2.6. Media (yang digunakan)
- 2.7. Metode (yang digunakan)
- 2.8. Anggaran (rincian anggaran yang telah dikeluarkan untuk kegiatan)

**BAB III.
MONITORING-EVALUASI**

- 3.1. Monitoring
- 3.2. Evaluasi

**BAB IV.
PENUTUP**

.....
.....

Nama Jabatan pejabat diatasnya
atau Ketua Panitia

Tanda tangan

Nama Lengkap pejabat/ketua

Pas/Mlg/Prob,
tanggal –bln- tahun
Nama Jabatan pembuat laporan

Tanda Tangan dan Stempel

Nama Lengkap

CONTOH
FORMAT LAPORAN KINERJA TRIWULAN, SEMESTER DAN TAHUNAN RSPH



LAPORAN KINERJA SEMESTER.../TAHUNAN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADATAHUN 20.....

BAB I
PENDAHULUAN

- 1.1. Umum/Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II
GAMBARAN UMUM

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Motto
- 2.4. 7 Nilai Budi Utama
- 2.5. SOTK

BAB III.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

- 3.1 SDM :
 - 3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)
 - 3.1.2 Orientasi
 - 3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
 - 3.1.4. Evaluasi Kinerja Staf
- 3.2. Pengembangan Pelayanan (inovasi, kreatifitas, terobosan, layanan baru untuk meningkatkan pelayanan di unit tsb
- 3.3. Kinerja Produktifitas Unit dan Instalasi sesuai kelompok Bidangnya (semua program/kegiatan pelayanan di RSPH per Unit yang diambil rekapannya, garis besar, untuk rincian/detailnya masukkan lampiran)
 - 3.3.1. Penunjang terdiri dari (A.Farmasi, B.Radiologi, C.Laboratorium terpadu, D.RM, E.Gizi, F. CSSD-laundry, G.Unit kamar jenazah, H.Rehab. Medik)
 - 3.3.2 Pelayanan (IRJA : poliklinik, IGD; Irna : ICU, perina, Maternitas, R.....)
 - 3.3.3. Umum (Humas-marketing, IPS, CS, Gudang, security, penjaminan, PIPP).
 - 3.3.4. Program Nasional (PROGNAS)
- 3.4. Kinerja Produktifitas Komite MFK dan K3
 - 3.4.1. Fasilitas Kesehatam
 - 3.4.2. Gedung & bangunan
 - 3.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 3.5. Kinerja Produktifitas Komite Mutu :
 - 3.5.1 Mutu Nasional
 - 3.5.2 Mutu prioritas Rumah Sakit
 - A. Mutu Sasaran keselamatan Pasien /SKP
 - B. Mutu Pelayanan klinis prioritas
 - C. Mutu terkait Tujuan strategis rumah sakit .
 - D. Mutu terkait perbaikan sistem
 - E. Mutu terkait manajemen risiko
 - 3.5.3. Mutu prioritas Internal Unit (tiap unit)/Instalasi/Program
 - 3.5.4 Mutu *Global Budget* (sesuai regulasi jika sudah dijalankan)
- 3.6. Kinerja Produktifitas Komite PPI
- 3.7. Kinerja Produktifitas Tim PKRS
- 3.8. Kinerja Produktifitas Tim Geriatri
- 3.9 Kinerja Produktifitas KFT
- 3.10. Kinerja Produktifitas Tim Review RM
- 3.11 Kinerja Produktifitas Komite PPRA
- 3.12. Kinerja Produktifitas Komite keperawatan
- 3.13. Kinerja Produktifitas Komite Medis
- 3.14 Kinerja Produktifitas Komite Tenaga Kes lain
- 3.15. Kinerja Produktifitas Semua TIM/komite dimasukkan semua walaupun tidak KASUS /hasil 0

(setiap tabel diikuti grafik, analisis, RTL atau tambahkan PDSA jika terkait Mutu, masukkan juga hasil supervisi masing masing kegiatan) , lampiran ditaruh paling belakang untuk rincian yang lengkap, jika ada kolom di kinerja produktifitas isi dengan kesimpulan atau rekapan secara keseluruhan jangan masukkan lampiran semua.

BAB IV.
KINERJA KEUANGAN

BAB V.
KESIMPULAN DAN SARAN

BAB VI.
PENUTUP

SERTAKAN
LAMPIRAN2 NYA

Pas/Mlg/Prob, tanggal –bln- tahun
Direktur Rumah Sakit Prima Husada
.....
Tanda Tangan dan Stempel

CONTOH
FORMAT LAPORAN KINERJA TAHUNAN PROGRAM MUTU RSPH



LAPORAN KINERJA PMKP
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TAHUN.....

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang (alasan indikator2 tsb. Dipilih, alasan diklat dilakukan, alasan pemilihan IMPRS , strategi yang digunakan di tahun pelaporan, semua alasan/analisis situasi dimasukkan dilatar belakang).

1.2 Dasar Hukum (terkini terupdate yang masih berlaku yang terkait Mutu)

1.3 Maksud dan Tujuan (laporan ini dibuat untuk apa?

Misalnya :

- 1).Mengevaluasi Kinerja Mutu: Untuk memberikan penilaian menyeluruh mengenai kinerja Komite Mutu selama periode semester I tahun 2024. Evaluasi ini mencakup pencapaian target mutu, efektivitas strategi yang diterapkan, serta pengukuran keberhasilan dalam implementasi sistem manajemen mutu.
- 2). Mengidentifikasi Kendala dan Masalah: Untuk mengidentifikasi dan menganalisis kendala atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mutu. Identifikasi ini bertujuan untuk menemukan solusi yang tepat guna mengatasi hambatan dan meningkatkan efektivitas sistem mutu.
- 3). Memberikan Rekomendasi Perbaikan: Untuk menyusun rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi dan analisis. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu organisasi dalam merumuskan strategi dan tindakan yang diperlukan untuk peningkatan mutu di masa mendatang.
- 4). Menyediakan Informasi kepada Stakeholder: Untuk menyajikan informasi yang transparan dan komprehensif kepada manajemen dan seluruh stakeholder mengenai upaya, pencapaian, dan tantangan yang dihadapi oleh Komite Mutu. Informasi ini penting untuk menjaga keterlibatan dan dukungan stakeholder terhadap upaya perbaikan mutu.
- 5). Menilai Implementasi dan Kepatuhan: Untuk menilai sejauh mana implementasi sistem manajemen mutu dan kepatuhan terhadap standar serta kebijakan mutu yang telah ditetapkan. Penilaian ini juga meliputi audit internal dan eksternal yang dilakukan selama periode laporan.
- 6). Menyusun Strategi untuk Perbaikan Berkelanjutan: Untuk memberikan dasar dalam penyusunan strategi perbaikan berkelanjutan yang akan diterapkan di semester berikutnya. Laporan ini bertujuan untuk membantu perencanaan dan pengembangan kebijakan mutu yang lebih efektif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis.
- 7). Mengukur Dampak Inisiatif Mutu: Untuk mengevaluasi dampak dari inisiatif dan proyek-proyek mutu yang telah dilaksanakan. Penilaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif tersebut memberikan manfaat yang signifikan dan berkontribusi positif terhadap pencapaian tujuan mutu organisasi.

1.4.Ruang Lingkup

Misalnya / Contoh:

Laporan Komite Mutu Tahun 202... mencakup ruang lingkup sebagai berikut:

- 1). Evaluasi Kinerja Kegiatan Mutu:
Proses dan Metodologi: Menilai efektivitas proses dan metodologi yang diterapkan oleh Komite Mutu, termasuk pelaksanaan sistem manajemen mutu, audit internal, dan kegiatan pemantauan mutu.
Pencapaian Target: Evaluasi pencapaian target mutu yang telah ditetapkan untuk tahun 202..., serta analisis terhadap pencapaian dan ketidaksesuaian.
- 2). Analisis dan Identifikasi Kendala:
Masalah dan Hambatan: Identifikasi masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan mutu, serta analisis penyebabnya.
Solusi dan Tindakan Korektif: Penilaian terhadap solusi dan tindakan korektif yang telah diterapkan untuk mengatasi masalah dan hambatan tersebut.
- 3). Audit dan Kepatuhan:
Audit Internal: Laporan hasil audit internal yang mencakup penilaian kepatuhan terhadap prosedur dan standar mutu, serta tindak lanjut dari temuan audit
Audit Eksternal: Evaluasi hasil audit eksternal (jika ada) missal dari PT atau hasil PPS akre atau BPJS atau Dinkes) yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk rekomendasi yang diberikan dan tindak lanjutnya.
- 4). Program Pelatihan dan Pengembangan: Pelatihan Karyawan: Penilaian efektivitas program pelatihan yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi dan kesadaran karyawan mengenai mutu, serta hasil dari pelatihan tersebut. Pengembangan Kapasitas: Analisis terhadap pengembangan kapasitas dan keterampilan karyawan dalam mendukung pencapaian standar mutu.
- 5). Inisiatif dan Proyek Mutu (Pengembangan Layanan Mutu) :
Inisiatif Terbaru: Evaluasi terhadap inisiatif dan proyek mutu yang dilaksanakan selama I th, termasuk penilaian dampaknya terhadap peningkatan mutu. Proyek Khusus: Laporan mengenai proyek-proyek khusus yang dijalankan untuk memperbaiki proses atau meningkatkan produk/layanan jika ada.

- . 6). Feedback dan Kepuasan Pelanggan:
Pengumpulan Data: Analisis data feedback dari pelanggan yang diperoleh selama periode laporan, serta penilaian terhadap tingkat kepuasan pelanggan dan tren yang teridentifikasi. § Tindakan Perbaikan: Penilaian terhadap tindakan perbaikan yang diambil berdasarkan feedback pelanggan dan efektivitas tindakan tersebut.
7. Kolaborasi dan Koordinasi:
Kerja Sama Antar Departemen: Evaluasi terhadap kerja sama dan koordinasi antar departemen dalam mendukung upaya peningkatan mutu, serta penilaian terhadap integrasi sistem dan proses. Komunikasi dan Integrasi: Analisis efektivitas komunikasi dan integrasi antara Komite Mutu dan unit-unit lain dalam organisasi, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan mutu.
- 8). Penilaian Terhadap Kebijakan dan Prosedur: Kebijakan Mutu: Evaluasi penerapan dan efektivitas kebijakan mutu yang ada, analisis terhadap kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan dan standar terkini. Prosedur Operasional: Penilaian terhadap prosedur operasional yang diterapkan untuk memastikan kesesuaian dengan standar mutu dan efektivitasnya dalam implementasi.
- 9). Laporan Kinerja dan Rencana Tindak Lanjut:
Laporan Kinerja: Ringkasan pencapaian kinerja Komite Mutu selama periode semester I dan keberhasilan dan area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Rencana Tindak Lanjut: Usulan rencana dan strategi untuk periode berikutnya, berdasarkan temuan.

BAB II
GAMBARAN UMUM

- 2.1 Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Motto
- 2.4. 7 Nilai Budi Utama
- 2.5. SOTK Komite Mutu RS

BAB III.
KEGIATAN YANG TELAH DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

- 3.1 SDM :
- 3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)
 - 3.1.2 Orientasi (pengisian Mutu untuk orientasi staf baru)
 - 3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat Mutu :)
 - 3.1.4. Evaluasi Kinerja Staf (Komite Mutu termasuk PIC Mutu Unit)
- 3.2. Pengembangan Pelayanan (inovasi, kreatifitas, terobosan, layanan baru untuk meningkatkan pelayanan di unit tsb
- 3.3. Hasil Kinerja Mutu RS
- Uraikan tentang** : hasil pencapaian dari penyelenggaraan tata kelola mutu RS. Hasil kinerja meliputi
- 1) Pencapaian Indikator Mutu Nasional, (termasuk Evaluasi Panduan Praktik Klinik (PPK) / Clinical Pathway (CP) hitung juga Effisiensinya (KMKB nya, adakah kerugian yang tidak patuh?)
 - 2) Indikator Mutu Prioritas RS :
 - a. 6 SKP
 - b. Terkait Renstra
 - c. Terkait Sistem
 - d. Klinis : uraikan secara terperinci /laporkan Program Perbaikan yang IMP Klinis yang sudah dilakukan sampai berapa level PDSA nya, analisisnya menggunakan tulang ikan atau 5W? Dirapatkan terus sambung menyambung ? Hasilnya? RTL bagaimana strateginya -TL-monitoring-evaluasi dan progresnya dst. Hasilnya baik primer maupun sekunder.
 - e. Terkait Manrisk (asalnya dulu awal tahun dipilih melalui UGD/FGD 1 yang dimasukkan IMPRS)
 - 3) Mutu Program misalnya :
 - a.Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI),
 - b.KE, Geriatri,
 - c.Prognas, dan yang lain
 - 4) Indikator Mutu Prioritas Unit (IMP – Unit), ,
 - 5) Budaya Keselamatan Pasien dan Budaya Keselamatan RS (ini mencakup semua), **jika mau dibuat laporan tersendiri juga tidak apa-apa beri keterangan dilaporkan terpisah!!!!.**
 - 6) Manajemen Risiko (jika sudah ada di Budaya Keselamatan RS ya tidak apa-apa menjadi 1),
 - 7) Pemenuhan Standard Akreditasi RS (yang tidak termasuk di atas dibuatkan laporannya disini).

BAB IV
MONITORING EVALUASI

- 4.1 Monitoring : laporkan rekapan /audit dan hasil supervisi yang dilakukan 1 tahun (berapa kali nya, hasilnya, lampirkan beberapa sampel lembar supervisi).
- 4.2. Evaluasi : uraikan berapa kali dilakukan rapat evaluasi pesertanya siapa/sasaran rapat, hasilnya bagaimana, komitmen bagaimana, Rakor dg program lain? , rakor dg unit? Rakor pemilihan indikator dst kalau perlu lampirkan sejak mulai awal tahun. Rapat dengan SDM untuk memasukkan kedalam kinerja, PPI, MFK, Manajerial, koreksi dari PT, Studi kasus dst.

BAB V
PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi/Saran

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit prima Husada

Pas/Mlg/Prob, tanggal –bln- tahun
Ketua Komite/PJ Mutu RSPH

.....

Nama dan Sempel

Tanda Tangan

CONTOH
FORMAT LAPORAN KINERJA TRIWULAN- SEMESTER DAN TAHUNAN
UNIT/INSTALASI/PENGELOLA PROGRAM



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN..../SEMESTER/TAHUNAN UNIT /
INSTALASI/PROGRAM.....
RSPH..... TAHUN**

**BAB I .
PENDAHULUAN**

- 1.1. Umum/Latar belakang (bisa dimasukkan masalah2 yang terjadi TW yang lalu mengerucut sampai alasannya membuat laporan Tw/semester/tahun lalu)
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan (uraikan maksud dan tujuan pembuatan laporan, untuk apa, apa saja yang dilaporkan)

**BAB II
GAMBARAN UMUM**

- 2.1 Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Motto
- 2.4. 7 Nilai Budi Utama
- 2.5. SOTK (SOTK di unit ditarik dari Direktur)

**BAB III.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI**

- 3.1 SDM :
 - 3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)
 - 3.1.2 Orientasi (berapa orang JMI staf baru yang orientasi khusus ? Evaluasi Kinerjanya?)
 - 3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat utk staf unit yang sudah dilakukan tabel...)
 - 3.1.4. Evaluasi Kinerja Staf (rekapan, jika masing2 uraian Panjang masukkan lampiran)
 - 3.2. Pengembangan Pelayanan (Inovasi / hal baru layanan yang sedang dikembnagkan di trial diujicobakan khusus di unit tsb)
 - 3.3. Kinerja Produktifitas (semua program/kegiatan pelayanan yang harus dikerjakan di unit tsb, cocokkan dengan Proker yang sudah anda buat kurang jangan lebih boleh)
 - 3.3.1.....
 - 3.3.2..... dst
 - 3.4. Fasilitas Kesehatan (MFK) dan K3
 - 3.4.1. Fasilitas Kesehatam (aldok/alkes/asset yang butuh kalibrasi/pemeliharaan)
 - 3.4.2. Gedung & bangunan (laporan kerusakan/perbaikan/proses/PCRA)
 - 3.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Jumlah Hari cuti, Ijin, Sakit, Mangkir; Immunisasi, Kecelakaan kerja dll)
 - 3.5. Mutu : INM yang sesuai unit/sesuai diProker ; IMPRS (jika termasuk) ; Mutu Prioritas Unit, Manrisk, IKP yang terjadi di unit
 - 3.6. PPI : (target tercapai/tdk, RTL nya bagaimana? Tabel , sesuaikan dengan standard unit)
 - 3.7. PKRS (target tercapai/tdk, RTL nya bagaimana? Tabel , sesuaikan dengan standard unit)
- Jika ini Adalah laporan tahunan maka tambahkan yang terkait dengan standard akreditasi yang harus ada di unit Anda.**

**BAB III.
MONITORING DAN EVALUASI**

- 3.1 Monitoring : berisi monitoring dalam bentuk observasi/supervisi/pengisian Logbook/
- 3.2 Evaluasi :evaluasi dalam bentuk rapat evaluasi program yang telah dilaksanakan sesuai pedoman rapat bulanan atau insidental)

**BAB IV.
PENUTUP**

Penutup bisa berisi Kesimpulan dan saran/ Rekomendasi

Mengetahui

Kepala Instalasi/Pejabat di atasnya

Nama lengkap

....., tanggal –bln- tahun

Kepala Ruang/unit

Tanda Tangan

Nama Lengkap

CONTOH
FORMAT LAPORAN KINERJA SEMESTER/ TAHUNAN PROGRAM PPI



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

**BAB I .
PENDAHULUAN**

- 1.1. Umum/Latar belakang (bisa dimasukkan masalah2 yang terjadi semester/tahun yang lalu mengerucut sampai alasannya membuat laporan Tw/semester/tahun lalu)
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan (uraikan maksud dan tujuan pembuatan laporan, untuk apa, apa saja yang dilaporkan)

**BAB II
GAMBARAN UMUM**

- 2.1 Visi
- 2.2 Misi
- 2.3 Motto
- 2.4. 7 Nilai Budi Utama
- 2.5. SOTK (SOTK di unit ditarik dari Direktur)

**BAB III.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI**

- 3.1 SDM :
 - 3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)
 - 3.1.2 Orientasi (berapa orang JMI staf baru yang orientasi PPI ? Evaluasi Kinerjanya?)
 - 3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat PPI yang sudah dilaksanakan lengkap)
 - 3.1.4. Evaluasi Kinerja Staf (rekapan penilaian kinerja IPCN, IPCLN dan IP Unit)
- 3.2. Pengembangan Pelayanan (Inovasi / hal baru layanan yang sedang dikembnagkan di trial diujicobakan khusus di unit tsb)
- 3.3. Kinerja Produktifitas (semua program/kegiatan pelayanan yang harus dikerjakan di unit tsb,
 - 3.3.1.Kewaspadaan Standard :
 - (1) Kebersihan tangan (termasuk Fasilitas Kebersihan Tangan)
 - (2) Alat Pelindung diri
 - (3) Dekontaminasi peralatan perawatan pasien (CSSD)
 - (4) Pengendalian lingkungan :
 - a.Kebersihan Umum
 - b.Kebersihan Toilet
 - c.Penyimpanan Alat Dan Obat
 - d.Pemeriksaan lingkungan RS
 - (5) Pengelolaan limbah :
 - a. Limbah Domestik
 - b. Limbah B3 : 1) padat 2) cair
 - (6) Penatalaksanaan linen (Laundry)
 - (7) Perlindungan kesehatan petugas (Paparan dan Paparan)
 - (8) Penempatan pasien (isolasi baik di IGD, Klinik TBC, Irna Isolasi)
 - (9) Kebersihan pernafasan/etika batuk dan bersin
 - (10) Praktik menyuntik yang aman
 - (11) Praktik lumbal pungsi (IKO)
 - 3.3.2.Kewaspadaan Transmisi (masukkan APD, Penempatan Pasien, Edukasi)
 - (1) Kontak
 - (2) Droplet
 - (3) Airborne
 - 3.3.4. .Survilance
 - 3.3.5 ICRA Bangunan
 - 3.3.6. Sosialisasi dan Edukasi PPI

**BAB IV.
PENUTUP**

Penutup bisa berisi Kesimpulan dan saran/ Rekomendasi

Mengetahui
Dir RSPH

Mengetahui
Ketua PPI

....., tanggal -bln- tahun
PJ- PPI
Tanda Tangan
Nama Lengkap

CONTOH
FORMAT LAPORAN KINERJA BULANAN
UNIT/INSTALASI/



LAPORAN KINERJA BULANAN UNIT/INSTALASI.....
RSPH..... BULAN.... TAHUN

I. SDM :

- 1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi, kebutuhan)
- 1.2 Orientasi (apakah ada peserta orientasi di bulan tersebut)
- 1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat yang belum dan yang sudah dilaksanakan)
- 1.4. Evaluasi Kinerja Staf

II. PENGEMBANGAN PELAYANAN

(berisi inovasi yang dikembangkan di tiap unit oleh unit itu sendiri : missal terapi music di ruang ICU, Hipnolaktasi, Hipnobirthing, dll, tabulasi data, grafik)
Jika telah berjalan lebih dari 1 tahun maka menjadi layanan unggulan Unit.

III. KINERJA PRODUKTIFITAS UNIT (semua program/kegiatan pelayanan sehari-hari di unit tsb)

- 3.1.....
- 3.2..... dst

IV. FASILITAS KESEHATAN DAN K3

- 4.1. Fasilitas Kesehatan (Alkes/Aldok/dll disesuaikan unitnya)+ **hasil pemeliharaan**
- 4.2. Gedung & bangunan + **hasil Pemeliharaan**
- 4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Jumlah Hari cuti, Ijin, Sakit, Mangkir; Imunisasi, Kecelakaan kerja dll) isikan kesimpulan atau rekapan garis besarnya saja pada kolom sedangkan rincian lengkap di lampiran

V. MUTU

VI. PPI

VII.PKRS

VIII. MONITORING DAN EVALUASI

(berisi monitoring dalam bentuk observasi/supervisi/ sedangkan evaluasi dalam bentuk rapat atau briefing, evaluasi program yang telah dilaksanakan sesuai pedoman rapat: bulanan atau insidentil)

TABEL REKAPAN HASIL SUPERVISI BULANAN UNIT/INSTALASI

No	tanggal	Kegiatan	Jumlah Yang dipantau/ observasi	Hasil temuan	Akar masalah	RTL	PIC	ket
1								

Tabel Permasalahan di InstalasiRSPH.....bulan... Tahun..

No	Masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC & Waktu
----	---------	-----------------------	-------------

IX. PENUTUP

Mengetahui
Kepala Instalasi/Pejabat diatasnya
.....
TTD

Nama lengkap

Pas/Mlg/Prob, tanggal –bln- tahun
Nama Jabatan pembuat laporan
Tanda Tangan

Nama Lengkap

CONTOH
FORMAT LAPORAN KINERJA BULANAN
UNIT/INSTALASI/



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

LAPORAN KINERJA BULANAN KEPALA BIDANG.....
RSPH..... BULAN.... TAHUN

I. SDM :

- 1.1 Ketenagaan (merupakan hasil rekapitulasi semua unit tabulasikan)
- 1.2 Orientasi (merupakan hasil rekapitulasi semua unit tabulasikan)
- 1.3 Pendidikan dan Pelatihan (merupakan hasil rekapitulasi semua unit tabulasikan)
- 1.4. Evaluasi Kinerja Staf (merupakan hasil rekapitulasi semua unit tabulasikan) jika ada tambahan tampilkan jika diperlukan.

II. PENGEMBANGAN PELAYANAN

(berisi inovasi yang dikembangkan di tiap unit oleh unit itu sendiri : misal terapi music di ruang ICU, Hipnolaktasi, Hipnobirthing, dll, tabulasi data, grafik)

Jika telah berjalan lebih dari 1 tahun maka pengembangan menjadi layanan unggulan.

III. KINERJA PRODUKTIFITAS UNIT (semua program/kegiatan pelayanan sehari-hari di unit tsb jika spesifik sendirikan jika sama bisa disatukan)

- 3.1.....
- 3.2..... dst sesuaikan dengan kinerja yang harus dilaporkan apabila rawat inap rekapitulasi seluruh irna

IV. FASILITAS KESEHATAN (MFK) DAN K3

- 4.1. Fasilitas Kesehatan (Alkes/Aldok/dll disesuaikan unitnya)+ **hasil pemeliharaan**
- 4.2. Gedung & bangunan + **hasil Pemeliharaan**
- 4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Jumlah Hari cuti, Ijin, Sakit, Mangkir; Immunisasi, Kecelakaan kerja dll) isikan kesimpulan atau rekapitulasi garis besarnya saja pada kolom sedangkan rincian lengkap di lampiran **(Rekapitulasi sesuai unit di Bidangnya)**

V. MUTU (masukkan yang IMP Unit saja sesuai bidangnya) jika IMP RS masuk dalam Bidang harus dilaporkan juga)

VI. PPI (Rekapitulasi sesuai unit di Bidangnya ini, sebagai Upaya pencegahan dan penanggulangan infeksi)

VII. PKRS (Rekapitulasi sesuai unit di Bidangnya karena KIE masuk disetiap lini dan menjadi sumber utama miss communication, termasuk KIE ke staf RS)

VIII. MONITORING DAN EVALUASI

(berisi monitoring dalam bentuk audit sedangkan evaluasi dalam bentuk rapat atau pertemuan evaluasi program dan hasilnya termasuk evaluasi persiapan audit dari luar)

TABEL REKAPAN HASIL AUDIT KABID/KABAG

No	Kegiatan Yang Di Audit	Hasil temuan	Akar masalah	RTL	Pelaksanaan TL	ket
1						

SILAHKAN DITAMBAHKAN JIKA ADA YANG PERLU DILAPORKAN

IX. PENUTUP

Mengetahui
Direktur RSPH
TTD

Nama lengkap

Pas/Mlg/Prob, tanggal –bln- tahun
Nama Jabatan pembuat laporan
Tanda Tangan

Nama Lengan

CONTOH
FORMAT LAPORAN KINERJA TAHUNAN



LAPORAN KINERJA SEMESTER.../TAHUNAN BIDANG.....
RUMAH SAKITTAHUN 20.....

BAB I
PENDAHULUAN

- 1.1. Umum/Latar belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan

BAB II
GAMBARAN UMUM

- 2.1 Visi
- 2.2. Misi
- 2.3. Motto
- 2.4. 7 Nilai Budi Utama
- 2.5. SOTK

BAB III.
KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DAN HASIL YANG DICAPAI

- 3.1 SDM :
 - 3.1.1 Ketenagaan (distribusi tenaga, kualifikasi dan kebutuhan)
 - 3.1.2 Orientasi
 - 3.1.3 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
 - 3.1.4. Evaluasi Kinerja Staf
- 3.2. Pengembangan Pelayanan (inovasi, kreatifitas, terobosan, layanan baru untuk meningkatkan pelayanan di unit tsb
- 3.3. Kinerja Produktifitas Unit dan Instalasi sesuai kelompok Bidangnya (semua program/kegiatan pelayanan di RSPH per Unit yang diambil rekapannya, garis besar, untuk rincian/detailnya masukkan lampiran)
Bidang Penunjang terdiri dari (A.Farmasi, B.Radiologi, C.Laboratorium terpadu, D.RM, E.Gizi, F. CSSD-laundry, G.Unit kamar jenazah, H.Rehab. Medik)
Bidang Pelayanan (IRJA : polyklinik, IGD; Irna : ICU, perina, Maternitas, R rawat lain.) tampilkan yang utama
Bidang Umum (SDM,Humas-marketing, IPS, CS, Gudang, security, penjaminan, PIPP, Kasir, Parkir).
- 3.4. Kinerja MFK dan K
 - 3.4.1. Fasilitas Kesehatan (alkes/aldok, pemeliharaan harian oleh unit, kondisi)
 - 3.4.2. Gedung & bangunan + hasil Pemeliharaan (perlu perbaikan, sudah diperbaiki, belum)
 - 3.4.3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Jumlah Hari cuti, ljin, Sakit, Mangkir; Immunisasi, Kecelakaan kerja dll) isikan kesimpulan atau rekapan garis besarnya saja pada kolom sedangkan rincian lengkap di lampiran (Rekapan sesuai unit di Bidangnya)
- 3.5. MUTU (masukkan yang IMP Unit saja sesuai bidangnya) jika IMP RS masuk dalam Bidang harus dilaporkan juga)
- 3.6. PPI (Rekapan sesuai unit di Bidangnya ini,sebagai Upaya pencegahan dan penanggulangan infeksi) Yang terkait HH, APD, penempatan pasien jika bidang pelayanan ,
- 3.7..PKRS (Rekapan sesuai unit di Bidangnya karena KIE masuk disetiap lini dan menjadi sumber utama miss communication, termasuk KIE ke staf RS)

BAB IV.
MONITORING DAN EVALUASI

(berisi monitoring dalam bentuk audit , rekapan dari supervisi selama 3 bulanan, progress tiap triwulan sampai akhir tahun, sedangkan evaluasi dalam bentuk rapat atau pertemuan evaluasi program dan hasilnya termasuk evaluasi persiapan audit dari luar RS)

TABEL REKAPAN HASIL AUDIT KABID/KABAG

Tri wulan	Kegiatan Yang Di Audit	Hasil temuan	Akar masalah	RTL	Pelaksanaan TL -Progress	ket
1		Jumlah sampel temuan nya %				
2						
3						

SILAHKAN DITAMBAHKAN JIKA ADA YANG PERLU DILAPORKAN

BAB V
PENUTUP

- 5.1 Kesimpulan
- 5.2. Rekomendasi/Saran

Mengetahui
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Kepala Bidang.....

Tanda Tangan
Nama terang

Tanda Tangan
Nama terang



LAPORAN PENGKAJIAN PENGELOLAAN STAF
(Penggunaan Data Mutu Dan Keselamatan Dalam Pengelolaan Staf)

TAHUN

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1..Latar Belakang

1.2. Tujuan

(tujuan bisa terkait dengan :

Jamin bahwa keputusan terkait staf berdasarkan data objektif.

Meningkatnya mutu pelayanan dan keselamatan pasien.

Optimalnya distribusi staf sesuai dengan kebutuhan klinis.

Sesuaikah jumlah dan kompetensi staf dengan kebutuhan layanan rumah sakit?.

BAB II
PENGKAJIAN PENGELOLAAN STAF.

2.1. Sumber Data dan Informasi

Data dan informasi yang digunakan dalam proses evaluasi staf meliputi:

- Indikator mutu pelayanan (angka kejadian sentinel, kepatuhan standar operasional, kepuasan pasien, waktu tunggu pelayanan, dll.).
- Data keselamatan pasien (insiden keselamatan pasien, laporan kejadian tidak diharapkan/near miss, root cause analysis).
- Evaluasi kinerja staf (hasil supervisi, penilaian kompetensi, pencapaian target kinerja individu dan tim).
- Beban kerja unit (rasio staf terhadap pasien, jumlah tindakan medis per unit waktu, kebutuhan tambahan tenaga medis berdasarkan tren pasien).
- Regulasi dan kebijakan rumah sakit terkait sumber daya manusia.

2.2. Mekanisme Evaluasi dan Pengambilan Keputusan

No.	Tahapan Evaluasi	Data yang Digunakan	Tindakan yang Diambil
1	Analisis kebutuhan staf per unit layanan	Beban kerja, tren kunjungan pasien, tingkat keterisian tempat tidur (BOR)	Penambahan atau pengurangan staf sesuai kebutuhan
2	Evaluasi kinerja staf	Hasil supervisi, laporan kesalahan medis, kepatuhan SOP	Pelatihan ulang, pemberian penghargaan, atau tindakan disipliner
3	Rotasi staf berdasarkan kebutuhan	Data kepuasan pasien, jumlah kasus klinis, beban kerja	Rotasi staf ke unit dengan beban kerja tinggi atau sesuai kompetensi
4	Pengurangan staf jika diperlukan	Evaluasi efisiensi layanan, penggunaan sumber daya, tren penurunan jumlah pasien	Penyesuaian jumlah staf berdasarkan kebutuhan real-time
5	Pemantauan dampak perubahan jumlah staf	Hasil audit mutu, tingkat keselamatan pasien, efektivitas layanan	Revisi strategi distribusi staf, rekrutmen jika diperlukan

2.3. Indikator Keberhasilan

Indikator	Target
Kepuasan pasien terhadap layanan (INM 13)	≥ 85%
Kepatuhan staf terhadap SOP klinis	≥ 95%
Waktu tunggu pasien dalam pelayanan medis	≤ 30 menit
Rasio staf terhadap pasien	Sesuai standar kebutuhan pelayanan
Jumlah kejadian tidak diharapkan (KTD) akibat kurangnya staf	0 kasus

Bandingkan dengan hasil pencapaiannya bagaimana?

2.4. Dokumentasi dan Laporan

- 2.4.1. Evaluasi kinerja staf per semester (secara rekapitan Kesimpulan besar, rincian taruh lampiran) .
- 2.4.2. Analisis kebutuhan staf tahunan .
- 2.4.3. Dokumen keputusan penambahan, pengurangan, atau rotasi staf.
- 2.4.4. Hasil audit mutu dan keselamatan terkait distribusi staf.
- 2.4.5. Rekomendasi perbaikan dari Komite Mutu dan Keselamatan Pasien.

**BAB III.
PENUTUP**

(Kesimpulan dan Rekomendasi)

Berdasarkan data mutu dan keselamatan pasien, pimpinan rumah sakit akan terus melakukan perbaikan dalam manajemen staf untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Keputusan yang diambil harus berbasis bukti, sesuai standar akreditasi, dan mengikuti kebutuhan operasional rumah sakit.

- 3.1. kesimpulan
- 3.2. Saran

Mengetahui	, tanggal –bln- tahun
Direktur Rumah Sakit Prima Husada	PJ-SDM
Tanda Tangan	Tanda Tangan
Nama Lengkap	Nama Lengkap

CONTOH
BAB IV
KINERJA KEUANGAN

Minimal Produktifiktas yang dilaporkan terkait keuangan

Tabel Pendapatan Rawat Jalan RSPH.....Berdasarkan Jenis Pembayaran Dan Jenis Klinik Bulan ... Tahun...

No	Poliklinik	Umum (Rp)	BPJS Kes (Rp)	BPJS TK (Rp)	Asuransi Swata Admedika	Asuransi Swasta Non Admedika	Perusa- haan	Jasa Raharja
1.	K. Anak							
2.	K.Anestesi							
3.	K Fisioterapi							
4.	K Gigi Spesialis							
5.	K Gigi Umum							
6.	K Jantung							
7.	K Jiwa							
8.	KKandungan							
9.	K Kulit Kelamin							
10.	K Mata							
11.	K Orthopedi							
12.	K Paru							
13.	K Peny. Dalam							
14.	Klinik Syaraf							
15.	Klinik THT							
16.	Klinik Urologi							
17.	K Bedah umum							
18.	K B. plastik							
19.	K.Bedah Syaraf							
20.	MCU							

Tabel Pendapatan Rawat Inap RSPH.....Berdasarkan Jenis Pembayaran Bulan ...
Tahun...

No	Rawat Inap	Umum (Rp)	BPJS Kes (Rp)	BPJS TK (Rp)	Asuransi Swata Admedika	Asuransi Swasta Non Admedika	Perusahaan	Jasa Raharja
1	VVIP							
2	VIP							
3	Kelas I							
4	Kelas 2							
5	Kelas 3							
6	Isolasi							
7	Perinatal Level 1							
8	Perinatal Level 2							
9	Perinatal Level 3							
10	ICU							

TabelPendapatan IGD RSPH.....Berdasarkan Jenis Pembayaran Bulan ...
Tahun...

Dan seterusnya sesuai kebutuhan dan apa yang ingin ditonjolkan dalam laporaTabel diikuti grafik, analisis dan rencana tindak lanjut, sesuai kebutuhan dimana trend yang ingin ditonjolkan dalam laporan.

CONTOH
TABEL KINERJA PRODUKTIFITAS PELAYANAN
BULANAN

..... Kinerja Produktifitas Rawat Jalan

Tabel Jumlah Kunjungan Rawat Jalan (Polyklinik) Berdasarkan Jenis pembayaran , Lama , baru di RSPH....bulan.... Tahun...

No	Polyklinik	Umum		BPJS Kes		BPJS TK		MCU		Jasa Raharja		Asur Swasta		Perusa haan		TOTAL	
		OB	OL	OB	OL	OB	OL	OB	OL	OB	OL	OB	OL	OB	OL	OB	OL
1	K. Anak																
2	K.Anestesi																
3	K Fisioterapi																
4	K Gigi Spesialis																
5	K Gigi Umum																
6	K Jantung																
7	K Jiwa																
8	KKandungan																
9	K Kulit Kelamin																
10	K Mata																
11	K Orthopedi																
12	K Paru																
13	K Peny. Dalam																
14	Klinik Syaraf																
15	Klinik THT																
16	Klinik Urologi																
17	K Bedah umum																
18	K B. plastik																
19	K.Bedah Syaraf																
20	MCU																
	dst																
Total																	

Tabel wajib diikuti grafik, analisis dan rencana tindak lanjut, sesuai kebutuhan sesuai trend yang ingin ditonjolkan dalam laporan

Tabel Jumlah Kunjungan IRJA Bulan Januari Tahun 2026

No	Nama POLIKLINIK	NOV 2025	DES 2025	JAN 2026	%	ket
1	Anak	875	777	897	1.06%	NAIK

Tabel 10 Penyakit Terbanyak Rawat Jalan (Polyklinik) di RSPH....bulan.... Tahun...

No	ICD 10	Deskripsi	Jumlah

Tabel permasalahan yang ada saat ini di Rawat jalan (Polyklinik) RSPH...bulan...tahun..

No	Masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC & waktu

CONTOH
TABEL LAPORAN KINERJA PRODUKTIFITAS PELAYANAN
BULANAN

Kinerja Produktifitas Rawat Inap

Tabel Jumlah Kunjungan Rawat Inap) Berdasarkan Jenis pembayaran di RSPH
.....bulan.... Tahun...

No	Kelas Perawatan	JML TT	Jumlah Pasien							Total	%
			Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asuransi Swasta	Jasa Raharja	Perusahaan	Asur Lain		
1.	VVIP										
2.	VIP										
3.	Kelas I										
4.	Kelas 2										
5.	Kelas 3										
6.	Perinatologi										
7.	NICU										
8.	ICU										
9.	ICU Isolasi										
10.	Isolasi										

Tabel Indikator Efisiensi Kinerja RSPH.....bulan...Tahun.....

No	Indikator	Standard	Hasil Pencapaian (bulan)			Ket (naik /turun)
		Satuan	2 bln sblm	1 bln sebelum	Bulan laporan	
1.	BOR					
2.	LOS					
3.	BTO					
4.	TOI					
5.	GDR					
6.	NDR					

TabelData LOS pasien BPJS Kesehatan berdasarkan DPJP Bulan Tahun 202....

No	Nama DPJP	LOS (Hari)											Grand Total
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	15	
1													
2													

Tabel Status Pasien Pulang Rawat Inap

No	Status Pulang	Jumlah	Tempat Tujuan Rujukan	Alasan (yang melatar belakang)
1	Sembuh			
2	Pulang Paksa			
3	Meninggal			
4	Rujuk			

Tabel 10 Penyakit Terbanyak Rawat Inap di RSPH....bulan.... Tahun...

No	ICD 10	Deskripsi	Jumlah

CONTOH
TABEL LAPORAN KINERJA PRODUKTIFITAS PELAYANAN IGD
BULANAN

..... Kinerja Produktifitas Instalasi/Unit Gawat Darurat

Tabel Jumlah Kunjungan di Instalasi/Unit Gawat Darurat Berdasarkan Jenis pembayaran dan Status Pasien di RSPH.....bulan.... Tahun...

No	Status Pasien	Jumlah Pasien					JML Total	%
		Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Jasa Raharja	Asuransi Swasta		
	Rawat Jalan							
	Rawat Inap							
	Rujuk							
	Meninggal							
	APS							
	Total							

Tabel..... 10 Penyakit Terbanyak di Instalasi/Unit Gawat Darurat RSPH....bulan.... Tahun...

No	ICD 10	Deskripsi	Jumlah

Tabel Permasalahan yang ada saat ini di Instalasi/Unit Gawat Darurat RSPH.....bulan....Tahun..

No	Masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC & waktu

Catatan :
Tabel dan grafik dibuat sesuai kebutuhan dan apa yang ingin ditonjolkan dalam laporan tersebut..minimal seperti contoh di atas.
Tabel wajib diikuti dengan **grafik, analisis dan rencana tindak lanjut**, sesuai kebutuhan dimana trend yang ingin ditonjolkan dalam laporan

CONTOH
TABEL KINERJA PRODUKTIFITAS PELAYANAN IKO
BULANAN

..... Kinerja Produktifitas Instalasi Kamar Operasi

Tabel Jumlah Kunjungan di Instalasi/Unit Kamar Operasi Berdasarkan Jenis pembayaran di RSPH.....bulan.... Tahun...

No	Jenis Operasi	Jumlah Pasien					jumlah Total	Ket
		Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Jasa Raharja	Asuransi Swasta		
1.	Kecil							
2.	Sedang							
3.	Besar							
4.	Khusus							

Tabel 10 Besar Penyakit Yang dilakukan Tindakan Operasi di Instalasi/ Kamar Operasi RSPH.....bulan....Tahun...

No	ICD 10	Deskripsi	Jumlah

Tabel Permasalahan di Instalasi/ Kamar Operasi RSPH.....bulan.... Tahun..

No	Masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC & waktu

Catatan :
Tabel dan grafik dibuat sesuai kebutuhan dan apa yang ingin ditonjolkan dalam laporan tersebut..minimal seperti contoh di atas.
Tabel wajib diikuti dengan grafik, analisis dan rencana tindak lanjut, sesuai kebutuhan dimana trend yang ingin ditonjolkan dalam laporan

CONTOH
TABEL KINERJA PRODUKTIFITAS PENUNJANG (bulanan)

..... Kinerja Produktifitas Instalasi Laboratorium

TabelJumlah Kunjungan Pemeriksaan Laboratorium Berdasarkan Jenis Pembayaran di RSPH bulan.... Tahun....

No	Jenis Pemeriksaan	Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asumasi Swasta	Jasa Raharja	Total
1. Patologi Klinik	1) Kimia darah						
	2) Hematologi						
	3) Serologi dan Molekuler						
	4) Urine						
	5) Immunoserologi RTAG						
	6) Immunoserologi Swab Ag						
	7) Transudat/Eksudat						
	8) Feses						
	9) Bakteriologi/Mikrobiologi						
	10) Lain-lain tambahkan						
2. Patologi Anatomi	1) Pemeriksaan Sitologi						
	2) Pemerik. Histopatologi						
3 BDRS (bisa dirinci sesuai Golda)							
TOTAL							

TabelJumlah Pemeriksaan Laboratorium yang dirujuk ke luar RSPH..... bulanTahun....

No	Jenis Pemeriksaan	Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asumasi Swasta	Jasa Raharja	Total
2. Patologi Klinik	1) Kimia darah						
	2) Hematologi						
	3) Serologi dan Molekuler						
	4) Urine						
	5) Immunoserologi RTAG						
	6) Immunoserologi Swab Ag						
	7) Transudat/Eksudat						
	8) Feses						
	9) Bakteriologi/Mikrobiologi						
	10) Lain-lain						
2. Patologi Anatomi	1) Pemeriksaan Sitologi						
	2) Pemerik. Histopatologi						
3 BDRS (bisa dirinci sesuai Golda)							
TOTAL							

Bisa dilengkapi sendiri sesuai jenis layanan di laboratorium terpadu, disendirikan antara PK, PA, BDRS

Tabel Permasalahan di Instalasi Laboratorium RSPHbulan...Tahun..

No	Masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC & waktu

Catatan :
Tabel dan grafik dibuat sesuai kebutuhan dan apa yang ingin ditonjolkan dalam laporan tersebut..minimal seperti contoh di atas.
Tabel wajib diikuti dengan grafik, analisis dan rencana tindak lanjut, sesuai kebutuhan dimana trend yang ingin ditonjolkan dalam laporan

CONTOH
TABEL KINERJA PRODUKTIFITAS INSTALASI RADIOLOGI

..... Kinerja Produktifitas Instalasi Radiologi

TabelJumlah Kunjungan Pemeriksaan Radiologi Menurut Jenis Pembayaran di RSPH
bulan.... Tahun....

No	Jenis Pemeriksaan	Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asumasi Swasta	Jasa Raharja	Total
1	Radiodiagnostik						
	1) Foto tanpa bahan kontras						
	2) Foto dengan bahan kontras						
	3) Foto dengan rol film						
	4) Fluoroskopi						
	5) Foto gigi						
	6) Foto Panoramix						
	7) Mamografi						
	8) Limphografi						
	9) Angiografi						
	10) Lain-lain						
	11) CT Scan tanpa kontras						
	12) CT Scan dengan kontras						
2	Imaging/Pencitraan						
	USG tanpa kontras						
	USG dengan kontras						
	dst.....						
TOTAL							

TabelJumlah Pemeriksaan Radiologi menurut jenis pembayaran yang dirujuk ke luar
RSPH..... bulanTahun....

No	Jenis Pemeriksaan	Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asumasi Swasta	Jasa Raharja	Total
1	Radiodiagnostik						
	1) Foto tanpa bahan kontras						
	2) Foto dengan bahan kontras						
	3) Foto dengan rol film						
	4) Fluoroskopi						
	5) Foto gigi						
	6) Foto Panoramix						
	7) Mamografi						
	8) Limphografi						
	9) Angiografi						
	10) Lain-lain						
	11) CT Scan tanpa kontras						
	12) CT Scan + kontras						
2	Imaging/Pencitraan						
	USG tanpa kontras						
	USG dengan kontras						
	dst.....						
3	MRI tanpa kontras						
	MRI dengan kontras						
TOTAL							

Tabel Permasalahan di Instalasi Radiologi RSPHbulan...Tahun..

No	Masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC & waktu

Catatan :

Tabel dan grafik dibuat sesuai kebutuhan dan apa yang ingin ditonjolkan dalam laporan tersebut..minimal seperti contoh di atas.

Tabel wajib diikuti dengan grafik, analisis dan rencana tindak lanjut, sesuai kebutuhan dimana trend yang ingin ditonjolkan dalam laporan

CONTOH
TABEL KINERJA PRODUKTIFITAS INSTALASI FARMASI RS

..... .Kinerja Produktifitas Instalasi Farmasi (IFRS)

TabelJumlah Resep Menurut Jenis Pembayaran dan Instalasi di RSPH.....ulan... Tahun

No	Unit /Instalasi	Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asumsi Swasta	Jasa Raharja	Total
1	Instalasi Rawat Inap :						
	Jumlah Resep Obat Racikan						
	Jumlah Resep Obat Jadi						
	Jumlah item Obat per R/						
2	IKO :						
	Jumlah Resep Obat Racikan						
	Jumlah Resep Obat Jadi						
	Jumlah item Obat						
3	Instalasi Rawat Jalan :						
	Jumlah Resep Obat Racikan						
	Jumlah Resep Obat Jadi						
	Jumlah item Obat						
4	IGD :						
	Jumlah Resep Obat Racikan						
	Jumlah Resep Obat Jadi						
	Jumlah item Obat dalam 1 resep rata2						
TOTAL							

Tabel Hasil Kinerja Instalasi Farmasi RSPH..... bulanTahun....

No	Kegiatan	Standard	Target	Pencapaian	Ket
1	Pengkajian Resep.				
2	Dobel cek obat-obat yg perlu diwaspadai				
3	Dispensing				
4	Pemantauan Dan Pelaporan Efek Samping Obat				
5	Edukasi Obat pada pasien dan keluarga				
6	Konseling				
7	Pemantauan Kadar Obat Dalam Darah				
8	Ronde/Visite Pasien/farmasi Klinik				
9	PIO				
10	Rekonsiliasi Obat				
11	5B, Dagusibu				
12	Obat tidak bertuan				
13	Lama waktu tunggu				
14					
TOTAL					

Tabel.... Hasil Perhitungan Stok Opname Instalasi Farmasi Bulan November 2024, Desember 2024, Januari 2025 (contoh pengambilan data 3 bln untuk lihat trend & sebagai pembandingan)

UNIT	JUMLAH STOK	JUMLAH PERSEDIAAN					
		NOVEMBER		DESEMBER		JANUARI 2025	
		JUMLAH	Rp	JUMLAH	Rp	JUMLAH	Rp
GUDANG	FISIK						
	SISTEM						
	SELISIH						
DEPO FARMASI	FISIK						
	SISTEM						
	SELISIH						
IKO	FISIK						
	SISTEM						
	SELISIH						
GUDANG RETURE	FISIK						
	SISTEM						
	SELISIH						
TOTAL SELISIH							

Catatan : Tabel wajib diikuti dengan grafik, analisis dan rencana tindak lanjut, sesuai kebutuhan dimana trend yang ingin ditonjolkan dalam laporan

Tabel..... Daftar Obat-obat Near ED <6 bulan (Bulan202. sd -..... 202..)

No	Kode	Nama Barang	Satuan	Harga Beli	Tanggal Expired	No Batch	Jumlah Fisik Baik (BULAN)	Total Harga	Laporan Penjualan 1 Tahun Terakhir
1									
2									

Tabel Rekapen kinerja Hasil Pemantauan Managemen Resiko dan Aksi Mitigasi

No	Nama	Deskripsi Risk	Jumlah kejadian	Hasil supervisi/ Pemantauan Bulan lapor	Indikator Kunci Mitigasi (kepatuhan thd SPO)	Hasil telusur
1	DrSp	Kesalahan input e-resep				
2	TTK...	LASA				
3		Tidak ada stiker Pada obat HA				
4		Terkait IFRS -Kabel tercecer tdk rapi di IFRS Risiko kebakara korslet -				
5						

Permasalahan di Instalasi Farmasi RSPHbulan...Tahun..

No	Masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Waktu

Tabel Pemantauan Harian obat (Obat yang secara Mandiri digunakan oleh Pasien) oleh Perawat

Tanggal	Nama Obat	Waktu Penggunaan	Cara Penggunaan	Keluhan/Respon Pasien	Tanda tangan Staf

Tabel..... Pengisian Kelengkapan Dokumen ERM per-DPJPdi Rawat Inap RSPH..... bulan, tahun 20.....

N O	Nama DPJP	Pengkajian Awal Medis					CPPT					Ingkasan pasien Pulang /Ringkasan medis				
		JML DRM	L	%	TL	%	JML DRM	L	%	TL	%	JML DR M	L	%	T L	%

Tabel..... Pengisian kelengkapan Dokumen ERM per-Perawat di Rawat Inap RSPH..... bulan, tahun 20.....

NO	Nama Perawat	Pengkajian Keperawatan					Askep					SBAR-TBK/konformasi				
		JML DRM	L	%	TL	%	JML DRM	L	%	TL	%	JML DRM	L	%	TL	%

Tabel.....Pengisian kelengkapan Dokumen Asuhan Farmasi per-Apoteker A di IRNA RSPH..... bulan, tahun 20.....

NO	Nama Apoteker	Pemantauan terapi Obat					Catatan Riwayat penggunaan obat					Daftar pemberian obat				
		JML DRM	L	%	TL	%	JML DRM	L	%	TL	%	JML DRM	L	%	TL	%
1.																

Tabel.....Pengisian kelengkapan Dokumen Asuhan Farmasi per-Apoteker A di IRNA RSPH..... bulan, tahun 20.....

NO	Nama Apoteker	Rekonsiliasi Obat					CPPT					Kelengkapan				
		JML DRM	L	%	TL	%	JML DRM	L	%	TL	%	JML DRM	L	%	TL	%

Asuhan Gizi

Tabel.....Pengisian kelengkapan Dokumen Asuhan Gizi per-petugas di IRNA RSPH..... bulan, tahun 20.....

NO	Nama A Gizi	Pengkajian Gizi					CPPT					Kelengkapan				
		JML DRM	L	%	TL	%	JML DRM	L	%	TL	%	JML DRM	L	%	TL	%

IGD

Tabel.....Pengisian kelengkapan Dokumen ERM per-DPJPdi IGD RSPH..... bulan, tahun 20.....

NO	Nama Dokter IGD	Triase					Pengkajian Awal Medis					Kelengkapan				
		JML DRM	L	%	TL	%	JML DRM	L	%	TL	%	JML DRM	L	%	TL	%

Permasalahan di Unit RM RSPHbulan...Tahun..

No	Masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Waktu

Tabel.... Jenis Ketidaklengkapan Pengisian di Rekam Medis oleh PP Berdasarkan Ruangan Rawat Inap Dan IGD di RSPH..... bulan...Tahun.....

NO	JENIS KESALAHAN	NAMA RUANGAN						
		RI-L3	RI L2A	RI L2B	Mater	ICU	IGD	
1	Tidak Ada Form / Form Hilang							
2	Form Kosong / Tdk Diisi							
3	Tdk Ada Ttd Dpjp / Dokter							
4	Tdk Ada Ttd Px							
5	Tdk Ada Ttd Keluarga / Saksi							
6	Tdk Ada Ttd Perawat/Bidan / Apotek							
7	Tdk Ada Ttd Petugas Lain							
8	Tdk Ada Nama Ruangan							
9	Tdk Ada Esay / Sebagian							
10	Cetakan Tdk Terbaca/ Tulisan Tdk Bs Dibaca							
11	Tdk Ada Centang / Sebagian							
12	Tdk Ada Angka							
13	Tdk Ada Tgl							
14	Tdk Ada Jam							
15	Tdk Ada Durasi							
16	Mark (○ □) Etc							
17	Id Px (Nama, Tgl Lhr, L/P, No Rm)							
18	Penggunaan Singkatan Yang Tidak Disepakati							
19	PPA Tdk Lengkap, dst sesuai banyaknya kesalahan							
TOTAL KESALAHAN								
JUMLAH BERKAS								

TabelLaporan Jumlah Setoran Harian Pengembalian DRM Bulan Tahun

NO	JUMLAH SETORAN PERTANGGAL	NAMA RUANGAN						TOTAL SETORAN RM/HR
		RI-L3	RI L2A	RI L2B	Mater	ICU	IGD	
	01-05-2022							
	Sampai 30/31 Hr/sebulan							
	Total jumlah setoran RM tepat waktu							
	RM terlambat disetor							
16	Mark (○ □) Etc							
17	Id Px (Nama, Tgl Lhr, L/P, No Rm)							

CONTOH PEMANTAUAN KEAMANAN DAN KERAHASIAAN DATA (MRMIK 2.2)

Elemen	Kriteria Kepatuhan	Metode Verifikasi	Status Kepatuhan	Tindakan Perbaikan	PIC	Batas Waktu Tindakan
Pengelolaan Akses Pengguna	Akses hanya diberikan kepada pengguna berdasarkan kebutuhan akses mereka	Audit sistem akses dan wawancara dengan admin sistem	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	Review dan modifikasi akses	Manajer IT	30 hari
Otorisasi Akses	Otorisasi akses dikelola melalui proses formal dengan dokumentasi yang jelas	Inspeksi dokumentasi otorisasi akses	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	Perbaiki prosedur otorisasi	Manajer Keamanan Informasi	30 hari
Pemantauan dan Evaluasi Akses	Semua akses ke sistem dievaluasi dan dipantau untuk memastikan kepatuhan	Pemeriksaan log akses dan kegiatan pemantauan	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	Tingkatkan pengawasan sistem	Tim Keamanan	30 hari
Pelatihan Keamanan Data	Staf dilatih mengenai keamanan data dan kebijakan privasi	Catatan pelatihan dan feedback dari peserta	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	Implementasi sesi pelatihan ulang	HR dan Tim Keamanan	Setiap tahun
Penghapusan Data dan Informasi	Data dan informasi sensitif dihapus sesuai kebijakan saat tidak lagi diperlukan	Review prosedur penghapusan dan penerapannya	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	Perbarui kebijakan penghapusan	Manajer IT	30 hari
Penanganan dan Respons Terhadap Insiden	Protokol untuk menanggapi insiden keamanan data ditetapkan dan diikuti	Simulasi insiden dan review kejadian sebenarnya	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	Revisi protokol respons insiden	Tim Keamanan	Setelah setiap insiden
Audit Keamanan Data	Audit keamanan data dilakukan secara rutin untuk memastikan kepatuhan	Jadwal audit dan temuan dari audit terakhir	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	Lakukan audit tambahan	Tim Audit Internal	6 bulan
Penyimpanan dan Transmisi Data	Semua data yang disimpan dan ditransmisikan dienkripsi	Pemeriksaan konfigurasi enkripsi	☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	Aktifkan/Perbarui enkripsi	Tim IT	30 hari

Instruksi Pengisian Matriks:

- **Kriteria Kepatuhan:** Apa yang diharapkan untuk memenuhi regulasi.
- **Metode Verifikasi:** Cara yang akan digunakan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap kriteria tersebut.
- **Status Kepatuhan (Ya/Tidak):** Apakah saat ini elemen tersebut sesuai regulasi.
- **Tindakan Perbaikan:** Langkah-langkah yang direkomendasikan jika terdapat ketidaksesuaian.
- **Penanggung Jawab:** Individu atau tim yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tindakan yang diperlukan.
- **Batas Waktu Tindakan:** Jangka waktu yang ditentukan untuk menyelesaikan tindakan yang diperlukan.

TABEL LAPORAN KINERJA PRODUKTIFITAS MARKETING & PENGADUAN
BULANAN

Tabel Piutang RSPH....Bulan... Tahun...

No.	Nama PT	tgl pelaks	Jenis Pemeriksaan					Tgl- Invoice	No.Inv
			RTAG	Swab PCR	MCU	Vaksin	LAINNYA		
1									
2									

Dilanjutkan kolom di bawah ini (sambung ke kanan)

Total (Rp)		Status Pembayaran		penagihan ke		Bukti pengiriman tagihan	Ket
Tagihan	Jml Bayar	Lunas	Belum Lunas				

b. Kerjasama RSPH

Tabel MOU atau Kerjasama RSPH Dengan Pihak LuarBulan... Tahun

No	Kelompok MOU	Jumlah	Exp < 3bln	Target MOU baru	Tercapai MOU baru	Ket
1	Asuhan Pasien/pelayanan kesehatan					
2	RS.Rujukan					
3	KSO alat					
4	Klinik peujuk					
5	Puskesmas perujuk					
6	Pemeriksaan penunjang					
7	Pelayanan R.Inap					
8	MOU Khusus					
9	dan seterusnya sesuaikan					

c. Pengaduan Pasien Dan Keluarga

NO	Nama Ruangan/unit	Petugas Yang Mendapat Komplain					
		Perawat	Dokter	Apoteker	Gizi	Pendaf- taran	lain- lain

d. Permasalahan Humas, Marketing & Pengaduan

No	Masalah	Rencana Tindak Lanjut	PIC	Waktu

CONTOH

TABEL LAPORAN KINERJA PRODUKTIFITAS INSTALASI GIZI-BULANAN

Tabel.....Porsi makan

No	Kelas Perawatan	Jumlah Porsi							Lama Dirawat
		Umum	BPJS Kes	BPJS TK	Asuransi Swasta	Jasa Raharja	Asuransi Lain	Total	
	VVIP								
	VIP								
	Kelas I								
	Kelas 2								
	Kelas 3								
	Perinatologi								
	ICU								
	Isolasi								

Tabel.....

NO	NAMA DIIT	BULAN			PROSENTASE TERHADAP BULAN SEBELUMNYA (%)
		NOVEMBER 202 JML (...%)	DESEMBER 202 JML (...%)	JANUARI 202 JML (...%)	
1.	Diabetes Melitus				
2.	Rendah Garam				
3.	Jantung				
4.	Rendah serat				
5.	TKTP				
6.	Makanan biasa				
7.	Makanan Lunak				
8.	Rendah Lemak				
9.	Rendah Protein				
10.	Bubur Halus				
11.	Cair				
12.	Rendah Purin				
13.	Tinggi Protein				
14.	Blender				
15.	Tinggi serat				
16.	Tinggi Kalium				
17.	Rendah Kalium				
18.	Rendah Sisa				
TOTAL					

Tabel.....Hasil Monitoring Sisa Makan Pasien oleh Ahli Gizi (sampel 200/bln)

No	Nama Ruang Rawat Inap	Pengambilan Sampel						Rata2
		I	2	3	4	5	6	

Tabel.....Hasil Monitoring Kepadatan Lalat dan Vektor Pengganggu dan HS

No	Monitoring	Hasil	RTL	PIC & Waktu
1	Kepadatan Lalat dan Vektor Pengganggu (lalat, tikus, kecoa)			
2	Sanitasi tiap ruang di dapur			
3	Suhu penyimpanan bahan			
4	Alur transfer alat makan pasien dari pantry ke pemorsian			
5	Suhu air cuci alat dapur (St 70)			
6	Alur pengiriman dan penerimaan bahan makanan			

Tabel.... Kinerja Konseling & KIE Gizi di RSPH Bulan.....sd.....Tahun.....

No	program	target	Nov		Des		Jan	
			jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Konsultasi IRNA							
2.	Konsultasi IRJA							
3	KIE kelompok	8x/bln						
4	KIE radio	8x/bln						
5	KIE Cetak	8x/bln						
6	KIE Medsos	8x/bln						

Asuhan Gizi Rawat Inap

Tabel.....Kinerja Ahli Gizi yang terpantau di ERM RSPH..... Bulan...
sd....Tahun.....

No	Program	Target	Nov		Des		Jan	
			jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Skreening Gizi oleh perawat	Isi dg total pasien						
2.	Skreening Gizi > 2	Berapa yg >2 dlm 1 bl, jml...(%)						
3	Pengkajian awal Gizi oleh ahli Gizi	Jml yang >2.....(%)						
4	CPPT (ADIME)	Jml =... (100%)						
5	KIE Gizi Terintegrasi (pasien & keluarga)	Jml semua pasien						
6	KIE Gizi Kolaborasi (pasien & keluarga)	Minimal 1x semua pasien						

Tabel.... Inventarisasi Alat Makan Pasien Di Rawat Inap Unit Gizi RSPH...
Bulan....Tahun....

No	Alat Makan	Target Kehilangan	Jml Total Ops	Jml Stock tersimpan	Nov		Des		Jan	
					Jml	%	Jml	%	Jml	%
1.	Sendok makan	0%								
2	Lepek kue/snack	0%								
3	Sendok tertukar	0%								
4	Garpu	0%								
	lainnya									

. Setelah tampilan tabel- grafik, analisis dan RTL lanjutkan dengan PDSA contoh PDSA sebagai berikut:

Masalah/Problem	Apa masalah yang muncul dari hasil pengukuran/tampilan data pada tabel /grafik (dari hasil analisis) Pencapaian kelengkapan DRM masih 65%
Tool-Step -cycle	Kelengkapan berkas RM lengkap 1x24 jam Sosialisasi ke PPA 1 siklus
Plan	Mengidentifikasi tahap perubahan untuk perbaikan Saya berencana menilai kelengkapan pengisian DRM setelah Pasien pulang. PPA menulis dg lengkap Harapan : Saya berharap dalam waktu 1 mg 100 DRM terisi lengkap Tindakan 1. Sosialisasi 2. Telusur 3. Dicoba selama 1 mg
Do	Menguji perubahan yang telah dilakukan (dilakukan pada sampel) Apa yg anda amati 1. PPA belum mengisi DRM dengan lengkap masih kurang TTD, Nama Ttd iam

TABEL-TABEL LAPORAN KINERJA PRODUKTIFITAS PROGRAM PKRS - BULANAN

- a. Penyuluhan Kelompok
Tabel..... Jumlah Edukasi Kelompok Yang Dilakukan Petugas Di RSPH.....
Bulan.... Tahun....

N O	RUANG/ UNIT /INSTALA SI	Kinerja PKRS (F)	%	METODE YANG DIGUNAKAN						MEDIA YANG DIGUNAKAN									
				CTJ		DEM O		RP/ Prakte k		CE TAK		ALAT PERAG A/ MODEL		Radi o/AU DIO		MED SOS		AUDIO VISUAL	
				F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			

KIE kelompok : sesuai target 1mg 2X/unit/ruang

- b. Penyuluhan Individu
Tabel..... Jumlah Edukasi Individu Yang Dilakukan Petugas Di RSPH..... Bulan...
.Tahun....

Rua ng/U nit/In stala si	JML PASIE N	STAN DARD (%)	Jumlah Kasus Yg Diinterv ensi PKRS		METODE YANG DIGUNAKAN						MEDIA YANG DIGUNAKAN							
			Frek (F) X	%	KIE		Kon se Lin g		Praktik /Demo/ Roll Play		Cetak		Alat Pera ga/ Mode l		Siaran radio/ audio		VIDEO /audiov isual	
					F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%	F	%
		100																

- c. Pembinaan Komunitas
Tabel Pembinaan komunitas Geriatri Berbasis RSPH... Bulan... Tahun....

No	Nama Komunitas Binaan	Target Pembinaan/ bln	Jenis Kegiatan Pembinaan				
			Senam /OR	Pemerik- Saan/ MCU	Edukasi/ seminar	Ketram- Pilan/Game /Lomba	Keaga maan
1							
2							
3							

- d. Peringatan Hari-hari besar
e. Hasil pengukuran Mutu komunikasi & Edukasi:
1).SBAR (kelengkapan Lembar RM) ;5) Konsultasi DPJP (kelengkapan konformasi)
2) HO (kelengkapan Konformasi) ;6) KIE menjelang akhir kehidupan
3) Edukasi terintegrasi (kelengkapan Lembar RM) 7) Lembar Riwayat (kieshar-thk)

CONTOH
LAPORAN HASIL PENUGASAN



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

LAPORAN HASIL PENUGASAN
.....

1	Umum/Latar belakang	misalnya ada undangan dari Dinkes atau Instansi yang lain
2	Dasar Hukum /Regulasi	1 2
3	Instansi/Lembaga yang dituju dan alamat	
4	Maksud dan Tujuan perjalanan dinas	1 2 3
5	Bertemu dengan	1 2 3
6	Hadir dalam pertemuan	1 2 3
7	Nara Sumber/Pemateri /Pemimpin pertemuan	1 2 3
8	Materi yang dibahas	1 2 3
9	Evaluasi aplikasi materi yang dibahas dengan yang kita aplikasikan di tempat kerja	sesuai materi/teori/standard
		apa yang sudah diaplikasikan di tempat kerja kita
10	Kesimpulan	
11	Saran	
12	Jumlah Lampiran jika ada	

....., tanggal –bln- tahun
Nama Jabatan pembuat laporan

Tanda Tangan dan Stempel

Nama Lengkap



CONTOH
DAFTAR HADIR



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

DAFTAR HADIR

(manual bisa dengan elektronik menggunakan barcode)

HARI / TANGGAL :
PUKUL/JAM :
ACARA :
TEMPAT :

NO	NAMA	JABATAN/UNIT/INSTANSI	TTD
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
dst			

....., tanggal –bln- tahun
Pemimpin Rapat/Jabatan

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Pada kolom Jabatan/Unit bisa diganti Alamat/Instansi disesuaikan dengan kebutuhan acara

3.5. Telaahan Staf

1) Pengertian

Telaahan staf adalah bentuk uraian yang disampaikan oleh pejabat atau staf yang memuat analisis singkat dan jelas mengenai suatu persoalan dengan memberikan jalan keluar / pemecahan yang disarankan.

2) Susunan

1. Kepala

Bagian kepala telaahan staf terdiri dari:

- a. judul telaahan staf diletakkan secara simetris ditengah atas; dan
- b. uraian singkat tentang permasalahan.

2. Batang Tubuh

Bagian batang tubuh telaahan staf terdiri dari:

- (1) Persoalan, yang memuat pernyataan singkat dan jelas tentang persoalan yang akan dipecahkan;
- (2) Praanggapan, yang memuat dugaan yang beralasan, berdasarkan data yang ada, saling berhubungan sesuai dengan situasi yang dihadapi, dan merupakan kemungkinan terjadi di masa yang akan datang;
- (3) Fakta yang mempengaruhi, yang memuat fakta yang merupakan landasan analisis dan pemecahan masalah;
- (4) Analisis pengaruh praanggapan dan fakta terhadap persoalan dan akibatnya, hambatan serta keuntungan dan kerugiannya, pemecahan atau cara bertindak yang mungkin atau dapat dilakukan;
- (5) Simpulan, yang memuat intisari hasil telaahan, yang merupakan pilihan cara bertinfak atau jalan keluar; dan
- (6) Tindakan yang disarankan, yang memuat secara ringkas dan jelas saran atau usul tindakan untuk mengatasi persoalan yang dihadapi.

3. Kaki

Bagian kaki telaahan staf ditempatkan di sebelah kanan bawah, yang terdiri dari:

- (1) Nama jabatan pembuat telaahan staf, ditulis dengan huruf awal kapital (bold);
- (2) Tanda tangan;
- (3) Nama lengkap dan cap dinas (jika ada; sesuai peruntukan stempel)
- (4) Daftar lampiran (jika diperlukan).

CONTOH
FORMAT TELAAHAN STAF



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

TELAAHAN STAF
TENTANG

.....

I. Persoalan atau Masalah

.....
.....
.....

II. Praanggapan

.....
.....
.....

III. Fakta yang mempengaruhi (fakta yang dilihat saat input/proses/output apa)

.....
.....
.....

IV. Analisis

.....
.....
.....

V. Kesimpulan

.....
.....
.....

VI. Saran/RTL

.....
.....
.....

.....,
Nama Jabatan Pembuat Telaahan Staf,

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Daftar lampiran

1.
2.

3.6. Sertifikat dan Piagam Penghargaan

- 1) Pengertian
Sertifikat adalah surat penghargaan atau surat keterangan tertulis yang tercetak dan dikeluarkan oleh instansi dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai bukti telah mengikuti suatu kegiatan atau telah memenuhi standar / prosedur / syarat yang ditetapkan.
- 2) Wewenang Penandatanganan
 - a. Sertifikat ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya.
 - b. Jika bekerjasama dengan Pihak lain maka tanda tangan pihak yang diajak kerjasama juga dicantumkan
- 3) Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan ditambahkan

Tata naskah dinas untuk sertifikat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan situasional sesuai kebutuhan (*design* bebas).

CONTOH SERTIFIKAT BAGIAN DEPAN DAN BELAKANG



Pencetakan lembar belakang apabila diperlukan (contoh Diklat), yang tandatangan adalah Nara Sumber pada kegiatan tersebut.

3.7. Surat Peringatan

Bentuk dan susunan surat peringatan adalah sebagai berikut.

1) Kepala

Bagian kepala memuat hal-hal berikut.

- a. Menggunakan kertas surat dengan kop surat berlogo
- b. Tulisan surat peringatan pada bagian tengah margin di bawah logo Rumah Sakit, ditulis dengan huruf kapital
- c. Nomor surat peringatan ditulis di bawah tulisan surat peringatan
- d. staf yang memberikan peringatan dituliskan di bawah nomor surat, di tengah margin.

2) Batang Tubuh

Batang tubuh memuat hal-hal berikut.

- a. Pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar dikeluarkannya surat peringatan, dalam rumusan:
 - ☐ Menimbang
 - ☐ Mengingat
 - ☐ Memperhatikan
 - ☐ Memutuskan
 - ☐ Menetapkan memberikan peringatan ke..
- b. Karyawan yang diberikan peringatan, dengan identitas nama, nomor induk karyawan, dan unit kerja
- c. Sanksi apabila yang bersangkutan tidak mematuhi apa yang diperingatkan.

3) Kaki

Sebelah kanan bawah berisi

- a. Tempat dan tanggal dibuat surat peringatan
- b. Tanda tangan staf yang memberi peringatan
- c. Nama jelas penanda tangan yang memberi peringatan
- d. Stempel dinas,

Sebelah kiri bawah sejajar dengan sebelah kanan bawah berisi:

- a. Penerima peringatan
- b. Tanda tangan penerima peringatan
- c. Nama jelas karyawan yang diberi peringatan

Tembusan ditulis di sebelah kiri bawah dengan jarak 2 spasi di bawah nama penerima peringatan

3.8. Notulen

Bentuk dan susunan Notulen menggunakan format sebagai berikut, jika Notulen lebih dari satu lembar, tanda tangan pimpinan rapat dan notulis hanya pada lembar paling akhir, lembar notulen lain dibubuhkan paraf notulis.

CONTOH
FORMAT NOTULEN RAPAT



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

NOTULEN RAPAT

Hari /Tanggal : Pimpinan Rapat :
Jam/Pukul : Notulis :
Acara : Tempat :
Berikut hasil notulen :

No	TOPIK/ BAHASAN	PEMBAHASAN	KESIMPULAN DAN / RTL	PIC	WAKTU

Menyetujui,
Pimpinan Rapat

(.....)

Notulis,

(.....)

3.9. Naskah Dinas lain

3.9.1. Term Oh Reference (TOR) atau Kerangka Acuan Kerja (KAK)

1) Pengertian

TOR atau KAK adalah naskah dinas yang memuat tentang perencanaan program tertentu sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan suatu kegiatan /program tersebut.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat / staf yang diberi tugas. TOR/KAK ditandatangani oleh pejabat / staf yang disertai tugas.

3) Susunan

a) Sampul/Cover

Bagian Sampul TOR terdiri dari :

- (1) Judul TOR/KAK ditulis dengan huruf kapital (bold) yang diletakan secara simetris;
- (2) Bulan dan tahun, ditulis dengan huruf kapital (bold) secara simetris;
- (3) Logo Rumah Sakit Prima Husada
- (4) Nama, alamat, nomor telepon, email dan website Rumah Sakit Prima Husada ;

b) Isi TOR/KAK/Proposal

Bagian Isi TOR terdiri dari :

- 1) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum atau latar belakang, maksud, dan tujuan, dasar hukum serta ruang lingkup dan sistematikaTOR , disesuaikan dengan kegiatan yang akan dibuat;
- 2) Materi TOR, yang terdiri dari rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, tanggal, tempat, waktu,, kepanitiaan, peserta, Nara sumber, schedule/susunan acara, media yang digunakan, metode yang dipilih, kebutuhan anggaran, rencana rapat panitia penyelenggara sebelum pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi, monitoring evaluasi, dan hal lain yang perlu direncanakan sesuai dengan kegiatannya,
- 3) Monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk kegiatan berikutnya agar lebih baik, bisa dibuat notulen proses pelaksanaan kegiatan, bisa pre,pos tes, atau yang lain sesuai kebutuhan.
- 4) Penutup, yang merupakan akhirTOR, memuat harapan / permintaan arahan / ucapan terima kasih.

c.) Kaki

Bagian kaki TOR terdiri dari:

- 1) Tempat dan tanggal pembuatan
- 2) Nama jabatan pejabat pembuat, ditulis dengan huruf awal kapital;
- 3) Tanda tangan; dan
- 4) Nama lengkap, ditulis dengan huruf awal capital dan setiap unsurnya
- 5) Tannda tangan pejabat yang lebih tinggi berada di kiri tanda tangan pembuat TOR dan pejabat yang paling tinggi (Direktur) ada di tengah bawah sendiri

CONTOH
TERM OF REFERENCE (TOR)



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

**TERM OF REFERENCE (TOR)
SEMINAR/WORKSHOP/GATHERING/DIKLAT/PERTEMUAN.....
TAHUN....**

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang/alasan perlunya acara tersebut:
- 1.2. Dasar Hukum (regulasi yang umum dan yang terkait dengan judul)
- 1.3. Maksud dan Tujuan (TIU: Tujuan Instruksional Umum; TIK :Tujuan Instruksional Khusus).
 - A. Maksud
 - B. Tujuan :
 - a.TIU :
 - b.TIK :

II.RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

- 2.1. Susunan Panitia (lengkapi dengan tugasnya)
- 2.2. Rencana Rapat Panitia Penyelenggara (hari, tgl, jam, tempat)
- 2.3. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Frekwensi,hari, tgl, jam, tempat)
- 2.4. Sasaran Atau Peserta (siapa ? jumlah berapa dirinci dan ditotal)
- 2.5. Nara Sumber/Pemateri (nama NS, materi apa? Berapa lama)
- 2.6. Susunan Acara lengkap (lengkapi dengan no, acara, jam, PIC, petugasnya)
- 2.7. Media (alat perlengkapan yang digunakan)
- 2.8 . Metode (ceramah tanya jawab, diskusi kelompok, FGD, Simulasi, Demonstrasi, Rollplay, Game, dll)
- 2.9. Kebutuhan Anggaran (Jika tidak ada anggaran isi dengan angka 0)

III. MONITORING-EVALUASI

- 3.1. Monitoring : (proses dalam kegiatan/durante acara)
- 3.2. Evaluasi : (pre dan post kegiatan disesuaikan dengan kegiatan jika ada praktek lakukan penilaian saat praktek) Jika diklat/sosialisasi lakukan evaluasi juga paska Diklat/aplikasi keseharian.

IV.PENUTUP

Mengetahui
Kepala Bidang/Bagian

TTD
Nama Lengkap

Disetujui oleh
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

.....
TTD

Nama Lengkap

....., tanggal –bln- tahun

Ketua Panitia/Tim/pengelola
Program/dll

TTD
Nama Lengkap

KETERANGAN (TOR DIKLAT BAGI KARYAWAN RSPH

- 1.1 Latar belakang :
- 1) Isikan alasan perlunya acara tersebut:

2) Tampilkan data kasus terkait judul di RS Prima Husada, bila data tidak lengkap, dapat menampilkan temuan kasus-kasus /IKP, fakta pentingnya acara diadakan.

3) Munculkan fakta-fakta riil di lapangan terkait ketidaksesuaian temuan kasus contoh :

pasien stunting ditulis normo weight, temuan kasus 30% tidak dilakukannya screening gizi dengan benar
- 1.2. Dasar Hukum (regulasi yang umum dan yang terkait dengan judul)
- 1.3. Maksud dan Tujuan (TIU Tujuan Instruksional Umum; TIK :Tujuan Instruksional Khusus). Sesuaikan dengan jumlah materi yang akan diajarkan.
- Contoh misalnya Diklat “Manajemen Stunting & Wasting di RS. Prima Husada”
- a.TIU : Semua pasien anak dan bayi di RSPH dilakukan pengukuran BB TB dengan sarana prasarana memadai, baik oleh perawat / bidan / dokter.

b. TIK : jika sasaran pesertanya dokter maka

1). Peserta terampil melakukan pengukuran BB / TB dengan tepat dan akurat dengan berbagai cara dan alat.

2). Peserta terampil menggali keluhan/melakukan anamnesis terkait stunting & Wasting dari ibu/keluarganya/yang merawat pasien.

3). Peserta terampil mengisi rekam medis dengan benar dan lengkap

3). Peserta dapat bekerja secara terintegrasi dengan PPA lain sebagai tim dalam memberikan asuhan pasien stunting & Wasting.

4) Peserta terampil dalam memberikan Informasi dan Edukasi kepada keluarga dengan komunikasi efektif sesuai bahasanya.

2.1 Susunan Panitia Diklat

No	Susunan Panitia	Nama Staf yang menjabat	Tugas & tanggungjawab
1.	Ketua	PJ.Bab/ Program/ Komite/Tim	Bertanggungjawab terhadap keberlangsungan Training dari perencanaan sd evaluasi Membuat TOR Membuat Laporan Mengumpulkan UMANDOK Mengarsipkan UMANDOK asli
2.	Sekretaris	Nama B	Melakukan semua pekerjaan administrasi acara: Pembuatan Undangan; Pembuatan SK Panitia; Pengajuan ke Direktur RS, PT.DPM; Pembuatan Daftar hadir, Notulensi acara.
3.	Bendahara	Keuangan PT.DPM	Bertanggungjawab terhadap anggaran Diklat yang dibutuhkan/diusulkan/ disetujui
4.	MC	SDM	Mengatur keberlangsungan acara
5.	Moderator	SDM	Mengarahkan, mengatur, membatasi NS dan peserta agar tetap dalam jalur bahasan NS sesuai Topik/materi.
6.	IT	IT	Mempersiapkan sound system dan laptop serta LCD, mengatur, mensetting, menatakan operator
7.	Dokumentasi	SDM	Tiap acara diambil untuk dokumentasi laporan cukup 2 saja. Ambil video 1’ untuk lg/Tiktok
8.	Absensi/penerima undangan	SDM	Bisa elektronik atau manual sesuai peserta Membagikan konsumsi, Kuis, angket, dll.mengarahkan peserta menuju tempat duduk.

9.	Perlengkapan	CS	Membersihkan, merapikan menata /setting ruangan.
10.	Instruktur	Nama A Nama B Nama C Nama D	Membantu NS dalam melakukan Praktek/ Rollplay/Simulasi/Demonstrasi/FGD/game dan metode lainnya.
11.	Pemantau/ pengawas	SDM	Mengawasi jalannya acara Membuat penilaian kekurangan/masalah saat acara berlangsung baik untuk peserta maupun Nara Sumber kekurangannya apa nanti dipakai bahasan saat evaluasi selesai acara/rapat

2.2. Rencana Rapat Panitia Penyelenggara

Rapat : Pre Training : materi / bahasan saat rapat awal calon panitia penyelenggara			
No	Bahasan dan kegiatan	PJ	Yang terlibat/yang masuk Panitia
1	Mendiskusikan materi yang akan diberikan untuk training (materi berdasarkan outline training)	SDM	Semua yang terkait Tim/Komite/PJ Program/PJ Bab dan yang harus dilibatkan
2	Pembuatan soal pre/post test & kunci jawaban Penilaian Praktek oleh instruktur kompeten kalau perlu dilakukan TOT lebih dulu	SDM	
3	Tentukan siapa NS yang harus membuat PPT berdasarkan kisi-kisi materi yang sudah didiskusikan.	SDM	Panitia Narasumber
4	Pengumpulan PPT materi maksimal H-7 acara	SDM	Narasumber
5	Menentukan moderator training (pilih SDM yang menguasai program tsb atau yang bisa mengendalikan acara bisa dirangkap MC)	SDM	Kabid Yan Med / PT / Ketua Komite
6	Menyusun panitia (MC merangkap dokumentasi, IT sebagai operator)	SDM	Tim/Komite/PJ Program /PJ Bab akre,keuangan,
7	Membuat /membahas Form Evaluasi untuk penyelenggara untuk Nara Sumber	SDM	Tim/Komite/PJ Program /PJ Bab akre,dll
8	Media apa saja yang perlu disiapkan, metode nya yang akan dipilih dan disiapkan agar Diklat berjalan sesuai tujuan dan harapan	SDM	Tim/Komite/PJ Program /PJ Bab akre, dll ,
9	Penyusunan SLIDE HOST (PPT yang ditampilkan sejak awal mulai dari absensi, pre test, rundown, ppt materi, post test dijadikan 1 kesatuan)	SDM	Panitia

3.1. Monitoring : (proses dalam kegiatan/durante acara)			
No	Bahasan dan kegiatan	PJ	Yang terlibat/yang masuk Panitia
1	Memastikan training berjalan sesuai TOR dan rundown	SDM	PJ Training
2	Mencatat evaluasi yang ditemukan selama training berjalan	SDM	PJ Training, Ketua Komite terkait

3	Memimpin evaluasi setelah training/diklat selesai.	SDM	PJ Training, Ketua Komite terkait
4	Mengirimkan link g-form evaluasi yang diisi oleh narasumber/peserta.	SDM	Narasumber
5	Menyiapkan kredensial apabila materi training ada sesi praktek / role play dan metode lainnya.	SDM	Ketua Komite terkait
3.1. Evaluasi (Post Training) jangka pendek			
1	Merekapitulasi hasil nilai pre test post test dan praktek dan dibahas sebagai evaluasi apakah sesuai target? Ataukah ada yang perlu mengulang.	SDM	panitia
2	Melakukan evaluasi hasil penilaian baik untuk penyelenggara maupun untuk nara sumber dan pengamatan perilaku peserta saat Diklat (serius, mengantuk, antusias)	SDM	Panitia
3	Menerbitkan sertifikat	SDM	SDM
4	Evaluasi kinerja panitia	SDM	Panitia
Evaluasi (Post Training) jangka Panjang saat sudah diaplikasikan			
1	Melakukan supervisi atau observasi kepatuhan peserta Diklat terhadap regulasi dan materi-materi dalam diklat yang sudah diikuti. (apakah staf sudah terampil sesuai Goal/outcome yang diharapkan dari pelaksanaan Diklat?)	SDM	SDM dan Tim/Komite/PJ Program /PJ Bab akre, dll ,
2	Hasil tersebut di no.1 dibahas di rapat koordinasi	SDM	SDM dan Tim/Komite/PJ Program /PJ Bab akre, dll ,
3	Buat RTL-TL-Evaluasi terus menerus	SDM	SDM dan Tim/Komite/PJ Program /PJ Bab akre, dll ,

b. Feasibility Studi (FS) atau Study Kelayakan (SK)

1) Pengertian

FS/SK adalah naskah dinas yang memuat tentang perencanaan program tertentu yang akan dikembangkan sebagai bahan atau dasar pertimbangan atas kelayakan alat atau program yang akan dikembangkan serta peluang keberhasilan jika dikembangkan atau dilaksanakan atau diadakannya alat tsb sebagai penunjang program pengembangan pelayanan.

2) Wewenang Pembuatan dan Penandatanganan

Wewenang pembuatan laporan dilakukan oleh pejabat / staf yang diberi tugas. FS/SK ditandatangani oleh pejabat /staf yang diserahi tugas/ketua Tim.

3) Susunan

a) Sampul/Cover

Bagian Sampul SK terdiri dari :

- 1) Judul FS/SK ditulis dengan huruf kapital (bold) yang diletakan secara simetris;
- 2) Bulan dan tahun, ditulis dengan huruf kapital (bold) secara simetris;
- 3) Logo Rumah Sakit Prima Husada
- 4) Nama, alamat, nomor telepon, email dan website Rumah Sakit Prima Husada

b) Isi FS/SK

Bagian Isi FS/SK terdiri dari :

- 1) Pendahuluan, yang memuat penjelasan umum atau latar belakang, maksud, tujuan, dan dasar hukum dan sistematika, disesuaikan dengan kegiatan yang akan dibuat;
- 2) Materi FS/SK, yang terdiri dari data-data pendukung pentingnya kegiatan yang akan dilaksanakan, Analisis TWOS, dan hasilnya, factor yang mempengaruhinya, pengajuan 3 vendor yang telah presentasi dihadapan Tim HTA dan kesimpulan hasil presentasi vendor (kelebihan kekurangan, spek yang diusulkan), analisis keuangan termasuk harga jual dan BEP, rencana maintenance, monitoring evaluasi, dan hal yang perlu sesuai dengan kegiatan yang dikembangkan,
- 3) Monitoring dan evaluasi kegiatan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk kegiatan berikutnya agar lebih baik,
- 4) Penutup, yang merupakan akhir FS/SK, memuat harapan / permintaan arahan / ucapan terima kasih.

c.) Kaki

Bagian kaki FS/SK terdiri dari:

- 1) Tempat dan tanggal pembuatan
- 2) Nama jabatan pejabat pembuat, ditulis dengan huruf awal kapital;
- 3) Tanda tangan; dan
- 4) Nama lengkap, ditulis dengan huruf awal capital dan setiap unsurnya

CONTOH
FEASIBILITY STUDY/STUDY KELAYANAN



**FEASIBILITY STUDY/STUDY KELAYANAN
PENGUSULAN BARANG/ALDOK/ALKES/ALAT LAIN
(JUDUL.....)
TAHUN...**

I. LATAR BELAKANG

(dari gambaran besar ke kecil / dari nasional/daerah/local ke RSPH)

II. DASAR HUKUM

(dasar hukum terkait regulasi yang mendukung)

III. MAKSUD DAN TUJUAN

IV. ANALISA SITUASI

(berisi data-data yang mendukung perlunya pengembangan program tsb dalam bentuk narasi, tabel, grafik lengkap dengan analisisnya)

V. ANALISIS TWOS

(yaitu dengan melihat faktor eksternal perusahaan threats dan opportunity kemudian diikuti dengan melihat faktor internal perusahaan weakness dan strengths .

VI. PENILAIAN VENDOR

(Pilih 3 vendor yang telah presentasi di hadapan tim HTA tabulasi kelebihan dan kekurangannya secara lengkap termasuk spek,utilisasi after selling, sewa atau beli, diklat, uji fungsi, perijinan, kalibrasi dan lain-lain), bandingkan dengan standard.

VII. ANALISIS KEUANGAN

(termasuk kapan BEP, harga jual/tsrip nanti berapa, dll, terkait pembelian atau KSO)

VIII.KESIMPULAN DAN SARAN

Mengetahui
Kepala Bidang/Bagian

TTD
Nama Lengkap

....., tanggal –bln- tahun

Ketua Panitia/Tim/pengelola
Program/dll

TTD
Nama Lengkap

Disetujui oleh
Direktur Rumah Sakit Prima Husada

.....
TTD

Nama Lengkap

BAB IV PENYUSUNAN NASKAH DINAS

4.1. Prinsip

Penyusunan naskah dinas memperhatikan prinsip :

- 1) Kejelasan berarti harus memperhatikan aspek fisik dan materi.
- 2) Ketelitian berarti harus sesuai dengan bentuk, susunan, pengetikan, isi, struktur dan kaidah bahasa.
- 3) Tepat dan akurat berarti mengemukakan dalam naskah dinas adalah fakta yang benar.
- 4) Singkat dan padat, berarti harus menggunakan bahasa Indonesia yang formal, efektif, singkat, dan lengkap.
- 5) Logis dan meyakinkan berarti naskah yang disusun harus runtut dalam penuangan gagasan ke dalam naskah dinas dan dilakukan menurut urutan yang logis dan meyakinkan sehingga mudah dipahami oleh penerima naskah dinas.
- 6) Pembakuan naskah sesuai dengan peraturan berarti naskah yang disusun harus mengikuti aturan yang berlaku.

4.2. Langkah dan Ketentuan Penyusunan

4.2.1. Penyusunan Konsep

Setiap Naskah Dinas yang akan ditindaklanjuti wajib dilakukan dengan penyusunan konsep yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Konsep Naskah Dinas disusun/disiapkan oleh staf dengan menggunakan verbal konsep.
- b. Setiap verbal konsep yang diajukan kepada pimpinan wajib terlebih dahulu diteliti oleh staf setingkat di atasnya mengenai:
 - 1) Redaksi, sesuai dengan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar; dan
 - 2) Bentuk, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Konsep Naskah Dinas dicetak di balik verbal, jika konsep Naskah Dinas lebih dari satu halaman dapat menggunakan lembar berikutnya.

4.2.2. Tembusan

Tembusan surat bagian ini dicantumkan disebelah kiri bawah, yang menunjukkan bahwa pihak tersebut perlu mengetahui isi surat tersebut.

4.2.3. Lampiran

Jika naskah memiliki beberapa lampiran, setiap lampiran harus diberi nomor urut dengan angka Arab. Nomor halaman lampiran merupakan nomor lanjutan dari halaman sebelumnya.

4.3. Penggunaan Kertas

Ukuran dan jenis kertas

1) Ukuran

Untuk keseragaman tata naskah dinas, ukuran kertas yang digunakan sebagai berikut:

- a) Naskah dinas arahan menggunakan kertas F4 yang berukuran 210 x 330 mm(8,5 x 13 inci)
- b) Naskah dinas korespondensi menggunakan kertas F4 yang berukuran 210 x 330 mm(8,5 x 13 inci)
- c) Naskah dinas khusus menggunakan kertas :
 - (1) Perjanjian kerjasama, surat kuasa berita acara menggunakan kertas : A4 yang berukuran 210 x 297 mm (8,27 x 11,69 inci);
 - (2) Pengumuman, surat pengantar, surat keterangan menggunakan kertas F4 yang berukuran 210 x 330 mm(8,5 x 13 inci)
- d) Laporan menggunakan kertas F4 yang berukuran 210 x 330 mm(8,5 x 13 inci)
- e) Telaahan staf menggunakan kertas F4 yang berukuran 210 x 330 mm(8,5 x 13 inci)

2) Jenis kertas

- a) Untuk naskah dinas, digunakan jenis kertas HVS putih 70 gram.
- b) Untuk sertifikat dipilih lebih tebal

4.4. Tata Cara Penulisan

- 1) Bentuk Huruf (*fonts*)
Setiap tulisan naskah dinas menggunakan huruf Arial ukuran 11 (sebelas) dan spasi 1,15 (satu koma lima belas).
- 2) Ruang Tepi (*Margin*)
Demi keserasian dan kerapian (estetika) dalam penyusunan naskah dinas, diatur supaya tidak seluruh permukaan kertas digunakan secara penuh. Oleh karena itu, perlu ditetapkan batas antara tepi kertas dan naskah, baik pada tepi atas, kanan, bawah, maupun pada tepi kiri sehingga terdapat ruang yang dibiarkan kosong.

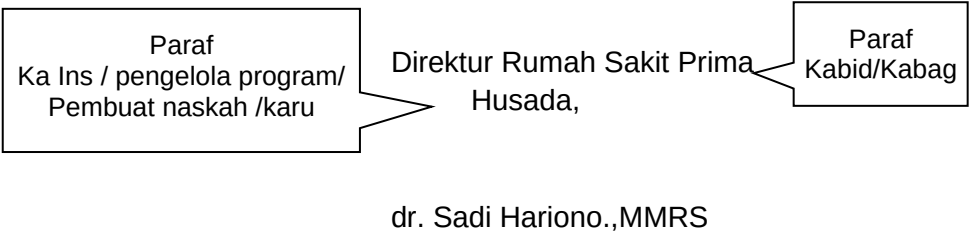
- (1) Naskah Dinas
 - a) Ruang tepi atas: apabila menggunakan kop naskah dinas, 2 spasi di bawah kop, dan apabila tanpa kop naskah dinas, sekurangkurangnya 2 cm dari tepi atas kertas;
 - b) Ruang tepi bawah : sekurang – kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;
 - c) Ruang tepi kiri : sekurang – kurangnya 3,5 cm dari tepi kiri kertas;
 - d) Ruang tepi kanan : sekurang – kurangnya ,2 cm dari tepi kanan kertas.
- (2) Regulasi
 - a) Ruang tepi atas : sekurang – kurangnya 2,5 cm dari tepi atas kertas;
 - b) Ruang tepi bawah : sekurang – kurangnya 2,5 cm dari tepi bawah kertas;
 - c) Ruang tepi kiri : sekurang – kurangnya 3,5 cm dari tepi kiri kertas;
 - d) Ruang tepi kanan : sekurang – kurangnya 2 cm dari tepi kanan kertas.

Catatan :
Dalam pelaksanaannya, penentuan ruang tepi seperti tersebut di atas bersifat fleksibel, disesuaikan dengan banyak atau tidaknya isi suatu naskah dinas. Penentuan ruang tepi (termasuk juga jarak spasi dalam paragraph) hendaknya memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

- 3) Pembubuhan Paraf
Naskah akhir terlebih dahulu diteliti dan diparaf oleh pejabat setingkat di bawah pejabat penanda tangan di akhir nama jabatan. Selanjutnya pejabat dua tingkat di bawah pejabat penandatanganan memberikan paraf di awal nama jabatan. Naskah akhir (net) Naskah dinas dibuat menjadi dua rangkap, dengan pembubuhan paraf ditempatkan pada lembar naskah dinas pertama.

Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada pembubuhan paraf dilakukan oleh kepala bidang atau kepala bagian terkait di akhir nama jabatan penandatanganan dan Kepala Instalasi /karu/pengelola program/pembuat naskah di awal nama jabatan penandatanganan.

Contoh:



- 4) Warna Tinta
Tinta yang digunakan untuk penulisan surat berwarna hitam, dan untuk warna tanda tangan yang digunakan dalam pembubuhan paraf dan tanda tangan berwarna hitam.
- 5) Peletakan Tanda Tangan jika lebih dari 1 pejabat

Naskah akhir terlebih dahulu diteliti dan diparaf oleh pejabat setingkat di bawah pejabat penanda tangan di akhir nama jabatan. Selanjutnya pejabat dua tingkat di bawah pejabat penandatanganan memberikan paraf di awal nama jabatan. Naskah akhir (net) Naskah dinas dibuat menjadi dua rangkap, dengan pembubuhan paraf ditempatkan pada lembar naskah dinas pertama.

- 6) Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada penambahan tanda tangan Kabid/Kabag diletakkan di sebelah kiri dari tanda tangan pengelola program atau Kepala Instalasi /karu//pembuat naskah/ketua terkait program .

Contoh:

Mengetahui Kabid/Kabag TTD Nama lengkap	Ka Ins / pengelola program/ Pembuat naskah /karu TTD Nama lengkap
--	--

Disetujui oleh
Direktur Rumah Sakit Prima
Husada,

Nama terang & stempel

- 7) Penulisan Alamat Surat
- a. Penulisan alamat dalam naskah dinas dibawah Kepada Yth.
Contoh Surat Eksternal :
Kepada Yth.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Jalani No., Kecamatan..... Kab/Kota.....
- b. Penulisan nama jabatan di alamat surat dan amplop tidak menggunakan sebutan bapak atau ibu.
- c. Untuk perhatian (u.p.) digunakan atau ditujukan kepada seseorang atau pejabat teknis yang menangani suatu kegiatan atau suatu pekerjaan tanpa memerlukan kebijakan langsung dari pimpinan pejabat yang bersangkutan.

Contoh penggunaan u.p.:
Kepada Yth.
Dinas Kesehatan Kabupaten
u.p. Bagian Sumber Daya Manusia

- 8) Ketentuan Jarak Spasi, serta Kata Penyambung
- Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian, estetika, banyaknya isi Naskah Dinas dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Jarak antara judul dan isi adalah dua spasi.
 - 2) Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan baris kedua adalah satu spasi.
 - 3) Jarak masing-masing baris disesuaikan dengan keperluan.

- 9) Kata Penyambung
- Kata penyambung adalah kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya (jika naskah lebih dari satu halaman). Kata penyambung ditulis pada akhir setiap halaman pada baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman dengan urutan kata penyambung dan tiga buah titik. Kata penyambung itu diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya. Jika kata pertama dari halaman berikutnya menunjuk pasal atau diberi garis bawah atau

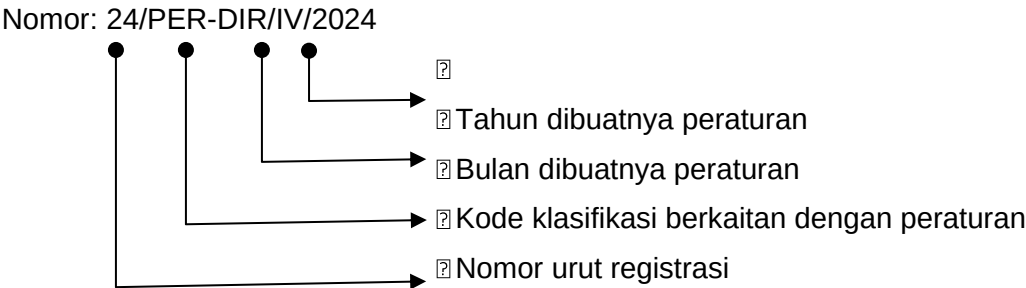
dicetak miring, kata penyambung juga harus dituliskan sama. Kata penyambung tidak digunakan untuk pergantian bagian.

4.5. Registrasi Dan Penomoran Naskah Dinas

Naskah yang telah disetujui harus diregistrasi dan diberi nomor surat dan tanggal. Registrasi naskah merupakan segmen penting dalam tata berkas, sehingga dapat disusun berdasarkan kronologis pemberkasan dan memberikan kemudahan menemukan kembali jika dilakukan pencarian arsip. Penomoran naskah dikoordinir oleh sekretariat Rumah Sakit, sesuai dengan kodifikasi dan penomoran yang berlaku di RS BAKTI KARS. Penomoran naskah adalah sebagai berikut.

1) Nomor Peraturan Direktur

- a. Nomor ditulis lengkap bukan singkatan dengan huruf awal kapital, diberi titik dua tanpa spasi
- b. Nomor urut registrasi
- c. Kode klasifikasi yang berkaitan dengan peraturan ditulis PER-DIR
- d. Bulan dibuatnya peraturan ditulis dengan angka romawi
- e. Tahun dibuatnya peraturan, pada akhir angka tidak diberi titik
- f. Di antara nomor, kode, bulan, dan tahun diberi garis miring tanpa spasi
- g. Contoh:

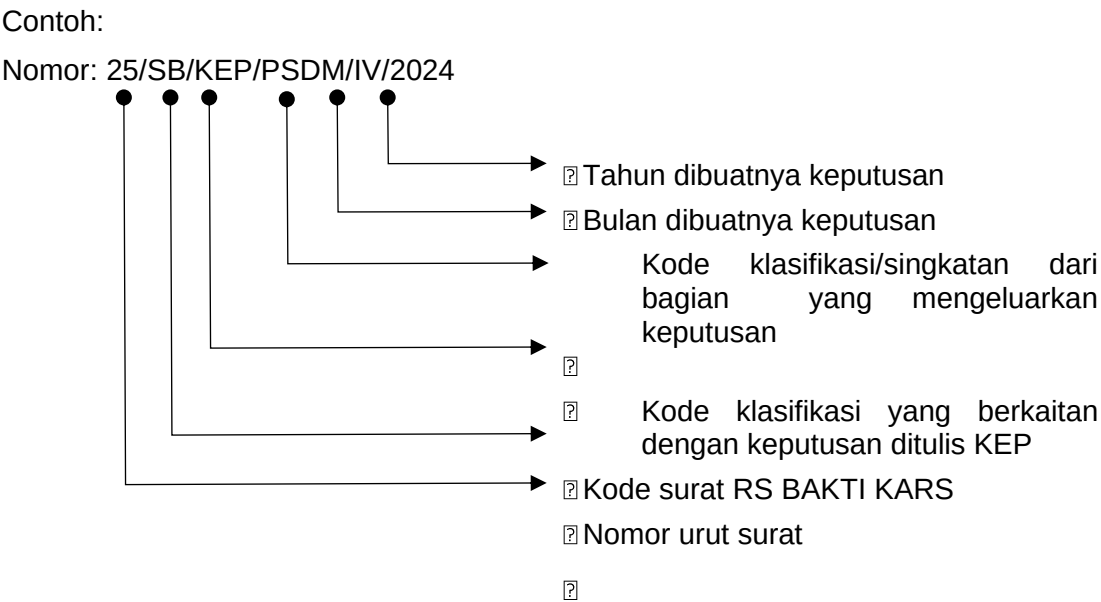


2) Nomor Surat Keputusan Direktur

- a. Nomor ditulis lengkap bukan singkatan dengan huruf awal kapital, diberi titik dua tanpa spasi
- b. Nomor urut surat
- c. Kode keputusan yang dikeluarkan Direktur RS BAKTI KARS ditulis BK
- d. Kode klasifikasi yang berkaitan dengan keputusan ditulis KEP
- e. Kode klasifikasi atau singkatan bagian dari mana asal keputusan atau surat dikeluarkan, ditulis singkatan dengan huruf kapital.
- f. Bulan dibuatnya peraturan ditulis dengan angka romawi
- g. Tahun dibuatnya peraturan, pada akhir angka tidak diberi titik
- h. Di antara nomor, kode, bulan, dan tahun diberi garis miring tanpa spasi
- i. Daftar klasifikasi dan singkatan bagian atau tim/panitia/pokja

Bagian	Singkatan	Bagian	Singkatan
Administrasi Umum	ADUM	Komite Keperawatan	KOMKEP
Keuangan	KEU	Komite Tenaga Kesehatan Lain	KOMKES
Pengembangan Sumber Daya Manusia	PSDM	Keselamatan & Kesehatan Kerja	K3
Keperawatan	YANKEP	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	PPI
Penunjang Medis	JANGDIS	Promosi Kesehatan RS	PKRS

Penunjang Umum	JANGUM	Tata Kelola RS	TKRS
Pelayanan Medis	YANMED	Pendidikan dalam Pelayanan Kesehatan	PPK
Satuan Pemeriksa Internal	SPI	Program Nasional	PROGNAS
Komite Mutu	MUTU		
Komite Medik	KOMDIK		



- 3) Nomor Surat Korespondensi Dari Direktur
- a. Nomor urut surat ditulis lengkap bukan singkatan dengan huruf awal kapital, diberi titik dua tanpa spasi.

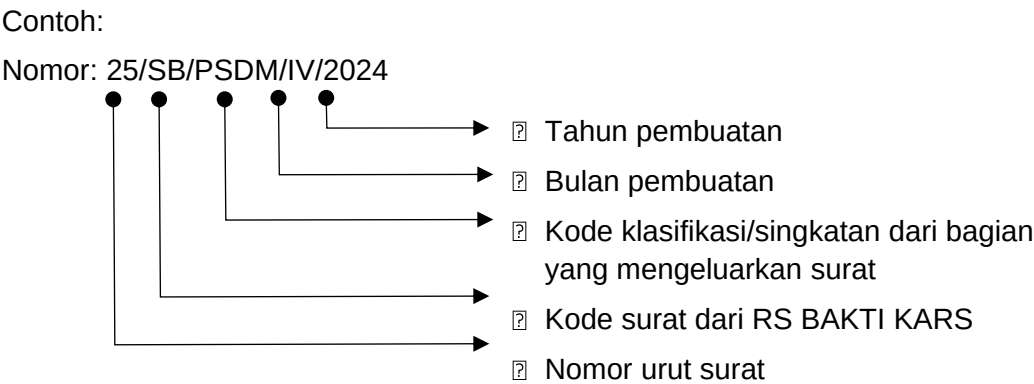
b. Kode surat yang dikeluarkan Direktur RS BAKTI KARS ditulis BK.

c. Kode klasifikasi atau singkatan bagian dari mana asal surat dikeluarkan, ditulis singkatan dengan huruf kapital.

d. Bulan dibuatnya peraturan ditulis dengan angka romawi.

e. Tahun dibuatnya peraturan, pada akhir angka tidak diberi titik.

f. Di antara nomor, kode, bulan, dan tahun diberi garis miring tanpa spasi.



- 4) Nomor Surat dari Kepala Bidang, Komite, Tim
- a. Nomor urut surat ditulis lengkap bukan singkatan dengan huruf awal kapital, diberi titik dua tanpa spasi.

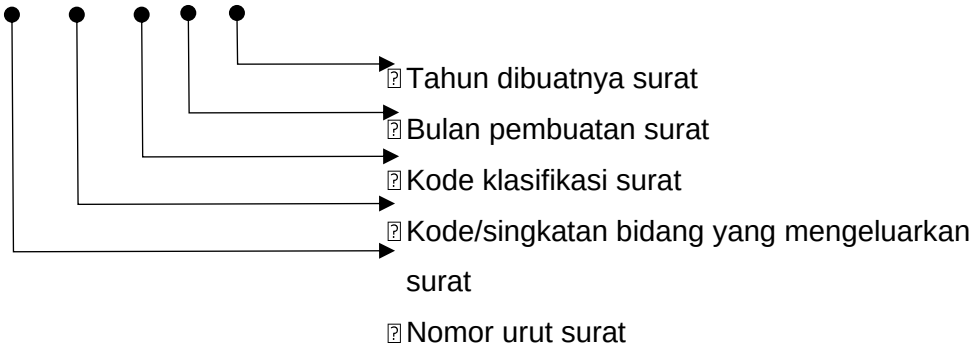
- b. Kode surat yang dikeluarkan oleh kepala bidang, komite, tim, dan lain-lain., ditulis singkatannya dengan huruf awal kapital. Daftar singkatan bidang, komite, panitia, dan lain-lain, seperti di atas
- c. Kode klasifikasi atau singkatan jenis keputusan atau surat korespondensi yang dikeluarkan, ditulis singkatan dengan huruf awal kapital.
- d. Daftar jenis surat dan singkatan adalah sebagai berikut:

Jenis surat	Singkatan	Jenis surat	Singkatan
Rotasi	Rot	Surat Tugas	Tgs
Undangan	Und	Surat Peringatan	SP
Pemberitahuan	Pemb		

- e. Bulan dibuatnya surat ditulis dengan angka romawi
- f. Tahun dibuatnya peraturan, pada akhir angka tidak diberi titik
- g. Di antara nomor, kode, bulan, dan tahun diberi garis miring tanpa spasi

Contoh:

Nomor: 24/Kprwt/Rot/IV/2024



5) Nomor SPO

Penomoran SPO dengan cara mengacu pada masing-masing unit kerja pada struktur organisasi Rumah Sakit, sebagai berikut:

- a. Singkatan dari nama divisi/unit kerja atau nama komite. Misalnya: YANMED (Pelayanan medis)
- b. Nomor sub divisi atau sub dalam panitia atau tim. Misalnya: 02 (Jangdis)
- c. Nomor sub-sub divisi jika ada Misalnya: 03 (Radiologi)
- d. Nomor urut SPO di unit kerja masing-masing.

Daftar bagian dan singkatan, sub bagian dan nomor, sub-sub bagian dan nomor, dalam penomoran adalah sebagai berikut:

Divisi	Singkatan	Sub divisi	No	Sub-sub divisi	
Keuangan	KEU	Akuntansi	01		
		Logistik	02		
		Keuangan	03		
		Administrasi	04		
		Perusahaan			
Pengembangan Sumber Daya Manusia	PSDM	Manajemen SDM	01		
		Pendidikan dan	02		
		Pelatihan	03		
			04		
Penunjang Umum	JANGUM	Kesehatan	01		
		Lingkungan	02		
		Taman	03		
		Linen Laundry	04		
		Operator	05		
		Keamanan	06		01

		Pemeliharaan		Penggunaan alat medis	02
		Kendaraan	07	Pemeliharaan	03
		Teknologi	08	alat medis	04
		Informasi		Penggunaan alat umum	
		Pemeliharaan alat umum			
Legal, Humas, dan Pemasaran	LHP	Legal	01		
		Humas dan	02		
		Pemasaran	03		
		Pelayanan			
		Pengaduan			

Divisi	Singkatn	Sub divisi	No	Sub-sub divisi	No
Bidang Pelayanan Medis	YANMED	Pelayanan Medis	01	Pelayanan Intensif	01
				Kamar Operasi	02
				Rawat Jalan	03
				IGD	04
				Hemodialisis	05
				Rawat Inap	06
				PKRS	07
				TumbuhKembang	08
		Penunjang Medis	02	farmasi	01
				laboratorium	02
				radiologi	03
				rehabilitasi Medis	04
				SSD	05
				pelayanan Gizi	06
		Rekam Medis	03	pendaftaran	01
				rekam Medis	02
				asemix	03
				pengendali Layanan	04
				Asuransi	
				Perusahaan	
Bidang Keperawatan	YANKEP	Ketenagaan	01		
		Peralatan	02		
		Tindakan Keperawatan	03		
		Administrasi	04		
		Keperawatan			
Komite Medis	KOMDIS	Sub Komite Etik dan Disiplin	01		
		Sub Komite Kredensial	02		
		Sub Komite Mutu Profesi	03		
Komite Keperawatan	KOMKEP	Sub Komite Etik dan Disiplin	01		
		Sub Komite Kredensial	02		
		Sub Komite Mutu Profesi	03		
Komite Nakes Lain	KOMKES	Sub Komite Etik dan Disiplin	01		
		Sub Komite Kredensial	02		
		Sub Komite Mutu Profesi	03		

Divisi yang tidak ada Sub divisi

Divisi	Singkatan	Divisi	Sing kata n
Peningkatan Mutu	MUTU	Program Nasional - Kesehatan ibu dan bayi - Tuberkulosis / TBC - HIV / AIDS - Stunting dan Wasting - Keluarga Berencana	PO NE K TB DO T HIV STU NTI NG KB
Keselamatan Pasien	SKP	Program lain - Pengenalian resistensi antimikroba - Geriatri - Tata kelola Rumah Sakit	PP RA GE RIA TRI TKR S
Manajemen Risiko	MANRISK		
Keselamatan Kerja, Kebakaran & Kewaspadaan Bencana	K3		
Pencegahan & Pengendalian Infeksi	PPI		
Sekretariat	SEKRET		

- Jika tidak ada sub bagian, sub-sub bagian atau indikator, penomoran langsung di belakang bagian, sub bagian atau di belakang singkatan standar.
- SPO yang dikeluarkan oleh bagian yang bersifat matriks (terkait silang dengan unit/bagian/divisilain) penomoran mengacu pada sifat dari prosedur yang disusun. Misalnya: SPO dari unit hemodialisis, jika prosedur yang diterbitkan tentang pelayanan keperawatan, maka penomoran mengikuti panduan di bidang keperawatan, sedangkan prosedur yanmed penomoran mengacu pada penomoran yanmed.
- Nomor SPO yang sudah dikeluarkan dicatat di buku catatan nomor SPO masing-masing pokja atau masing-masing bagian, pengelolaan penomoran oleh sekretaris akreditasi atau tim khusus akreditasi.

Contoh : 001/I-KEP/DIR/IV/2022

- a. Kode Jenis Dokumen
- Peraturan Direktur

Keputusan Direktur

Instruksi Direktur

Standar Prosedur Operasional

Surat Edaran

Surat Tugas

Surat Perintah Perjalanan Dinas

Undangan
- : PER

: KEP

: INS

: SPO

: SE

: ST

: SPPD

: UND

Perjanjian	: PKS
Addendum	: ADD
Surat Kuasa	: SKU
Berita Acara	: BA
Surat Keterangan	: SKT
Surat Pengantar	: PTR
Pengumuman	: PNG
Sertifikat	: SRTF
Surat Permohonan	: PM
Surat Pemberitahuan	: PB
Surat Pemanggilan	: SPG
Pengaduan Pelayanan	: PP

b. Unit yang bertanggung jawab terhadap Dokumen

Direktur	: DIR
Manajer Pelayanan	: MP
Manajer Keuangan & Akuntansi	: MKA
Manajer Umum	: MU
Instalasi Gawat Darurat	: IGD
Instalasi Rawat Jalan	: IRJA
Instalasi Rawat Inap	: IRNA
<i>Intensive Care Unit</i>	: ICU
Instalasi Kamar Operasi	: IKO
Instalasi Laboratorium	: LAB
Instalasi Radiologi	: RAD
Instalasi Farmasi	: IFRS
Instalasi Rekam Medis	: IRM
Instalasi Gizi	: IGZ
Instalasi Laundry	: ILN
Bagian Keuangan	: KEU
Bagian Akuntansi	: AKT
Bagian SDM	: SDM
Bagian Umum	: UMM
Bagian Humas-Pemasaran & Pely. Pelanggan	: HPMS
Bagian IPSRS	: IPSRS
Bagian Gudang Umum	: GDU
Instalasi SIMRS	: SIMRS
Pengadaan	: PGD
Sekretariat	: SKR
Komite Medik	: KMD
Komite Keperawatan	: KPW
Komite PPI	: PPI
Komite Mutu dan Keselamatan Pasien	: KMKP
Komite Etik	: KETK
Komite Farmasi dan Terapi	: KFT
Komite Pengendalian Resistensi Anti Mikroba	: PPRA
Komite K3RS	: K3RS
Panitia Rekam Medis	: PRM
Tim Review Rekam Medis	: TRRM
Tim TB DOTS	: TB
Tim PONEK	: PONEK
Tim PKRS	: PKRS
Tim Penjaminan	: TP
Tim-HTA	: HTA
Komite Farmasi dan Terapai	: KFT
Unit Pengaduan	: UP

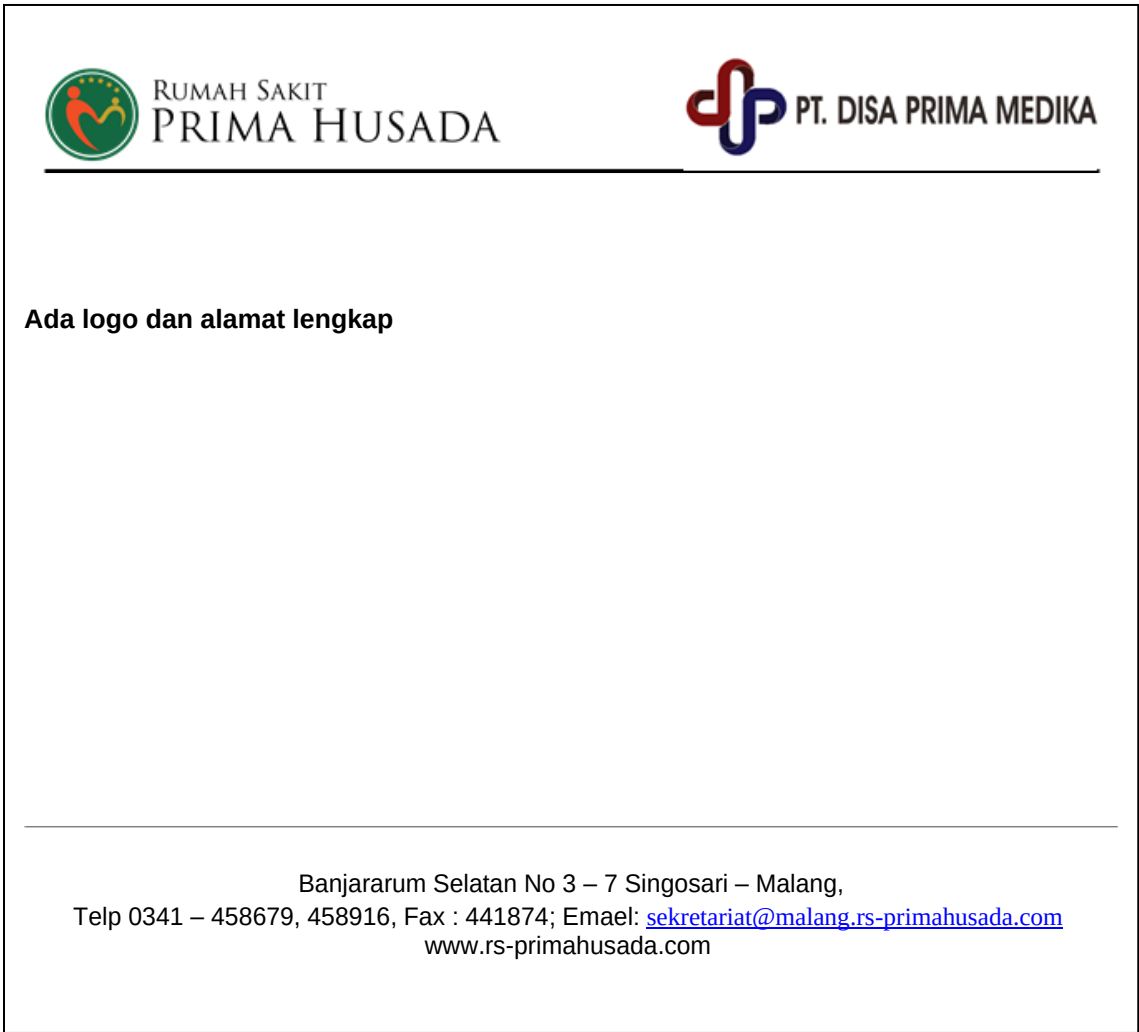
Nomor halaman ditulis dengan menggunakan nomor urut angka Arab dan dicantumkan di sebelah kanan bawah, kecuali halaman pertama naskah dinas yang menggunakan kop naskah dinas tidak perlu mencantumkan nomor halaman.

4.6.Penggunaan Kop/ Logo

Logo dan stempel digunakan dalam tata naskah dinas sebagai tanda pengenal atau identifikasi yang bersifat tetap dan resmi. Untuk memperoleh keseragaman dalam penyelenggaraan Tata Naskah Rumah Sakit Prima Husada, perlu ditentukan penggunaan logo dan stempel pada kertas surat dan amplop.

- 1) Penggunaan Logo
 - a. Logo adalah tanda pengenal atau identitas berupa symbol atau huruf yang digunakan dalam tata naskah sebagai identitas agar publik lebih mudah mengenalnya.
 - b. Logo yang digunakan di Rumah Sakit Prima Husada ditempatkan disebelah kiri surat. Sedangkan logo pemilik RS ditempatkan di sebelah kanan
- 2) Kepala Naskah Dinas
 - a. Pada kepala naskah dinas, dicantumkan logo Rumah Sakit Prima Husada dan juga logo pemilik RS yakni PT.DPM disebelah kanan serta garis penutup tebal. Dibawah logo
 - b. Pada kaki dicantumkan alamat lengkap tanpa singkatan, telepon, faksimile, surat elektronik (e-mail), website, lg.
- 3) Format Kepala Naskah Dinas
 - a. Penggunaan kop naskah dinas hanya pada lembar pertama naskah dinas.
 - b. Naskah dinas yang ditandatangani oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada menggunakan kop surat sebagaimana contoh :

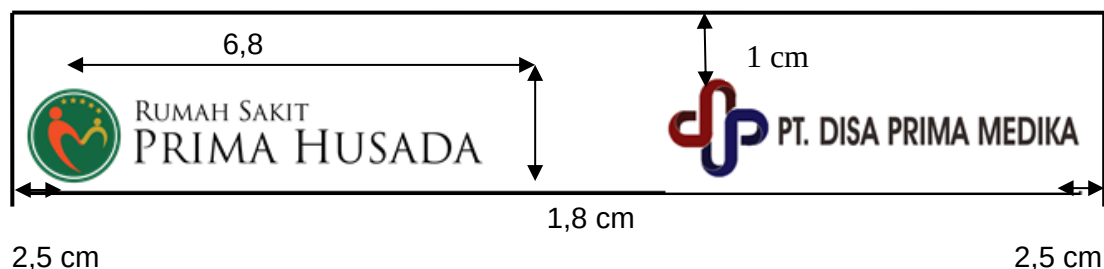
CONTOH FORMAT KOP NASKAH



Keterangan :

- 1) Logo dan nama Rumah Sakit Prima Husada diletakkan di sebelah kiri dengan ukuran 6,8 cm
- 2) Tulisan Rumah Sakit menggunakan huruf Arial tebal ukuran font 11
- 3) PRIMA HUSADA menggunakan huruf Arial tebal ukuran font 15
- 4) Logo PT. DPM diletakkan di sebelah kanan dengan ukuran 6,8 cm
- 5) Tinggi atas bawah 9lebar) 1,8 cm
- 6) Batas dari tepi kertas 1 cm
- 7) Tulisan alamat, nomor telepon, faksimile, email dan website menggunakan huruf Arial ukuran 9,5 - 10 diletakkan di bawah (footnote) tengah.
- 8) Garis batas atas menggunakan ukuran 2,1/4 pt.
- 9) Garis batas bawah menggunakan ukuran 1/2 pt
- 10) Jarak dari Kop ke Judul naskah 2 spasi

CONTOH KOP NASKAH SECARA DETAIL



4.7. Penggunaan Stempel/Cap Surat Dinas

a. Jenis dan warna stempel

Stempel ada 2 macam, yaitu :

- 1) Stempel instansi : tinta warna sesuai logo
- 2) Stempel unit kerja : tinta warna berwarna ungu

b. Penggunaan

1) Stempel terdiri atas :

- a) Stempel Instansi digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat di lingkup eksternal rumah sakit.
- b) Stempel unit kerja digunakan untuk menyertai tanda tangan pejabat di lingkungan unit kerja tersebut.

2) Penggunaan stempel terletak di sebelah kiri tanda tangan naskah dinas dan mengenai tanda tangan pejabat yang berwenang.

c. Bentuk ukuran, huruf, dan isi tulisan

1) Bentuk

Bentuk stempel instansi dan unit kerja adalah logo Rumah Sakit Prima Husada beserta tulisan Rumah Sakit Prima Husada

2) Ukuran

Ukuran stempel di Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut :

- a) Panjang : 5,5 cm
- b) Lebar : 1,2 cm

3) Huruf – huruf yang digunakan adalah huruf kapital dengan ukuran yang disesuaikan dengan besarnya stempel serta jumlah atau banyaknya huruf yang ada di dalam stempel tersebut.

4) Isi tulisan pada stempel Rumah Sakit Prima Husada

- a) Isi tulisan pada stempel Rumah Sakit Prima Husada diatur sebagai berikut:

(1) Tulisan di samping logo adalah RUMAH SAKIT.

(2) Dibawah tulisan RUMAH SAKIT terdapat tulisan PRIMA HUSADA

Contoh stempel Instansi



Contoh stempel unit kerja



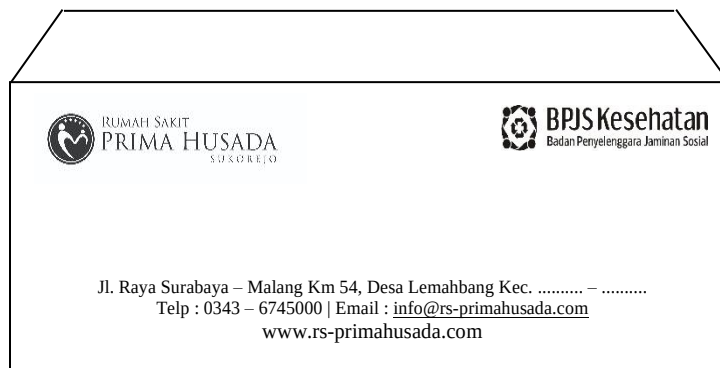
4.8.Amplop Surat Dinas

A.Standar ukuran amplop dinas sebagai berikut :

a. Surat Biasa :

- 1) Ukuran amplop : 230 x 110 mm
- 2) Warna amplop : putih
- 3) Logo Rumah Sakit Prima Husada dicetak disebelah kiri atas
- 4) Logo BPJS Kesehatan dicetak disebelah kanan atas
- 5) Alamat, nomor telepon, faksimile, website, email di cetak secara simetris di bagian tengah bawah.

Contoh Amplop Surat Biasa :



b. Surat yang dilipat dua

- 1) Ukuran amplop : 280 x 180 mm
- 2) Warna amplop : coklat
- 3) Diberi label instansi di pojok kiri atas

c. Surat dengan kertas A4 tanpa dilipat

- 1) Ukuran amplop : 350 x 240 mm
- 2) Warna amplop : coklat
- 3) Diberi label instansi di pojok kiri atas

B.Ketentuan Jarak Spasi

Dalam penentuan jarak spasi, hendaknya diperhatikan aspek keserasian, estetika, banyaknya isi naskah dinas dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jarak antara judul dan isi adalah dua spasi.
- b. Jika judul lebih dari satu baris, jarak antara baris pertama dengan baris kedua adalah satu spasi.
- c. Jarak masing – masing baris satu koma lima belas spasi.

BAB V

PEMBERLAKUAN DOKUMEN REGULASI

5.1. Pemberlakuan Dokumen Regulasi Internal

- 1) Dokumen internal Rumah Sakit terdiri dari regulasi dan dokumen pelaksanaan. Terdapat beberapa tingkat dokumen internal, yaitu:
 - a. dokumen tingkat Yayasan;
 - b. dokumen tingkat Rumah Sakit; dan
 - c. dokumen tingkat Unit (klinis dan non klinis), Komite, dan Tim
- 2) Dokumen Internal yang memerlukan pengaturan atau dikendalikan adalah:
 - a. Regulasi pelayanan Rumah Sakit, terdiri dari:
 - (1) Peraturan Direktur Rumah Sakit;
 - (2) Pedoman/Panduan Rumah Sakit;
 - (3) Standar Prosedur Operasional (SPO);
 - (4) Rencana Jangka Panjang (Renstra, Rencana strategi bisnis, bisnis plan, dan lain-lain); dan
 - (5) Rencana Kerja Tahunan (RKT).
 - b. Regulasi di unit (klinis dan non klinis), yang terdiri dari:
 - (1) Pedoman Pengorganisasian;
 - (2) Pedoman Pelayanan/Kerja;
 - (3) Standar Prosedur Operasional (SPO); dan
 - (4) Program Kerja (tahunan).
 - c. Regulasi di komite dan tim, yang terdiri dari:
 - (1) Pedoman/Panduan;
 - (2) Program Kerja (tahunan).
- 3) Apabila ada kebutuhan pembuatan dokumen baru di unit kerja, maka diusulkan ke jajaran struktural di atasnya disertai dengan usulan *draft* dokumen.
- 4) Apabila kebutuhan pembuatan dokumen baru terkait lebih dari satu unit pelayanan/unit kerja/ komite/tim, maka diadakan pembahasan bersama untuk penyusunan dokumen dan diusulkan ke jajaran struktural di atasnya disertai dengan usulan *draft* dokumen.
- 5) Jika ada perubahan/revisi dokumen, maka dilakukan permintaan revisi dokumen dengan disertai dengan usulan revisinya.
- 6) Dokumen yang telah dibuat oleh unit kerja ditandatangani oleh pembuat dokumen dan disetujui oleh atasannya, serta diperiksa oleh Direktur/Kepala Bidang atau Ketua Komite/Tim yang bersangkutan.
- 7) Dokumen yang telah disetujui oleh pihak-pihak terkait (ditandai dengan paraf) diserahkan ke Tim Regulasi dilampiri Daftar Dokumen Regulasi Internal (Lampiran II.a) selanjutnya dimintakan tandatangan ke Direktur sebagai pengesahan pemberlakuan dokumen.
- 8) Dokumen yang sudah disahkan digandakan sesuai usulan jumlah pendistribusian, kemudian didistribusikan sesuai dengan ketentuan pendistribusian dokumen.

5.2. Pemberlakuan Dokumen Regulasi Eksternal

- 1) Dokumen eksternal yang akan ditetapkan menjadi acuan di RS BAKTI KARS diusulkan ke Tim Regulasi untuk dimasukkan dalam Daftar Dokumen Eksternal (Lampiran II.b) oleh masing-masing bidang, Pokja, Komite, atau Tim yang ada di RS BAKTI KARS.
- 2) Dokumen eksternal yang ditetapkan menjadi acuan kerja di RS BAKTI KARS disahkan dengan Surat Keputusan Direktur tentang pemberlakuan dokumen regulasi eksternal, dilampiri dengan Daftar Dokumen Eksternal yang akan disahkan.
- 3) Dokumen eksternal yang ada dalam Daftar Dokumen Eksternal diunggah ke intranet jaringan akreditasi Rumah Sakit dalam format pdf.
- 4) Hard copy dokumen eksternal disimpan oleh Sekretaris Tim Regulasi dan bagian yang menggunakan dokumen eksternal secara langsung sebagai acuan kerja sehari-hari.
- 5) Jika ada revisi dari dokumen eksternal tersebut, maka daftar dokumen eksternal akan diperbaharui.

5.3. Dokumentasi dan Penandaan Dokumen Regulasi

Penandaan Dokumen Regulasi Berdasarkan Klasifikasi berdasarkan jenisnya dibagi menjadi:

1) Dokumen Terkendali;

Setiap dokumen terkontrol harus memiliki penandaan yang jelas yang menyatakan statusnya sebagai "**CONTROLLED**". Dokumen harus mencantumkan informasi tentang tanggal rilis, penulis, nomor revisi, dan tanggal revisi terakhir.

2) Dokumen Tidak Terkendali (*Uncontrolled Document*);

Dokumen tidak terkontrol harus jelas ditandai dengan "**UNCONTROLLED**" atau "**For Reference Only**" untuk mencegah mereka digunakan sebagai dasar untuk keputusan kritis. Tidak ada kewajiban untuk memperbarui dokumen tidak terkontrol, dan mereka tidak boleh digunakan untuk keperluan operasional atau keputusan penting. Sekretaris Tim Regulasi tidak akan menarik salinan yang sudah tidak berlaku pada saat ada revisi baru.

3) Salinan Terkendali (*Controlled Copy*);

Salinan Terkendali (*Controlled Copy*) diberi tanda dengan distempel bertuliskan "**CONTROLLED COPY**" dan dituliskan nomor salinan sesuai dengan nomor pengguna dokumen seperti yang tercantum dalam Daftar Dokumen Internal. Apabila terjadi perubahan pada dokumen yang masih digunakan, maka revisi terbaru harus didistribusikan kepada unit kerja penerima sesuai kebutuhan dari unit kerja yang membutuhkan dan Sekretaris Tim Regulasi bertanggungjawab menarik salinan Dokumen Terkendali yang sudah tidak berlaku. Stempel "**CONTROLLED COPY**" tidak digunakan jika distribusi dokumen dilakukan melalui intranet.

4) Dokumen Tidak Berlaku (*Obsolete*).

Dokumen Tidak Berlaku (*obsolete*) diberi tanda dengan stempel "**TIDAK BERLAKU**" dan disimpan di Sekretaris Tim Regulasi sampai 3 (tiga) revisi terakhir, sebelum kemudian dimusnahkan.

5.4. Identifikasi Dokumen Regulasi

- 1) Diberi nomor identifikasi atau nomor dokumen sesuai dengan cara penomoran yang sudah diatur dalam Panduan ini.
- 2) Dokumen yang baru pertama kali diterbitkan diberi nomor revisi 0 (nol).
- 3) Bila terjadi revisi/perubahan diberi nomor revisi/perubahan sesuai dengan nomor urutan frekuensi dilakukan revisi.
- 4) Revisi dokumen internal maksimal sampai revisi ke 04 (empat), apabila ada revisi ke 05 (lima) wajib dituangkan dalam dokumen baru.
- 5) Bila dokumen habis masa berlakunya dan dari hasil evaluasi tidak ada perubahan, namun akan diberlakukan kembali, maka tidak dianggap sebagai revisi dan dituangkan dalam dokumen baru.
- 6) Dokumen yang berasal dari luar RS diidentifikasi dan diberi nomor urut oleh Sekretaris Tim Regulasi.
- 7) Dalam rangka menjaga keterbacaan dokumen, maka untuk pencetakan dokumen hanya diijinkan dengan cara:
 - a. *print* dari *softcopy* dokumen; atau
 - b. fotokopi dari dokumen *hardcopy* asli.

5.5. Pengesahan dan Penerbitan Dokumen

- 1) Para Kepala Bidang, Kepala Unit/Kepala Instalasi/Kepala Perawat, Ketua Komite/Tim bertanggungjawab atas penyusunan, kebenaran isi dokumen, dan/atau perubahan dokumen di unit kerjanya.
- 2) Kabid Medis dan Keperawatan, Kabag Umum dan Keuangan bertanggungjawab atas materi atau isi dokumen di bidangnya.
- 3) Tim Regulasi bertanggung jawab atas verifikasi dokumen regulasi sebelum diajukan untuk dimintakan tanda tangan kepada Direktur RS
- 4) Direktur RS bertanggungjawab atas pengesahan dokumen internal.
- 5) Sekretaris Tim Regulasi bertanggung jawab atas penyimpanan, pendistribusian, dan pemusnahan dokumen asli dan salinan terkendali.
- 6) Tingkatan regulasi yang berlaku di RS:

Jenis Dokumen	Disiapkan	Diperiksa	Disahkan
Peraturan	Kepala Bidang/Ketua Komite/Ketua Tim	Kabid Mutu PT	Direktur
Keputusan	Kepala Bidang/Ketua Komite/Ketua Tim	Kabid Mutu PT	Direktur
Kebijakan	Kepala Bidang/Ketua Komite/Ketua Tim	Kabid Mutu PT	Direktur
Pedoman	Kepala Bidang/Ketua Komite/Ketua Tim	Kabid Mutu PT	Direktur
Panduan	Kepala Bidang/Ketua Komite/Ketua Tim	Kabid Mutu PT	Direktur
Prosedur/SPO	Kepala Bidang /Ketua Komite/Ketua Tim	Kabid Mutu PT	Direktur
	/Kepala Unit	Kepala Bidang	Direktur

5.6.Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat Naskah Dinas.

Perubahan, pencabutan, pembatalan, serta ralat naskah dinas dapat dilakukan dengan syarat harus jelas menunjukkan naskah dinas atau bagian mana dari naskah dinas tersebut yang diadakan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan / atau ralat.

a. Pengertian

- 1) Perubahan
Perubahan adalah mengubah bagian tertentu dari naskah dinas yang dinyatakan dengan lembar perubahan.
- 2) Pencabutan
Pencabutan adalah mencabut naskah dinas tertentu karena bertentangan atau tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, khusus, atau naskah dinas yang baru ditetapkan.
- 3) Pembatalan
Pembatalan adalah menyatakan bahwa seluruh materi naskah dinas tidak diberlakukan lagi melalui suatu pernyataan pembatalan dalam naskah dinas yang baru.
- 4) Ralat
Ralat adalah perbaikan yang dilakukan terhadap sebagian materi naskah dinas melalui pernyataan ralat dalam naskah dinas yang baru.

b. Tata Cara Perubahan, Pencabutan, Pembatalan, dan Ralat

- 1) Pejabat yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan adalah Direktur Rumah Sakit Prima Husada
- 2) Ralat yang bersifat kekeliruan kecil, seperti salah ketik, dilaksanakan oleh pejabat yang menandatangani naskah dinas.
- 3) Staf yang berhak menentukan perubahan, pencabutan, dan pembatalan adalah staf yang menandatangani Naskah Dinas tersebut atau oleh staf yang lebih tinggi kedudukannya.
- 4) Naskah Dinas yang bersifat mengatur, apabila diubah, dicabut, atau dibatalkan, harus diubah, dicabut, atau dibatalkan dengan Naskah Dinas yang setingkat atau lebih tinggi.

BAB VI

PENGAMANAN NASKAH DINAS

6.1. Kategori Klasifikasi Keamanan dan Akses Naskah Dinas

Kategori klasifikasi keamanan untuk naskah dinas, terdiri dari :

- 1) Sangat rahasia adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan keutuhan organisasi.
- 2) Rahasia adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan manajemen, sumber daya Rumah Sakit, ketertiban umum, termasuk ekonomi. Apabila informasi yang terdapat dalam Naskah Dinas bersifat sensitif baik bagi organisasi maupun perorangan akan menimbulkan kerugian yang serius bagi privasi, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
- 3) Terbatas adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan fungsi dan tugas bagian/unit atau organisasi secara umum seperti kerugian finansial yang signifikan.
- 4) Biasa/Terbuka adalah Naskah Dinas yang apabila fisik dan informasinya dibuka untuk umum tidak membawa dampak apapun terhadap keamanan negara.
- 5) Penentuan keempat tingkat klasifikasi keamanan tersebut disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

6.2. Hak Akses Naskah Dinas:

- 1) Hak akses untuk Naskah Dinas berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas, diberikan kepada Direktur dan yang setingkat di bawahnya, serta pengawas internal/eksternal dan penegak hukum apabila sudah diberikan izin; dan
- 2) Hak akses Naskah Dinas berklasifikasi biasa/terbuka, diberikan kepada semua staf dan staf yang berkepentingan.

6.3. Perlakuan Terhadap Naskah Dinas Berdasarkan Klasifikasi Keamanan dan Akses

- 1) Pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses
- 2) Diberikan kode derajat pengamanan di amplop dan di sebelah kiri atas Naskah Dinas serta penggunaan amplop rangkap dua untuk Naskah Dinas yang sangat rahasia dan rahasia.
- 3) Pemberian kode derajat klasifikasi, meliputi:
 - a. Naskah dinas Sangat Rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah; dan
 - b. Naskah Dinas Rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah.

Tata cara pemberian kode dalam penomoran:
...../...../...../...../R/Tahun.

BAB VII
KEWENANGAN PENANDATANGANAN

7.1.Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas

- 1) Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani naskah dinas antar / keluar instansi yang bersifat keputusan / kebijakan / arahan berada pada Direktur Rumah Sakit Prima Husada.
- 2) Kewenangan untuk melaksanakan dan menandatangani Naskah yang tidak bersifat keputusan / kebijakan / arahan dapat diserahkan / dilimpahkan kepada Direktur /Kepala Bidang/Instalasi/Unit/Ketua Komite/tim.
- 3) Penyerahan / pelimpahan wewenang dan penandatanganan korespondensi kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. Direktur berhalangan hadir dan atau mendapat tugas keluar, meninggalkan kantor maka tugas dan wewenang serta tanggung jawab didelegasikan kepada salah satu Kabid/Kabag.
 - b. Kabid/Kabag berhalangan hadir dan atau mendapat tugas keluar, meninggalkan kantor maka tugas dan wewenang serta tanggung jawab didelegasikan kepada Kabid/Kabag yang lain/ Instalasi/Unit/Ketua Komite/tim.
 - c. Kepala Bidang/Instalasi/Unit/Ketua Komite/Ketua Tim pada masing-masing jajaran RS Prima Husada dapat memperoleh penyerahan/ pelimpahan kewenangan dan penandatanganan Naskah Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masing-masing.

MATRIKS KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS DI RSPH

	Jenis Naskah Dinas	Dir	Ka Bid	Ka Ins	Ka Unit	Komite/Tim
1.	Peraturan	✓	-	-	-	-
2.	Pedoman	✓	-	-	-	-
3.	Instruksi	✓	-	-	-	-
4.	SPO	✓	-	-	-	-
5.	Surat Perjanjian	✓	-	-	-	-
6.	Surat Perintah	✓	-	-	-	-
7.	Surat Tugas	✓	-	-	-	-
8.	Surat Kuasa	✓	✓	-	-	-
9.	Keputusan	✓	✓	-	-	-
10.	Edaran	✓	✓	-	-	-
11.	Surat Keterangan	✓	✓	-	-	-
12.	Surat Dinas	✓	✓	-	-	✓
13.	Nota Dinas	✓	✓	-	-	✓
14.	Undangan	✓	✓	✓	✓	✓
15.	Berita Acara	✓	✓	✓	✓	✓
16.	Surat Pengantar	✓	✓	✓	✓	✓
17.	Pengumuman	✓	✓	✓	✓	✓
18.	Laporan	✓	✓	✓	✓	✓
19.	Telaahan Staf	-	-	✓	✓	✓
20.	Juklak/Juknis	-	✓	✓	✓	-
21.	Surat Peringatan	✓	✓	-	-	-

*)

Ruang lingkup surat undangan yang ditandatangani selain Direktur hanya diperuntukkan di lingkungan internal Rumah Sakit bukan untuk keluar RS.

7.2.Garis Kewenangan dan Penandatanganan

7.2.1.Penggunaan Garis Kewenangan

Direktur Rumah Sakit Prima Husada bertanggung jawab atas segala kegiatan yang dilakukan di dalam instansinya. Tanggung jawab tersebut tidak dapat dilimpahkan atau diserahkan kepada seseorang yang bukan pejabat berwenang. Garis kewenangan digunakan jika naskah dinas ditandatangani oleh pejabat yang mendapat pelimpahan dari pejabat yang berwenang.

7.2.2.Penandatanganan

Bentuk pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas adalah sebagai berikut :

a. Atas nama (a.n.)

Atas nama digunakan jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Pelimpahan wewenang tersebut diberikan secara tertulis dalam surat kuasa, keputusan, mandat, instruksi, atau disposisi;
- 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar – benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang diatasnamakan;
- 4) Rentang pelimpahan paling banyak hanya dua tingkat dihitung dari pelimpahan jenjang pertama. Dikecualikan dari ketentuan pelimpahan paling banyak dua tingkat untuk keputusan yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;
- 5) Pejabat yang menerima wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberi pelimpahan wewenang;
- 6) Penomoran Naskah Dinas a.n. menggunakan nomor staf yang menandatangani;

Format :

a.n. Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Kabid Pelayanan

Nama Pejabat

Contoh :

a.n. Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Kabid Penunjang

Nama Lengkap

b. Untuk beliau (u.b.)

u.b. digunakan jika dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Jika pejabat yang diberi kuasa memberi mandat kepada pejabat satu tingkat dibawahnya. Oleh sebab itu, u.b. digunakan setelah a.n. ;
- 2) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan surat berada pada pejabat yang diatasnamakan; dan
- 3) Pejabat yang menerima wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang memberi pelimpahan wewenang.

Format :

Contoh :

a.n. Direktur RS. Prima Husada
Kabid Pelayanan,

a.n. Direktur RS. Prima Husada

Pejabat satu tingkat dibawah,
u.b.

u.b.

Pejabat dua tingkat dibawah

Kepala Instalasi Rawat Inap

Nama Pejabat

Nama lengkap

7.2.3. Pelaksana Tugas (Plt.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana tugas disingkat (Plt.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan bidang kepegawaian lebih lanjut;

- 1) Pelimpahan wewenang diberikan kepada pejabat struktural setingkat; dan
- 2) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif ditetapkan.

Format :
Plt. Nama Jabatan,

Nama Lengkap

7.2.4. Pelaksana Harian (Plh.)

Ketentuan penandatanganan pelaksana harian yang disingkat (Plh.) adalah sebagai berikut :

- 1) Pelaksana harian (Plh.) digunakan apabila pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas tidak berada di tempat sehingga untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sehari – hari perlu ada pejabat sementara yang menggantikannya;
- 2) Kewenangan penandatanganan naskah dinas dikecualikan untuk kebijakan dan keuangan;
- 3) Pelimpahan wewenang diberikan kepada pejabat struktural satu tingkat dibawahnya atau yang setingkat dan berada dalam satu unit yang sama;
- 4) Pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan pejabat yang definitif kembali bertugas; dan
- 5) Plh. bertanggungjawab kepada pejabat definitif.

Format :
Plh. Nama Jabatan,

Nama Lengkap
Contoh :
Plh. Kepala Instalasi Gawat Darurat
dr.Ferry Limantara, Sp.Em

7.2.5. Yang menjalankan Tugas (Ymt)

Ketentuan penandatanganan yang menjalankan tugas yang disingkat (Ymt) adalah sebagai berikut:

- 1) digunakan apabila staf yang berwenang menandatangani Naskah Dinas belum ditetapkan karena menunggu ketentuan lebih lanjut;
- 2) pelimpahan wewenang diberikan kepada staf struktural setingkat; dan/atau
- 3) pelimpahan wewenang bersifat sementara, sampai dengan staf yang definitif ditetapkan.

Format:	Contoh:
Ymt. Nama Jabatan,	Ymt. Kepala Bidang Keperawatan,
 Nama Lengkap	 Barlian, S.Kep

BAB VIII

PENGENDALIAN DOKUMEN

Pengaturan tentang pengendalian naskah dinas merupakan tahapan lanjutan dari penciptaan naskah dinas. Pengendalian naskah dinas harus diikuti dengan tindakan yang meliputi tahapan sebagai berikut :

8.1.Naskah Dinas

8.1.1.Naskah Dinas Masuk

- a. Naskah dinas masuk adalah semua naskah dinas yang diterima dari lembaga lain (eksternal).
- b. Prinsip – Prinsip penanganan naskah dinas masuk :
 - 1) Penerimaan naskah dinas masuk dipusatkan di Kesekretariatan Rumah Sakit Prima Husada yang memiliki tugas dan fungsi Kesekretariatan.
 - 2) Penerimaan naskah dinas masuk eksternal dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di Kesekretariatan yang memiliki tugas dan fungsi Kesekretariatan.
 - 3) Naskah dinas yang masuk yang disampaikan langsung kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada
- c. Pengendalian naskah dinas masuk dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) Penerimaan
Naskah dinas masuk eksternal yang diterima dalam sampul tertutup dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan rahasia, penting, segera, biasa.
 - 2) Pencatatan
 - a) Naskah dinas masuk eksternal, diterima oleh Kesekretariatan, dikelompokkan berdasarkan kategori klasifikasi keamanan.
 - b) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas.
Registrasi naskah dinas meliputi :
 - (1) Nomor agenda;
 - (2) Tanggal penerimaan;
 - (3) Nomor dan tanggal naskah dinas;
 - (4) Asal naskah dinas;
 - (5) Isi ringkas naskah dinas;
 - (6) Cara terima naskah dinas; dan
 - (7) Klasifikasi naskah dinas.
 - (8) Unit kerja yang dituju; dan
 - (9) Keterangan
 - 3) Sarana pengendalian naskah dinas antara lain berupa
 - a. Agenda Elektronik/SIMRS Sekretariat dan atau.
 - b. Buku Agenda
 - 4) Pengarahan
 - a) Pengarahan naskah dinas masuk eksternal dengan kategori rahasia disampaikan langsung kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada; dan
 - b) Pengarahan naskah dinas masuk eksternal dengan kategori penting, segera, biasa dilakukan dengan membuka, membaca, dan memahami keseluruhan isi dan maksud naskah dinas untuk mengetahui unit yang akan menindaklanjuti naskah dinas tersebut.

-
- 5) Penyampaian
 - a) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit sesuai dengan isi disposisi disertai bukti penyampaian naskah dinas.
 - b) Bukti penyampaian naskah dinas masuk memuat informasi tentang :
 - (1) Nomor urut pencatatan;
 - (2) Nomor & Tanggal naskah dinas;
 - (3) Nama naskah dinas;
 - (4) Asal naskah dinas;
 - (5) Unit yang dituju/Instalasi penerima;
 - (6) Nama dan tandatangan penerima di unit/Instalasi yang dituju;
 - (7) Waktu penerimaan;
 - (8) Isi ringkas naskah Dinas
 - (9) Keterangan.
 - c) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas dapat berupa ;
 - (1) Buku ekspedisi;
 - (2) Lembar tanda terima penyampaian; dan/atau
 - (3) Lembar pengantar.

8.1.2. Naskah Dinas keluar

a. Pengertian

Naskah Dinas keluar adalah semua Naskah Dinas yang dikirim ke orang/lembaga lain. Prinsip-prinsip pengendalian Naskah Dinas keluar dari RS berbeda dengan umumnya;

b. Pencatatan

- 1) Pengendalian Naskah Dinas keluar dilakukan dengan mencatat Naskah Dinas pada sarana pengendalian Naskah Dinas keluar. Informasi sarana pengendalian Naskah Dinas keluar meliputi:
 - a) nomor urut;
 - b) tanggal pengiriman;
 - c) nomor dan tanggal Naskah Dinas;
 - d) tujuan Naskah Dinas;
 - e) isi ringkas Naskah Dinas; dan
 - f) keterangan.
- 2) Sarana pengendalian Naskah Dinas keluar antara lain dapat berupa:
 - a. Buku Agenda; dan/atau
 - b. Agenda Elektronik.

c. Penggandaan

- 1) Penggandaan Naskah Dinas adalah kegiatan memperbanyak Naskah Dinas dengan sarana penggandaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Penggandaan Naskah Dinas dilakukan setelah Naskah Dinas keluar ditandatangani oleh staf yang berhak.
- 3) Penggandaan Naskah Dinas keluar yang kategori klasifikasi keamanannya sangat rahasia, rahasia, dan terbatas harus diawasi secara ketat.
- 4) Halaman pertama Naskah Dinas harus menggunakan kop asli dan penandatangan menggunakan cap basah.

d. Pengiriman

- 1) Naskah Dinas keluar yang akan dikirimkan oleh unit pengolah dimasukkan ke dalam amplop dengan mencantumkan alamat lengkap dan nomor Naskah

Dinas sesuai dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dan pembubuhan cap dinas.

- 2) Khusus untuk Naskah Dinas dengan kategori klasifikasi keamanan Sangat Rahasia (SR), Rahasia (R), Terbatas (T), dimasukkan ke dalam amplop kedua dengan hanya mencantumkan alamat yang dituju dan pembubuhan cap dinas.

e. Kecepatan penyampaian

- 1) Amat Segera/Kilat adalah surat dinas yang harus diselesaikan/dikirim/disampaikan pada hari yang sama dengan batas waktu 24 jam.
- 2) Segera adalah surat dinas yang harus diselesaikan/dikirim/disampaikan dalam waktu 2 x 24 jam.
- 3) Biasa adalah surat dinas yang harus diselesaikan/dikirim/disampaikan menurut urutan yang diterima oleh bagian pengiriman, sesuai dengan jadwal perjalanan pengirim/kurir.

f. Penyimpanan

- 1) Kegiatan pengelolaan Naskah Dinas keluar harus didokumentasikan oleh unit pengirim.
- 2) Naskah Dinas keluar yang disimpan merupakan verbal, konsep dan Naskah Dinas akhir yang diparaf dan ditandatangani oleh staf sesuai dengan jenjang kewenangannya.
- 3) Penyimpanan verbal, konsep dan Naskah Dinas akhir keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan Naskah Dinas masuk yang memiliki informasi atau masalah yang sama.

8.1.3. Naskah Dinas Masuk Internal RSPH

a. Pengertian

Naskah dinas masuk internal RSPH adalah semua naskah dinas yang diterima dari unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada. Prinsip – Prinsip penanganan naskah dinas masuk internal :

- 1) Penerimaan naskah dinas masuk internal dipusatkan di Kesekretariatan Rumah Sakit Prima Husada yang memiliki tugas dan fungsi Kesekretariatan.
- 2) Penerimaan naskah dinas masuk internal dianggap sah apabila diterima oleh petugas atau pihak yang berhak menerima di Kesekretariatan yang memiliki tugas dan fungsi Kesekretariatan.
- 3) Naskah dinas yang masuk yang disampaikan langsung kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada .

b. Pengendalian naskah dinas masuk internal dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

- 1) Penerimaan
Naskah dinas masuk internal yang diterima dari unit kerja Rumah Sakit Prima Husada
- 2) Pencatatan
 - a) Naskah dinas masuk internal, diterima oleh Kesekretariatan.
 - b) Pengendalian naskah dinas dilakukan dengan registrasi naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas.
Registrasi naskah dinas meliputi :
 - (1) Nomor agenda;
 - (2) Tanggal penerimaan;
 - (3) Nomor dan tanggal naskah dinas;
 - (4) Asal naskah dinas; dan
 - (5) Isi ringkas naskah dinas;

-
- 3) Sarana pengendalian naskah dinas berupa SIMRS Sekretariat.
 - 4) Pengarahan
 - a) Pengarahan naskah dinas masuk internal disampaikan langsung kepada Direktur Rumah Sakit Prima Husada; dan
 - b) Pengarahan naskah dinas masuk internal khususnya laporan bulanan unit disampaikan kepada Manajer terkait dengan pelayanan unit di Rumah Sakit Prima Husada
 - 5) Penyampaian
 - a) Naskah dinas masuk disampaikan kepada unit sesuai dengan isi disposisi disertai bukti penyampaian naskah dinas.
 - b) Bukti penyampaian naskah dinas masuk internal di muat di bukti kontrol surat di dalam SIMRS Sekretariat.
 - c) Bentuk bukti penyampaian naskah dinas berupa SIMRS Sekretariat.

8.1.4. Naskah Dinas Keluar Internal RSPH

- a. Pengertian

Naskah dinas keluar internal RSPH adalah semua naskah dinas yang dikirim ke unit kerja di Rumah Sakit Prima Husada. Prinsip – prinsip pengendalian naskah dinas keluar internal RSPH:

 - 1) Pengiriman naskah dinas keluar dilakukan oleh Kesekretariatan.
 - 2) Untuk surat yang bersifat biasa sebelum dikirim harus dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan naskah dinas, meliputi :
 - a) Nomor dan tanggal naskah dinas;
 - b) Stempel;
 - c) Tanda tangan;
- b. Pengendalian naskah dinas keluar internal dilakukan melalui tahapan sebagai berikut :
 - 1) Pencatatan
 - a) Pengendalian naskah dinas keluar internal dilakukan dengan mencatat naskah dinas pada sarana pengendalian naskah dinas keluar internal. Informasi sarana pengendalian naskah dinas keluar meliputi :
 - (1) Nomor dan tanggal naskah dinas;
 - (2) Tujuan naskah dinas; dan
 - (3) Isi ringkas naskah dinas.
 - b) Sarana pengendalian naskah dinas keluar berupa SIMRS Sekretariat.
 - 2) Penggandaan
 - a) Penggandaan naskah dinas adalah kegiatan memperbanyak naskah dinas dengan sarana penggandaan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.
 - b) Penggandaan naskah dinas dilakukan setelah naskah dinas keluar ditandatangani oleh pejabat yang berhak.
 - c) Halaman pertama naskah dinas harus menggunakan kop asli dan penandatanganan menggunakan stempel basah.
 - 3) Pengiriman
 - a) Naskah dinas keluar yang akan dikirimkan oleh Kesekretariatan dengan mencantumkan nama unit kerja dan pembubuhan stempel.
 - 4) Penyimpanan
 - a) Kegiatan pengelolaan naskah dinas keluar harus didokumentasikan oleh Kesekretariatan.

- b) Naskah dinas keluar yang disimpan merupakan verbal, konsep dan naskah dinas akhir yang diparaf dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan jenjang kewenangannya.
- c) Penyimpanan verbal, konsep dan naskah akhir keluar diberkaskan menjadi satu kesatuan dengan naskah dinas masuk yang memiliki informasi atau masalah yang sama.
Nomor urut;
 - (1) Tanggal pengiriman;
 - (2) Tujuan naskah dinas;
 - (3) Nomor naskah dinas;
 - (4) Isi ringkas naskah dinas; dan
 - (5) Keterangan
- d) Sarana pengendalian naskah dinas keluar berupa SIMRS Sekretariat.

8.2. Pembuatan dan Revisi Dokumen

Dokumen regulasi dibuat untuk memenuhi kebutuhan kepatuhan, seringkali sebagai respons terhadap perubahan dalam peraturan atau praktik industri. Dokumen tersebut harus secara rutin ditinjau dan diperbaharui untuk memastikan keakuratan dan relevansi terhadap regulasi yang berlaku.

8.3. Persetujuan Dokumen

Sebelum diimplementasikan atau didistribusikan, dokumen regulasi harus melalui proses persetujuan yang ketat. Persetujuan ini melibatkan berbagai tingkat otoritas tergantung pada kompleksitas dan tingkat risiko yang terkait. Setiap persetujuan harus didokumentasikan untuk memepertahankan catatan kepatuhan.

8.4. Akses, Distribusi, dan Pelacakan

1) Akses

Akses ke dokumen diatur berdasarkan jenis dokumen, peran dan tanggung jawab, memastikan bahwa hanya individu yang berwenang yang dapat melihat atau mengubah dokumen.

a. Dokumen terkendali

Akses ke dokumen terkendali dibatasi hanya untuk individu yang memiliki otoritas atau ada kebutuhan tertentu untuk mengetahui dokumen dengan persetujuan dari individu yang memiliki otoritas. Distribusi dokumen dilakukan melalui sistem manajemen dokumen yang terpusat, yang memungkinkan pelacakan siapa saja yang memiliki hak akses ke dokumen tersebut.

b. Dokumen tidak terkendali

Dokumen tidak terkendali dapat didistribusikan tanpa pembatasan yang ketat karena mereka tidak mengandung informasi yang dianggap kritis atau sensitif. Meskipun lebih mudah diakses, penting untuk mendidik staf bahwa informasi tersebut mungkin tidak akurat atau sudah ketinggalan zaman.

2) Distribusi

Distribusi adalah kegiatan atau usaha untuk menyampaikan naskah ke unit kerja dan atau pelaksana yang memerlukan naskah sebagai panduan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Pendistribusian naskah dilakukan oleh Tim Regulasi.

Unit kerja pembuat dokumen menentukan unit kerja lain yang akan diberi salinan dokumen dan menuliskan di "Lembar Distribusi" (Lampiran II.d) yang dilampirkan pada setiap dokumen yang telah selesai dibuat dan akan dimintakan pengesahan kepada Direktur dan diserahkan kepada Sekretaris Tim Regulasi.

Distribusi naskah menggunakan buku ekspedisi atau formulir untuk tanda tangan penerima apabila naskah yang diberikan dalam bentuk hard copy. Distribusi naskah

melalui intranet RS tidak perlu dimintakan tanda tangan penerima dan disimpan dalam bentuk soft copy dengan format pdf. Distribusi naskah bisa dilakukan ke semua unit kerja atau hanya ke unit kerja tertentu. Hal ini tergantung dari jenis naskah yang didistribusikan dan unit kerja yang memerlukan untuk diketahui atau untuk pedoman kerja.

Berikut ini kertas kerja untuk memantau dan mencatat akses, distribusi serta pelacakan terhadap dokumen RSPH:.

Tabel Klasifikasi Dokumen Terkendali dan Tidak Terkendali

No.	Nama Dokumen	Jenis Dokumen	Status Kendali	Versi	Tanggal Terakhir Diperbarui	Akses yang Diizinkan	Lokasi Penyimpanan	Catatan
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

3) Pelacakan

Setiap perubahan yang dibuat harus dicatat dengan detail termasuk pihak yang melakukan perubahan dan waktu perubahan tersebut dilakukan

Tabel Distribusi dan Pelacakan Akses Dokumen

N o	Nama Dokumen	Vers i	Tanggal Distribusi	Dibagikan Kepada	Departemen	Akses (Lihat/Edit/Hapus)	Tanggal Akses Terakhir	Catatan
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								

Keterangan Tabel

- No.:** Nomor urut dokumen.
- Nama Dokumen:** Judul atau nama dokumen yang didistribusikan.
- Versi:** Versi terkini dari dokumen.
- Tanggal Distribusi:** Tanggal dokumen dibagikan kepada pengguna.
- Dibagikan Kepada:** Nama penerima dokumen.
- Departemen:** Departemen penerima dokumen.
- Akses (Lihat/Edit/Hapus):** Jenis akses yang diberikan kepada penerima.
- Tanggal Akses Terakhir:** Tanggal terakhir dokumen diakses oleh penerima.
- Catatan:** Informasi tambahan atau catatan khusus mengenai dokumen atau distribusinya.

Tabel Pelacakan Distribusi Regulasi

N o	Nama Regulasi	Tanggal Ditetapkan	Penerima Regulasi	Metode Distribusi	Tanggal Distribusi	Konfirmasi Penerimaan	Keterangan
1.							
2.							

3							
4							
5							

Keterangan:

Nama Regulasi: Nama peraturan, SPO, atau regulasi yang didistribusikan.
Tanggal Ditetapkan: Tanggal regulasi tersebut disahkan oleh pihak yang berwenang.
Penerima Regulasi: Pihak atau departemen yang wajib menerima regulasi tersebut.
Metode Distribusi: Cara distribusi regulasi, misalnya melalui email, surat edaran, rapat sosialisasi, atau sistem intranet rumah sakit.
Tanggal Distribusi: Tanggal distribusi regulasi kepada pihak terkait.
Konfirmasi Penerimaan: Tanggal penerima menyatakan telah menerima regulasi, bisa melalui email balasan, tanda tangan, atau konfirmasi lain.
Keterangan: Catatan tambahan, misalnya apakah ada pihak yang belum menerima, atau metode distribusi yang memerlukan perbaikan.

8.5. Revisi dan Pembaharuan Dokumen

Revisi dan pembaharuan dokumen terkendali melalui proses formal. Revisi harus disetujui oleh otoritas yang kompeten sebelum dirilis. Pemberitahuan tentang revisi baru harus dikirimkan kepada semua pemegang dokumen, dan tindakan harus diambil untuk mengganti dokumen yang usang dengan versi yang diperbarui. Sementara untuk dokumen tidak terkendali maka revisi dokumen harus dikelola dengan ketat. Setiap revisi harus dicatat dengan jelas dan versi terbaru harus mudah diakses oleh pihak-pihak yang membutuhkannya.

- 1) Revisi atau pembaharuan dokumen dilakukan bila:
 - a. sudah tidak sesuai dengan kondisi kerja;
 - b. adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - c. adanya perubahan organisasi;
 - d. adanya kebijakan/regulasi baru; dan/atau
 - e. adanya perubahan fasilitas.
- 2) Seluruh pimpinan unit kerja dapat mengajukan usulan revisi sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Revisi tiap dokumen dilampiri dengan Formulir Amandemen Dokumen Regulasi (Lampiran II.g)
- 4) Dalam melakukan revisi dokumen, perlu memperhatikan dokumen-dokumen lain yang akan ikut terpengaruh oleh adanya revisi tersebut.
- 5) Dokumen lama berstatus “**CONTROLLED**” yang digantikan oleh dokumen yang direvisi, ditarik kembali oleh Sekretaris Tim -Regulasi untuk digantikan dengan yang baru. Semua dokumen berstatus “**CONTROLLED**” yang digantikan oleh dokumen yang direvisi, ditarik kembali oleh Sekretaris Tim Regulasi untuk digantikan dengan yang baru.
- 6) Dokumen asli yang kadaluwarsa harus diberi tanda (stempel) “**TIDAK BERLAKU**” pada setiap halaman dan disimpan sampai 3 (tiga) revisi terakhir. Sedangkan *file soft copy* nya dipindahkan ke folder **Expired**.
- 7) Jika ada penggantian Direktur atau pimpinan Rumah Sakit yang menandatangani dokumen, tidak wajib mengganti atau merevisi dokumen selama masih sesuai atau masih dipergunakan sebagai pedoman kerja.

8.6. Penyimpanan dan Keamanan Dokumen

Dokumen harus disimpan dalam sistem manajemen dokumen yang mendukung pencarian dan pengambilan yang cepat akurat serta keamanan tinggi untuk melindungi terhadap akses yang tidak sah dan kehilangan data.

- 1) Tata cara penyimpanan dokumen adalah bagaimana dokumen yang ada baik dokumen internal maupun eksternal RS BAKTI KARS disimpan dengan baik.

a. Dokumen terkendali

Dokumen terkendali harus disimpan dalam format yang aman dan dilindungi untuk mencegah perubahan tidak sah. Cadangan harus dibuat secara teratur dan disimpan di lokasi yang aman untuk mencegah kehilangan data.

b. Dokumen tidak terkendali

Dokumen yang sudah tidak berlaku harus diidentifikasi dengan jelas dan disimpan secara terpisah untuk mencegah penggunaan yang tidak disengaja, namun masih harus bisa diakses jika diperlukan untuk keperluan referensi atau legal.

- 2) Dokumen asli disimpan oleh Sekretaris Tim Regulasi.
- 3) Pengarsipan dokumen atau naskah asli harus rapi sesuai dengan metode pengarsipan agar mudah dicari bila diperlukan.
- 4) Salinan atau *fotocopy* dokumen disimpan di masing-masing unit kerja sesuai dengan isi dokumen atau di mana dokumen digunakan. Jika *fotocopy* dokumen sudah tidak dipergunakan lagi atau direvisi, maka:
 - a. Dokumen terkendali
Dokumen tersebut dikembalikan ke Sekretaris Tim Regulasi dan disimpan di Sekretariat sebelum kemudian dimusnahkan.
 - b. Dokumen tidak terkendali
Dokumen tersebut tidak perlu dikembalikan ke Sekretaris Tim Regulasi dan langsung bisa dimusnahkan oleh unit yang bersangkutan
- 5) Di unit kerja hanya ada dokumen yang masih berlaku. Dokumen yang sudah tidak dipergunakan dan harus dikembalikan adalah kebijakan, pedoman, panduan, dan SPO.
- 6) Dokumen asli tetap disimpan sesuai dengan ketentuan pengarsipan dokumen di Rumah Sakit.
- 7) Naskah Dinas yang digunakan sebagai pedoman di unit kerja harus diletakkan di tempat yang mudah dilihat, mudah diambil, dan mudah dibaca oleh pelaksana.

8.7. Pengendalian/Monitoring Dokumen

- 1) Pengendalian rutin dilakukan secara internal oleh jajaran jenjang struktural organisasi di RS BAKTI KARS dan jika diperlukan oleh SPI.
- 2) Dalam keadaan khusus Direktur dapat menugaskan SPI untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan regulasi tertentu berdasarkan surat tugas dari Direktur.
- 3) Hasil pelaksanaan monitoring regulasi dilaporkan kepada Direktur secara tertulis.
- 4) Semua dokumen berstatus “**CONTROLLED**” yang telah kadaluwarsa harus ditarik dari unit kerja dan harus dimusnahkan.
- 5) Bila salinan yang kadaluwarsa ingin disimpan untuk referensi, maka salinan tersebut diberi tanda (stempel) “**TIDAK BERLAKU**” pada setiap halaman yang kadaluwarsa. Haal ini dilakukan dalam rangka mencegah pemakaiannya secara sengaja atau tidak sengaja.

8.8.Pengendalian Dokumen Rahasia

Dokumen dikelompokkan menjadi rahasia atau tidak rahasia untuk menentukan tingkat akses yang diperbolehkan.

Tabel Pengendalian Dokumen Rahasia

No.	Aspek	Detail Kegiatan	Kebijakan atau Proses Terkait	Penanggung Jawab
1.	Klasifikasi Dokumen			
2.	Penentuan Akses			
3.	Pengamanan Fisik dan Digital			
4.	Audit dan Pelacakan			
5.	Pelatihan Kesadaran Keamanan			

6.	Penghancuran dan Disposisi			
----	----------------------------	--	--	--

Penjelasan Kolom Tabel

- **No.:** Nomor urut untuk masing-masing aspek yang diatur dalam pengendalian dokumen rahasia.
- **Aspek:** Area fokus atau kategori kegiatan yang terkait dengan pengendalian dokumen rahasia.
- **Detail Kegiatan:** Deskripsi spesifik dari kegiatan yang dilakukan untuk mengelola aspek tersebut.
- **Kebijakan atau Proses Terkait:** Dokumen atau kebijakan yang memberikan panduan dan standar untuk kegiatan tersebut.
- **Penanggung Jawab:** Individu atau departemen yang bertanggung jawab atas implementasi dan pemantauan kegiatan tersebut.

Tabel Akses Dokumen Rahasia dan Tidak Rahasia

No.	Nama Dokumen	Kategori Dokumen	Status Rahasia	Akses yang Diizinkan	Lokasi Penyimpanan
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Keterangan Kolom Tabel

- **No.:** Nomor urut dokumen.
- **Nama Dokumen:** Judul atau nama dokumen.
- **Kategori Dokumen:** Kategori atau jenis dokumen seperti kebijakan, laporan, manual, dll.
- **Status Rahasia:** Menunjukkan apakah dokumen tersebut diklasifikasikan sebagai rahasia atau tidak.
- **Akses yang Diizinkan:** Daftar individu atau grup yang memiliki akses ke dokumen.
- **Lokasi Penyimpanan:** Tempat fisik atau digital dimana dokumen disimpan.

8.9. Audit dan Evaluasi Dokumen

Sistem manajemen dokumen harus secara rutin diaudit untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi rumah sakit. Audit mencakup penilaian terhadap efektivitas praktik pengendalian dokumen yang ada.

1) Tahap 1: Perencanaan Audit

Menentukan Ruang Lingkup Audit: Tentukan area yang akan diaudit, fokus pada sistem pengendalian dokumen. Ini bisa termasuk proses pembuatan, penyimpanan, akses, revisi, dan penghapusan dokumen.

Penjadwalan Audit: Tentukan jadwal audit yang tidak mengganggu operasi normal tetapi cukup sering untuk memastikan kontrol yang efektif.

Penunjukan Tim Audit: Pilih tim auditor yang kompeten dan independen dari area yang diaudit. Tim ini harus memahami standar ISO dan kebijakan pengendalian dokumen internal.

2) Tahap 2: Pelaksanaan Audit

Pembukaan Rapat: Adakan pertemuan pembukaan dengan pihak-pihak terkait untuk menjelaskan tujuan dan proses audit.

Pemeriksaan Dokumen: Periksa dokumentasi sistem manajemen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar dan prosedur internal. Ini termasuk memeriksa keterkaitan antara dokumen, kebenaran, dan kebaruan.

Wawancara Staf: Wawancarai staf yang bertanggung jawab atas pengelolaan dokumen untuk memahami praktik kerja mereka.

Observasi Langsung: Lakukan observasi langsung terhadap proses pengelolaan dokumen untuk melihat implementasi kebijakan di lapangan.

Pengujian Sampel: Ambil sampel dokumen secara acak untuk memeriksa kepatuhan terhadap prosedur pengendalian dan pengarsipan.

3) Tahap 3: Laporan Audit

Penyusunan Temuan Audit: Kumpulkan semua data dan temuan audit, termasuk ketidaksesuaian, peluang perbaikan, dan poin kekuatan.

Penyusunan Laporan Audit: Buat laporan audit yang detail, mencakup metodologi, temuan, bukti, dan rekomendasi untuk perbaikan.

Presentasi Laporan: Sampaikan laporan kepada manajemen senior dan pihak-pihak terkait untuk ditinjau.

4) Tahap 4: Tindak Lanjut

Rencana Tindakan Perbaikan: Kembangkan rencana tindakan untuk mengatasi ketidaksesuaian yang diidentifikasi. Tentukan batas waktu dan alokasikan sumber daya yang diperlukan.

Implementasi Perbaikan: Lakukan perbaikan sesuai dengan rencana tindakan. Ini mungkin melibatkan revisi kebijakan, pelatihan ulang staf, atau peningkatan sistem IT.

Pemantauan dan Evaluasi: Monitor implementasi perbaikan dan evaluasi efektivitasnya. Lakukan audit tindak lanjut jika diperlukan.

Tabel Audit Kepatuhan Distribusi Regulasi

No	Regulasi	Tanggal Ditetapk an	Pihak yang Harus Menerima	Metode Distribus i	Tanggal Distribus i	Hasil	Keteranga n
1						☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2						☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3						☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
4						☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5						☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

Keterangan:

- **Regulasi:** Menunjukkan peraturan atau SOP yang harus didistribusikan.
- **Tanggal Ditetapkan:** Tanggal regulasi resmi disahkan.
- **Pihak yang Harus Menerima:** Departemen atau pihak-pihak yang wajib menerima informasi regulasi tersebut.
- **Metode Distribusi:** Cara atau metode yang digunakan untuk mendistribusikan regulasi (misalnya email, pelatihan, surat edaran).
- **Tanggal Distribusi:** Tanggal distribusi regulasi kepada pihak yang bersangkutan.
- **Hasil:** Penilaian apakah distribusi sudah dilakukan dengan benar (Sesuai/Tidak Sesuai).
- **Keterangan:** Ruang untuk catatan tambahan terkait pelaksanaan distribusi (misalnya konfirmasi penerimaan, pelatihan tambahan yang diperlukan).

Tabel Audit Untuk Kepatuhan Regulasi di Rumah Sakit

No	Area Audit	Standar/Regulasi	Kriteria Audit	Hasil	Keterangan
1				☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2				☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3				☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

4				☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5				☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

Keterangan tambahan:

- **Area Audit:** Menunjukkan area atau aspek yang diaudit dalam rumah sakit.
- **Standar/Regulasi:** Mencantumkan peraturan atau standar yang relevan yang harus dipatuhi.
- **Kriteria Audit:** Menyatakan apa yang harus diperiksa sesuai dengan regulasi yang berlaku.
- **Hasil:** Pilihan untuk menilai apakah rumah sakit sesuai atau tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
- **Keterangan:** Ruang untuk memberikan detail tambahan jika ada temuan atau catatan khusus terkait hasil audit.

Tabel Audit Kepatuhan Penyimpanan Dokumen Regulasi

N o	Dokumen Regulasi	Lokasi Penyimpanan	Metode Penyimpanan	Kriteria Penyimpanan	Hasil	Keterangan
1					☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
2					☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
3					☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
4					☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	
5					☐ Sesuai ☐ Tidak Sesuai	

Keterangan:

- **Dokumen Regulasi:** Jenis regulasi atau SOP yang disimpan.
- **Lokasi Penyimpanan:** Tempat fisik atau digital di mana dokumen disimpan (misalnya, ruang arsip, sistem intranet).
- **Metode Penyimpanan:** Bentuk penyimpanan dokumen (fisik, digital, atau kombinasi).
- **Kriteria Penyimpanan:** Standar yang harus dipenuhi dalam penyimpanan dokumen (seperti keamanan, backup, aksesibilitas).
- **Hasil:** Menyatakan apakah penyimpanan dokumen sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (Sesuai/Tidak Sesuai).
- **Keterangan:** Ruang untuk mencatat informasi tambahan seperti perbaikan yang diperlukan atau catatan kepatuhan lainnya.

8.10 Review Dokumen Regulasi

- Melakukan review terhadap dokumen regulasi adalah proses penting dalam setiap organisasi untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan prosedur tetap relevan, efektif, dan sesuai dengan perubahan peraturan, teknologi, dan keadaan pasar. Berikut adalah beberapa alasan mengapa review dokumen regulasi sangat penting:
- 1) Kepatuhan Regulasi: Peraturan dan hukum sering berubah, dan organisasi perlu memastikan bahwa mereka tetap mematuhi ketentuan yang berlaku. Review berkala memungkinkan organisasi untuk menyesuaikan dokumen-dokumen mereka dengan

perubahan-perubahan dalam peraturan dan undang-undang, sehingga menghindari risiko hukum dan sanksi finansial.

- 2) Mengadaptasi Perubahan: Organisasi perlu beradaptasi dengan perubahan dalam teknologi, pasar, dan praktik industri. Review memastikan bahwa dokumen regulasi mencerminkan praktik terbaik terkini dan mengakomodasi perkembangan baru.
- 3) Meningkatkan Efisiensi: Review membantu mengidentifikasi proses yang usang atau tidak efisien dalam kebijakan atau prosedur. Ini memberi kesempatan untuk memperbaiki atau mengoptimalkan proses, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional.
- 4) Risiko dan Manajemen Krisis: Review rutin dapat mengidentifikasi area di mana risiko belum sepenuhnya diatasi. Dengan melakukan perbaikan terhadap dokumen regulasi, organisasi dapat lebih baik dalam mengelola risiko dan responsif dalam situasi krisis.
- 5) Keseragaman dan Konsistensi: Memastikan bahwa semua departemen dan karyawan memahami dan mengikuti standar yang sama sangat penting untuk operasi organisasi yang harmonis. Review membantu memastikan bahwa semua dokumen regulasi konsisten dan diterapkan secara seragam di seluruh organisasi.
- 6) Umpan Balik dan Partisipasi Stakeholder: Review memberikan platform bagi stakeholder untuk memberikan masukan terhadap kebijakan dan prosedur. Hal ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan mereka tetapi juga memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut relevan dengan kebutuhan dan ekspektasi mereka.

Secara keseluruhan, review dokumen regulasi membantu memastikan bahwa organisasi tidak hanya tetap mematuhi tetapi juga tangguh, adaptif, dan efektif dalam menjalankan misi dan visinya dalam lingkungan yang dinamis dan sering berubah. Review/evaluasi dokumen regulasi dilakukan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi Dokumen yang Perlu Direview
 - a. Buat daftar semua dokumen regulasi yang ada, termasuk kebijakan, prosedur, manual, dan panduan.
 - b. Tentukan kriteria prioritas untuk review, seperti frekuensi penggunaan, perubahan dalam regulasi yang relevan, dan feedback dari pengguna.
- 2) Penetapan Tim Review
 - a. Bentuk tim yang terdiri dari staf yang memiliki keahlian dan keterlibatan langsung dengan materi regulasi tersebut. Idealnya, tim ini termasuk representasi dari departemen hukum, kepatuhan, operasi, dan IT.
 - b. Tugaskan seorang pemimpin tim yang akan bertanggung jawab atas koordinasi review dan pelaporan hasilnya.
- 3) Pengumpulan dan Analisis Informasi
 - a. Kumpulkan semua versi terdahulu dari dokumen dan informasi terkait lainnya.
 - b. Analisis perubahan dalam peraturan atau praktik industri yang dapat mempengaruhi isi dokumen.
 - c. Lakukan benchmark terhadap standar industri atau praktik terbaik untuk memastikan kesesuaian dokumen dengan standar terkini.
- 4) Pembaruan dan Revisi Dokumen
 - a. Revisi isi dokumen berdasarkan temuan dari analisis. Pastikan semua informasi terbaru dan akurat terkandung dalam dokumen.
 - b. Gunakan feedback dari pengguna untuk memperbaiki kejelasan, kegunaan, dan relevansi dokumen.
- 5) Validasi dan Persetujuan
 - a. Validasi draft revisi dengan pemangku kepentingan utama untuk mendapatkan persetujuan dan masukan tambahan.
 - b. Setelah semua persetujuan diperoleh, formalisasi perubahan dan siapkan dokumen akhir.
- 6) Diseminasi dan Implementasi

- a. Distribusikan dokumen yang telah direvisi kepada semua pihak terkait. Dokumen hasil telaah regulasi dikoordinasikan dengan Direktur bidang terkait.
 - b. Berikan pelatihan atau briefing jika isi dokumen yang direvisi mempengaruhi prosedur atau operasi sehari-hari.
- 7) Dokumentasi dan Arsip
- a. Simpan catatan tentang proses review, termasuk siapa yang terlibat, apa saja yang direview, dan ringkasan perubahan yang dibuat.
 - b. Perbarui sistem manajemen dokumen untuk mencerminkan versi terbaru dari dokumen.

Tabel Kegiatan Review Dokumen Regulasi

Tahap	Kegiatan	Penanggung Jawab	Detail Kegiatan	Jadwal / Frekuensi
Identifikasi Dokumen				
Penetapan Tim Review				
Pengumpulan dan Analisis Info				
Pembaruan dan Revisi Dokumen				
Diseminasi dan Implementasi				
Dokumentasi dan Arsip				
Waktu Pelaksanaan Review				

Tabel ini mencakup keseluruhan proses review dokumen regulasi dalam suatu organisasi, dari persiapan awal hingga implementasi perubahan dan pemeliharaan arsip. Ini memberikan panduan yang jelas tentang siapa yang bertanggung jawab atas apa, apa yang harus dilakukan, dan kapan tindakan tertentu harus diambil, memastikan bahwa proses review dilakukan secara terstruktur dan efektif.

Tabel Review Dokumen Regulasi

No.	Nama Dokumen	Kategori	Tanggal Review Terakhir	Jadwal Review Selanjutnya	Penanggung Jawab	Status	Catatan
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

Keterangan Kolom Tabel:

- **No.:** Nomor urut dokumen untuk kemudahan referensi.
- **Nama Dokumen:** Judul atau nama dokumen regulasi.
- **Kategori:** Klasifikasi dokumen berdasarkan fungsi atau departemen terkait.
- **Tanggal Review Terakhir:** Tanggal ketika dokumen terakhir kali direview.
- **Jadwal Review Selanjutnya:** Tanggal yang direncanakan untuk review berikutnya, bisa disesuaikan berdasarkan perubahan peraturan atau kebutuhan internal.
- **Penanggung Jawab:** Orang atau departemen yang bertanggung jawab atas review dokumen tersebut.
- **Status:** Status saat ini dari proses review (misalnya 'Selesai', 'Dijadwalkan', atau 'Dalam Proses').
- **Catatan:** Catatan tambahan mengenai update, perubahan yang dibutuhkan, atau masalah khusus yang perlu diatasi.

8.11. Waktu untuk Melaksanakan Review

- **Berdasarkan Jadwal:** Tetapkan jadwal review reguler, misalnya secara tahunan atau

- dua tahunan, tergantung pada volatilitas area regulasi yang relevan.
- **Saat Terjadi Perubahan Regulasi:** Segera setelah ada perubahan dalam peraturan atau undang-undang yang mempengaruhi dokumen tersebut.
- **Setelah Audit atau Inspeksi:** Jika ada temuan dari audit atau inspeksi yang menunjukkan kebutuhan untuk perubahan.
- **Pada Saat Terjadi Perubahan Signifikan dalam Operasi atau Bisnis:** Jika perubahan dalam operasi perusahaan atau kondisi pasar mempengaruhi relevansi atau keakuratan dokumen.
- **Berdasarkan Feedback:** Jika pengguna dokumen memberikan feedback yang menunjukkan masalah atau area untuk peningkatan.

Melakukan review dokumen regulasi secara terstruktur dan tepat waktu memastikan bahwa organisasi tidak hanya mematuhi peraturan yang berlaku tetapi juga menjalankan operasi sesuai dengan praktik terbaik industri.

Tabel Hasil Review Dokumen Regulasi

No.	Tahap	Dokumen yang Direview	Status Review	Temuan Utama	Tindak Lanjut	Jadwal Tindak Lanjut
1	Identifikasi Dokumen					
2	Penetapan Tim Review					
3	Pengumpulan dan Analisis					
4	Pengumpulan dan Analisis					
5	Pembaruan dan Revisi					
6	Validasi dan Persetujuan					
7	Diseminasi dan Implementasi					
8	Dokumentasi dan Arsip					
9	Waktu Pelaksanaan Review					

Keterangan Tabel

- **No.:** Nomor urut aktivitas atau dokumen yang direview.
- **Tahap:** Tahap dari proses review dokumen seperti yang didefinisikan dalam prosedur organisasi.
- **Dokumen yang Direview:** Nama dokumen atau kategori dokumen yang telah diperiksa.
- **Status Review:** Status saat ini dari proses review (contoh: Selesai, Memerlukan Revisi, Dalam Proses).
- **Temuan Utama:** Temuan penting dari proses review, termasuk kekurangan atau perubahan yang diperlukan.
- **Tindak Lanjut:** Tindakan yang perlu diambil berdasarkan hasil review.
- **Jadwal Tindak Lanjut:** Jadwal yang ditetapkan untuk melakukan tindak lanjut atau revisi berikutnya.

Tabel ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua informasi relevan terkait review dokumen regulasi terdokumentasi dengan baik dan mudah diakses untuk keperluan audit internal, kepatuhan, atau evaluasi lebih lanjut. Ini membantu memperkuat keamanan informasi dan kepatuhan organisasi terhadap regulasi yang berlaku.

Tabel Identifikasi Hasil Review Dokumen Regulasi

No.	Nama Dokumen	Kategori	Status Review	Catatan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

Keterangan Kolom Tabel

- **No.:** Nomor urut dokumen untuk kemudahan referensi.
- **Nama Dokumen:** Judul atau nama dokumen yang diidentifikasi.
- **Kategori:** Kategori atau jenis dokumen (misalnya, kebijakan, SOP, manual, laporan).
- **Status Review:** Menunjukkan status review untuk tahap identifikasi (contohnya "Selesai").
- **Catatan:** Ruang untuk catatan tambahan mengenai dokumen, misalnya kapan terakhir kali dokumen tersebut diperbarui atau diperiksa.

Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan terorganisir tentang dokumen-dokumen regulasi yang telah diidentifikasi dalam sebuah organisasi, sehingga memudahkan langkah berikutnya dalam proses review. Tabel ini sangat berguna dalam tahapan awal audit dokumen atau peninjauan kepatuhan untuk memastikan semua dokumen penting telah diperhitungkan.

Sesuai Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kearsipan penentuan retensi arsip didasarkan pada akumulasi retensi arsip aktif dan inaktif dengan 3 (tiga) pola:

- a. 2 (dua) tahun untuk nilai guna administrasi;
- b. 5 (lima) tahun untuk nilai guna hukum, informasi dan teknologi; dan
- c. 10 (sepuluh) tahun untuk nilai guna pertanggungjawaban catatan keuangan, bukti pembukuan dan data pendukung administrasi keuangan yang merupakan bagian dari bukti pembukuan.

8.12. Penghancuran Dokumen Regulasi

Penghancuran dokumen regulasi adalah proses penting dalam manajemen informasi dan kepatuhan perusahaan. Kegiatan ini melibatkan penghapusan fisik atau digital dokumen-dokumen yang telah mencapai akhir masa retensi mereka atau yang tidak lagi relevan untuk keperluan operasional atau kepatuhan. Proses ini harus dilakukan dengan cara yang aman untuk memastikan bahwa informasi sensitif tidak jatuh ke tangan yang salah atau disalahgunakan.

- 1) Pemusnahan dan daur ulang dokumen adalah tindakan pemusnahan dan daur ulang terhadap dokumen yang sudah dinyatakan tidak berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan masa simpan dan fungsi dokumen serta inventaris.
- 2) Dokumen yang sudah tidak berlaku dapat didaur ulang sehingga masih dapat berguna untuk fungsi yang lain.
- 3) Dalam hal dilakukan pemusnahan dan daur ulang dokumen, masing masing unit melakukan pengendalian dokumen dengan melakukan pengecekan secara rutin terhadap dokumen di unitnya.
- 4) Jika ada dokumen Dokumen Asli dan Salinan Terkendali yang sudah *expired* sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku, maka dilakukan penyerahan dokumen ke Tim Regulasi dengan bukti penarikan dokumen regulasi (lampiran II.f) untuk dilakukan pemusnahan serta dimuat dalam suatu Berita Acara Pemusnahan (Lampiran II.h).
- 5) Jika ada Dokumen Tidak Terkendali yang sudah *expired* sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku, maka

dilakukan pemusnahan atas persetujuan Kepala Bidang masing-masing serta dimuat dalam Berita Acara Pemusnahan (Lampiran II.h).

- 6) Daur ulang dokumen hanya dapat dilakukan jika dokumen tersebut memenuhi syarat alih fungsi atas persetujuan Direktur terkait serta megacu pada kebijakan Rumah Sakit.
- 7) Untuk pemusnahan dokumen di Unit Rekam Medis mengacu pada SPO Proses Retensi Berkas Rekam Medis yang berlaku. Metode penghancuran harus dipilih berdasarkan jenis dokumen dan tingkat keamanan yang dibutuhkan:
 - a. Shredding (Pemotongan): Cocok untuk dokumen kertas, shredding memastikan dokumen dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil yang tidak dapat dibaca atau direkonstruksi.
 - b. Pembakaran: Efektif untuk volume besar, memastikan dokumen dihancurkan sepenuhnya.
 - c. Degaussing (Penghilangan Medan Magnetis): Metode ini digunakan untuk menghapus data dari media penyimpanan magnetis, menghilangkan informasi yang tersimpan.
 - d. Pemusnahan Digital: Menggunakan perangkat lunak khusus untuk menghapus data secara permanen dari perangkat penyimpanan digital sehingga tidak dapat dipulihkan.

Proses penghancuran dokumen harus didokumentasikan dengan cermat melalui berita acara yang mencatat detail penting seperti tanggal penghancuran, metode yang digunakan, serta tanda tangan dan pernyataan dari saksi yang hadir. Protokol yang ketat dan dokumentasi yang tepat membantu memastikan bahwa penghancuran dilaksanakan secara bertanggung jawab dan bisa diverifikasi.

Melakukan penghancuran dokumen dengan cara yang sistematis dan terkontrol adalah kunci untuk menjaga keamanan informasi dan memastikan kepatuhan terhadap standar industri dan peraturan pemerintah. Sebagai bagian dari siklus hidup informasi, kegiatan ini harus dikelola dengan serius dan profesional untuk melindungi aset dan integritas organisasi.

Berikut adalah contoh tabel untuk pencatatan penghancuran dokumen regulasi dan contoh berita acara yang dapat digunakan sebagai dokumentasi formal dari proses tersebut:

Tabel Penghancuran Dokumen Regulasi

No.	Nama Dokumen	Kategori	Tanggal Penghancuran	Metode Penghancuran	Penanggung Jawab	Catatan
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						

BERITA ACARA PENGHANCURAN DOKUMEN REGULASI

Nomor:

Pada hari ini, [tanggal lengkap], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

Nama:
Jabatan:

telah melakukan penghancuran dokumen regulasi dengan rincian sebagai berikut:

- **Jenis Dokumen:**
- **Metode Penghancuran:**
- **Lokasi Penghancuran:** [Lokasi penghancuran, mis. kantor pusat di [Alamat]]
- **Alasan Penghancuran:**

Dokumen-dokumen tersebut telah dihancurkan sesuai dengan kebijakan penghancuran dokumen perusahaan untuk mencegah kebocoran informasi sensitif dan mematuhi regulasi yang berlaku. Tindakan ini telah dilakukan dengan mengikuti semua prosedur yang ditetapkan dan disaksikan oleh semua pihak yang bertanggung jawab.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai bukti yang sah.

Tanda Tangan dan Stempel Perusahaan:

[Tempat tanda tangan]

[Stempel Perusahaan]

Tabel dan berita acara ini membantu dalam dokumentasi resmi yang mengatur tentang bagaimana dokumen-dokumen regulasi yang sensitif dan penting dihancurkan sesuai dengan kebijakan keamanan dan regulasi yang berlaku.

Tanggal: [Tanggal Penghancuran]

Bagian	Deskripsi
Pendahuluan	Berita acara ini dibuat untuk mendokumentasikan penghancuran dokumen regulasi yang telah mencapai akhir masa retensi atau tidak lagi relevan, sesuai dengan kebijakan pengelolaan dokumen perusahaan.
Identitas	Penyelenggara: [Nama Organisasi] Penanggung Jawab: [Nama, Jabatan]
Detail Penghancuran	Tanggal Penghancuran: [Tanggal] Lokasi: [Alamat Lokasi Penghancuran]
Daftar Dokumen	[Tabel detail dokumen yang dihancurkan]
Saksi	[Nama dan Jabatan Saksi]
Tanda Tangan	[Ruang untuk tanda tangan yang terlibat]

Tabel Detail Dokumen yang Dihancurkan

No.	Nama Dokumen	Kategori	Metode Penghancuran	Catatan
1.				
2.				
3.				

BAB IX

DOKUMENTASI

Dokumentasi Dokumen Regulasi dicatat di lembar sebagai berikut:

1. Lembar Daftar Dokumen Regulasi Internal
Digunakan untuk mencatat semua dokumen regulasi asli yang diterbitkan RS BAKTI KARS.
2. Lembar Daftar Dokumen Regulasi Eksternal
Digunakan untuk mencatat dokumen regulasi eksternal yang digunakan sebagai acuan di RS BAKTI KARS.
3. Lembar Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Dokumen Regulasi
Digunakan untuk mencatat hasil monitoring dan evaluasi semua dokumen regulasi dan pelaksanaannya di masing-masing unit kerja.
4. Lembar Daftar Usulan Distribusi Dokumen Regulasi
Digunakan untuk mencatat usulan dari unit kerja pembuat dokumen regulasi ke Sekretaris Tim Regulasi tentang unit kerja yang akan diberi salinan dokumen regulasi yang akan diterbitkan.
5. Bukti Serah Terima Salinan Dokumen Regulasi
Digunakan sebagai bukti catatan serah terima dokumen regulasi ke unit kerja sebagai bukti penerimaan salinan dokumen.
6. Bukti Penarikan Dokumen Regulasi
Digunakan sebagai bukti catatan atau daftar dokumen yang ditarik dari unit kerja.
7. Formulir Amandemen Dokumen Regulasi
Formulir yang digunakan untuk mencatat usulan atau masukan untuk perbaikan dokumen regulasi yang sudah tidak sesuai dengan kondisi kerja atau sudah kedaluwarsa.
8. Berita Acara Pemusnahan Dokumen Regulasi
Adalah catatan sebagai bukti pelaksanaan pemusnahan dokumen regulasi.
9. Daftar Dokumen Regulasi Yang Dimusnahkan

BAB X PENUTUP

Pedoman tata naskah Rumah Sakit Prima Husada dijadikan acuan dalam penyelenggaraan komunikasi dan sistem pengelolaan arsip sebagai pendukung penyelenggaraan administrasi dilingkungan Rumah Sakit Prima Husada. Dengan adanya manajemen arsip yang baik dan benar, maka bukti kinerja kesekretariatan dalam mengimplementasikan tata naskah yang baik dapat dipelihara dan dipertanggungjawabkan.

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 20 September 2025
Direktur PT Disa Prima Medika



dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE